

FISIOLOGI DAN PSIKOLOGI PERSALINAN

Ernita Prima Noviyani, S.ST.,Bdn.,M.Kes
Nur Anita, S.ST, M.Kes
Idah Ayu Wulandari, S.Si.T.,M.Keb
Bdn. Pipih Salanti, S.ST.,MKM
Diani Magasida, S.Si.T.,M.Keb
Rina Octavia, S.ST,. Bdn., M.Kes
Fatmawati, S.ST.,M.Keb
Bd. Mariza Mustika Dewi, S.Tr.Keb.,M.Tr.Keb
Yuli Astuti, S.ST.,M.Keb
Ika Lustiani, S.ST.,M.Kes



FISIOLOGI DAN PSIKOLOGI PERSALINAN

ERNITA PRIMA NOVIYANI, S.ST.,Bdn.,M.Kes

NUR ANITA, S.ST, M.Kes

IDAH AYU WULANDARI, S.Si.T.,M.Keb

BDN. PIPIH SALANTI, S.ST.,MKM

DIANI MAGASIDA, S.Si.T.,M.Keb

RINA OCTAVIA, S.ST,. M.Kes

FATMAWATI, S.ST.,M.Keb

Bd. MARIZA MUSTIKA DEWI, S.Tr.Keb.,M.Tr.Keb

YULI ASTUTI, S.ST.,M.Keb

IKA LUSTIANI, S.ST.,M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

FISIOLOGI DAN PSIKOLOGI PERSALINAN

Penulis:

Ernita Prima Noviyani, S.ST.,Bdn.,M.Kes

Nur Anita, S.ST, M.Kes

Idah Ayu Wulandari, S.Si.T.,M.Keb

Bdn. Pipih Salanti, S.ST.,MKM

Diani Magasida, S.Si.T.,M.Keb

Rina Octavia, S.ST., Bd., M.Kes

Fatmawati, S.ST.,M.Keb

Bd. Mariza Mustika Dewi, S.Tr.Keb.,M.Tr.Keb

Yuli Astuti, S.ST.,M.Keb

Ika Lustiani, S.ST.,M.Kes

Desain Cover:

Ivan Zumarano

Tata Letak:

Siti Hartina Fatimah

ISBN:

978-623-88659-4-9

Cetakan Pertama:

April, 2023

Hak Cipta 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website: www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal

PRAKATA

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayahnya sehingga dapat diselesaikannya Buku Asuhan Kebidanan Fisiologi dan Psikologi Persalinan. Buku ini disusun berdasarkan berbagai hasil penelitian, referensi buku serta modul kebidanan khususnya terkait fisiologi dan psikologi persalinan.

Kelahiran merupakan salah satu proses yang akan dilalui oleh manusia sepanjang daur kehidupannya. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) banyak terjadi difase ini, baik itu disebabkan oleh perdarahan, infeksi, pre eklampsia ataupun faktor-faktor lain. Pemenuhan kebutuhan psikologis pada ibu bersalin juga harus diperhatikan dengan baik oleh bidan, karena keadaan psikologis ibu bersalin sangat berpengaruh pada proses dan hasil akhir persalinan. Sangat penting kita mengetahui dengan jelas tentang konsep dasar persalinan, kebutuhan dasar ibu bersalin, asuhan persalinan normal, lima benang merah serta faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan baik secara fisiologi maupun psikologi, karena hal tersebut akan menjadi pondasi atau dasar bagi seorang bidan atau petugas kesehatan dalam memberikan asuhan persalinan, sehingga seorang bidan diharapkan akan mampu memberikan asuhan secara maksimal sesuai dengan konsep asuhan persalinan.

Semoga buku ini dapat bermanfaat serta memberikan inspirasi untuk pembaca dalam memberikan asuhan kebidanan dengan memperhatikan kebutuhan fisiologi dan psikologi pada ibu bersalin. Selamat membaca.

Jakarta, Agustus 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 KONSEP DASAR PERSALINAN	1
<i>Nur Anita, S.ST.,M.Kes</i>	
BAB 2 LIMA BENANG MERAH PERSALINAN	11
<i>Idah Ayu Wulandari, S.Si.T.,M.Keb</i>	
BAB 3 KEBUTUHAN DASAR SELAMA PERSALINAN	27
<i>Bdn. Pipih Salanti, S.ST.,MKM</i>	
BAB 4 PSIKOLOGI MASA PERSALINAN	37
<i>Ernita Prima Noviyani, S.ST.,Bdn.,M.Kes</i>	
BAB 5 PEMERIKSAAN FISIK PADA IBU BERSALIN	53
<i>Diani Magasida, S.Si.T.,M.Keb</i>	
BAB 6 LANGKAH – LANGKAH PERSALINAN	65
<i>Rina Octavia, S.ST.,. Bd., M.Kes</i>	
BAB 7 TAHAPAN PERSALINAN	83
<i>Fatmawati, S.ST.,M.Keb</i>	
BAB 8 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSALINAN	97
<i>Bd. Mariza Mustika Dewi, S.Tr.Keb.,M.Tr.Keb</i>	
BAB 9 MEKANISME PERSALINAN	107
<i>Yuli Astuti, S.ST.,M.Keb</i>	
BAB 10 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN RUPTURE PERINEUM	117
<i>Ika Lustiani, S.ST.,M.Kes</i>	

BAB 1

KONSEP DASAR PERSALINAN

Nur Anita, S.ST.,M.Kes



BAB 1

KONSEP DASAR PERSALINAN

Nur Anita, S.ST., M.Kes

A. Pendahuluan

Kelahiran merupakan salah satu proses yang akan dilalui oleh manusia sepanjang daur kehidupannya. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) banyak terjadi difase ini, baik itu disebabkan oleh perdarahan, infeksi, pre eklampsia ataupun faktor-faktor lain. Sangat penting kita mengetahui dengan jelas tentang konsep dasar persalinan. Karena hal tersebut akan menjadi pondasi atau dasar bagi seorang bidan atau petugas kesehatan dalam memberikan asuhan persalinan. Dengan memahami secara seksama tentang konsep dasar persalinan maka seorang bidan diharapkan akan mampu memberikan asuhan secara maksimal sesuai dengan konsep asuhan persalinan. (Anita, 2022).

Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisiologi yang normal dalam kehidupan, fokus asuhan persalinan normal adalah persalinan bersih dan aman serta mencegah terjadinya komplikasi. AKI dan AKB dapat dicegah salah satunya dengan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari para penolong persalinan atau tenaga kesehatan. Jika semua tenaga kesehatan khususnya bidan dilatih agar dapat menerapkan asuhan persalinan secara tepat guna, tepat waktu, baik sebelum atau saat masalah terjadi dan segera melakukan rujukan diwaktu yang tepat. Maka para ibu dan bayi lahir akan terhindar dari ancaman kesakitan dan kematian. (Yulizawati dkk, 2019).

B. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian persalinan
2. Untuk Mengetahui Tujuan asuhan persalinan
3. Untuk mengetahui Jenis-jenis persalinan
4. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya persalinan

C. Pembahasan

1. Pengertian Persalinan

- a) Persalinan adalah Serangkaian kejadian pengeluaran bayi yang sudah cukup bulan disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir atau jalan lain berlangsung dengan bantuan atau tanpa bantuan (Kurniarum A, 2016).
- b) Persalinan adalah rangkaian peristiwa keluarnya bayi yang sudah cukup berada dalam rahim ibunya dengan disusul oleh keluarnya plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu (Fitriana Y, 2018).

- c) Persalinan adalah suatu proses dimana seorang wanita melahirkan bayi persalinan yang diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai dengan pengeluaran plasenta dan selaputnya dimana proses ini akan berlangsung selama 12 sampai 14 jam (Mayles, 1996).
- d) Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun kedalam jalan lahir.
- e) Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun kejalan lahir yang terjadi secara spontan atau dengan bantuan (Dewi A, 2012)
- f) Proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, lahir spontan, dengan presentasi belakang kepala tanpa komplikasi baik ibu maupun janin (Sukarni & Margareth, 2019)
- g) Persalinan adalah suatu proses fisiologis yang memungkinkan serangkaian perubahan yang besar pada ibu untuk dapat melahirkan janinnya melaui jalan lahir (Moore,2001).
- h) Persalinan adalah suatu proses dimana seorang wanita melahirkan bayi yang diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai dengan pengeluaran plasenta dan selaputnya dimana proses persalinan ini akan berlangsung selama 12 sampai 14 jam (Mayles, 1996).
- i) Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37–42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin (Prawirohardjo, 2002).
- j) Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri). Proses ini dimulai dengan adanya kontraksi persalinan sejati, yang ditandai dengan perubahan serviks secara progresif dan diakhiri dengan kelahiran plasenta (Sulistyawati, 2013)

2. Tujuan Asuhan Persalinan

Tujuan asuhan persalinan Adalah mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya melalui berbagai upaya yang terintegrasi dan lengkap serta intervensi minimal dengan asuhan kebidanan persalinan yang adekuat sesuai dengan tahapan persalinan sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang optimal. (Ari Kurniarum, S.SiT., 2016)

Tujuan Asuhan persalinan menurut Fitriana Y dan Nurwiandani (2018) yaitu:

- a) Memberikan dukungan baik secara fisik maupun emosional kepada ibu dan keluarganya selama persalinan dan kelahiran
- b) Melakukan pengkajian, membuat diagnosa, mencegah, menangani komplikasi-komplikasi dengan cara pemantauan ketat dan deteksi dini selama persalinan dan kelahiran
- c) Melakukan rujukan pada kasus-kasus yang tidak bisa ditangani sendiri untuk mendapatkan asuhan spesialis jika perlu.
- d) Memberikan asuhan yang adekuat kepada ibu dengan intervensi minimal sesuai dengan tahap persalinannya.
- e) Memperkecil resiko infeksi dengan melaksanakan pencegahan infeksi yang aman.
- f) Selalu memberitahukan kepada ibu dan keluarganya mengenai kemajuan, adanya penyulit maupun intervensi yang akan dilakukan dalam persalinan.
- g) Memberikan asuhan yang tepat untuk bayi segera setelah lahir.
- h) Membantu ibu dengan pemberian ASI dini.

3. Jenis-Jenis Persalinan

a) Persalinan Spontan

Persalinan spontan adalah persalinan yang berlangsung dengan adanya kekuatan ibu melalui jalan lahirnya.

Persalinan Normal (Spontan) Adalah proses lahirnya bayi pada LetakBelakang Kepala (LBK) dengan tenaga ibu sendiri, tanpa bantuanalat-alat serta tidak melukai ibu dan bayi yang umumnya berlangsung kurangdari 24 jam (Asrinah dkk, 2010).

b) Persalinan Buatan

Persalinan buatan adalah proses persalinan yang dibantu dengan tenaga dari luar atau selainn dari ibu yang akan melahirkan. Misalnya *ekstraksi forcep* atau *sectio caesarea*.

c) Persalinan Anjuran

Persalinan anjuran adalah proses persalinan yang tidak dimulai dengan proses persalinan seperti biasanya, akan tetapi baru berlangsung setelah pemecahan ketuban, pemberian pitocin, atau prostaglandin.

Jenis persalinan berdasarkan usia kehamilan :

1) Abortus

Pengeluaran buah kehamilan sebelum kehamilan 22 minggu atau bayi dengan berat badan kurang dari 500 gram.

2) Partus immaturus

Pengeluaran buah kehamilan antara 22 minggu dan 28 minggu atau bayi dengan berat badan antara 500 gram dan 999 gram.

- 3) Partus prematurus
Pengeluaran buah kehamilan antara 28 minggu dan 37 minggu atau bayi dengan berat badan antara 1000 gram dan 2499 gram.
- 4) Partus maturus atau aterm
Pengeluaran buah kehamilan antara 37 minggu dan 42 minggu atau bayi dengan berat badan 2500 gram atau lebih.
- 5) Partus postmaturus atau serotinus
Pengeluaran buah kehamilan setelah kehamilan 42 minggu.

4. Sebab-Sebab Terjadinya Persalinan

Selama kehamilan, didalam tubuh perempuan terdapat dua hormon yang dominan yaitu esterogen dan progesteron. Hormon esterogen berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas otot rahim serta memudahkan penerimaan rangsangan dari luar seperti rangsangan oksitosin, prostaglandin, dan mekanis. Sedangkan, hormon progesteron berfungsi untuk menurunkan sensitivitas otot rahim, menghambat rangsangan dari luar seperti rangsangan oksitosin, prostaglandin dan mekanis serta menyebabkan otot rahim dan otot polos relaksasi (Sulistyawati, dkk, 2013). Sampai saat ini hal yang menyebabkan mulainya proses persalinan belum diketahui sehingga hanya ada teori-teori antara lain:

a) Terjadinya penurunan kadar progesterone

Selama kehamilan, kadar estrogen dan progesteron dalam darah seimbang sehingga kehamilan dapat terjaga dan tidak menyebabkan bayi lahir sebelum waktunya. Namun, pada waktunya, kadar progesteron akan menurun sehingga otot-otot rahim tidak mengalami relaksasi dan cenderung meregang. Hal inilah yang menandakan awal terjadinya proses persalinan.

b) Teori Oxytocin

Diakhir masa kehamilan, produksi kadar oxytocin dalam darah akan meningkat sehingga akan menimbulkan kontraksi otot-otot rahim yang merupakan tanda-tanda dimulainya proses persalinan.

c) Ketegangan otot-otor

Dengan bertambahnya ukuran janin dalam perut maka akan membuat otot-otot rahim semakin teregang maka akan menimbulkan kontraksi untuk mengeluarkan isi dari rahim tersebut.

d) Teori Janin

Terdapat hubungan hipofisis dan kelenjar suprarenal yang menghasilkan sinyal kemudian diarahkan kepada maternal sebagai tanda bahwa janin siap dilahirkan.

e) Teori berkurangnya Nutrisi

Teori berkurangnya nutrisi pada janin diungkapkan oleh Hippocrates untuk pertama kalinya. Hasil konsepsi akan segera dikeluarkan bila nutrisi telah berkurang.

f) Teori plasenta menjadi tua

Plasenta yang semakin tua seiring dengan bertambahnya usia kehamilannya akan menyebabkan turunnya kadar estrogen dan progesteron sehingga timbul kontraksi rahim.

g) Teori Prostaglandin

Prostaglandin yang dihasilkan oleh desidua, diduga menjadi salah satu sebab permulaan persalinan. Hasil dari percobaan menunjukkan bahwa prostaglandin F2 atau E2 yang diberikan secara intravena dan extra amnial menimbulkan kontraksi miometrium pada setiap umur kehamilan.

5. Tanda dan Gejala Persalinan

a) Tanda-tanda bahwa persalinan sudah dekat

1) Lightening

Beberapa minggu sebelum persalinan, calon ibu merasa bahwa keadaannya menjadi lebih enteng. Ia merasa kurang sesak, tetapi sebaliknya ia merasa bahwa berjalan sedikit lebih sukar, dan sering diganggu oleh perasaan nyeri pada anggota bawah.

2) Pollakisuria

Pada akhir bulan ke-IX hasil pemeriksaan didapatkan epigastrium kendur, fundus uteri lebih rendah dari pada kedudukannya dan kepala janin sudah mulai masuk ke dalam pintu atas panggul. Keadaan ini menyebabkan kandung kencing tertekan sehingga merangsang ibu untuk sering kencing yang disebut Pollakisuria.

3) False Labour

Tiga (3) atau empat (4) minggu sebelum persalinan, calon ibu diganggu oleh his pendahuluan yang sebetulnya hanya merupakan peningkatan dari kontraksi Braxton Hicks. His pendahuluan ini bersifat:

- Nyeri yang hanya terasa di perut bagian bawah
- Tidak teratur
- Lamanya his pendek, tidak bertambah kuat dengan majunya waktu dan bila dibawa jalan malah sering berkurang
- Tidak ada pengaruh pada pendataran atau pembukaan cervix.

4) Perubahan cervix

Pada akhir bulan ke-IX hasil pemeriksaan cervix menunjukkan bahwa cervix yang tadinya tertutup, panjang dan kurang lunak, kemudian menjadi lebih

lembut, dan beberapa menunjukkan telah terjadi pembukaan dan penipisan. Perubahan ini berbeda untuk masing-masing ibu, misalnya pada multipara sudah terjadi pembukaan 2 cm namun pada primipara sebagian besar masih dalam keadaan tertutup.

5) Energy Sport

Beberapa ibu akan mengalami peningkatan energi kira-kira 24-28 jam sebelum persalinan mulai. Setelah beberapa hari sebelumnya merasa kelelahan fisik karena tuanya kehamilan maka ibu mendapati satu hari sebelum persalinan dengan energi yang penuh. Peningkatan energi ibu ini tampak dari aktifitas yang dilakukannya seperti membersihkan rumah, mengepel, mencuci perabot rumah, dan pekerjaan rumah lainnya sehingga ibu akan kehabisan tenaga menjelang kelahiran bayi, sehingga persalinan menjadi panjang dan sulit.

6) Gastrointestinal Upsets

Beberapa ibu mungkin akan mengalami tanda-tanda seperti diare, obstipasi, mual dan muntah karena efek penurunan hormon terhadap sistem pencernaan

b) Tanda-tanda persalinan

Yang merupakan tanda pasti dari persalinan adalah:

1) Timbulnya kontraksi uterus Biasa juga disebut dengan his persalinan yaitu his pembukaan yang mempunyai sifat sebagai berikut:

- Nyeri melingkar dari punggung memancar ke perut bagian depan.
- Pinggang terasa sakit dan menjalar kedepan.
- Sifatnya teratur, interval makin lama makin pendek dan kekuatannya makin besar.
- Mempunyai pengaruh pada pendataran dan atau pembukaan serviks.
- Makin beraktifitas ibu akan menambah kekuatan kontraksi. Kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan pada serviks (frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit). Kontraksi yang terjadi dapat menyebabkan pendataran, penipisan dan pembukaan serviks.

2) Penipisan dan pembukaan serviks Penipisan dan pembukaan serviks ditandai dengan adanya pengeluaran lendir dan darah sebagai tanda pemula.

3) Bloody Show (lendir disertai darah dari jalan lahir) Dengan pendataran dan pembukaan, lendir dari canalis cervicalis keluar disertai dengan sedikit darah. Perdarahan yang sedikit ini disebabkan karena lepasnya selaput

janin pada bagian bawah segmen bawah rahim hingga beberapa capillair darah terputus.

4) Premature Rupture of Membrane

Adalah keluarnya cairan banyak secara mendadak dari jalan lahir. Hal ini terjadi akibat ketuban pecah atau selaput janin robek. Ketuban biasanya pecah kalau pembukaan lengkap atau hampir lengkap dan dalam hal ini keluarnya cairan merupakan tanda yang lambat sekali. Tetapi kadang-kadang ketuban pecah pada pembukaan kecil, malahan kadang-kadang selaput janin robek sebelum persalinan. Walaupun demikian persalinan diharapkan akan mulai dalam 24 jam setelah air ketuban keluar

5) Prinsip Asuhan Persalinan

- Rawat ibu dengan penuh hormat
- Mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan ibu. Hormati pengetahuan dan pemahaman mengenai tubuhnya. Ingat bahwa mendengar sama pentingnya dengan memberikan nasihat.
- Menghargai hak-hak ibu dan memberikan asuhan yang bermutu serta sopan
- Memberikan asuhan dengan memperhatikan privasi
- Selalu menjelaskan apa yang akan dikerjakan sebelum anda melakukannya serta meminta izin terlebih dahulu.
- Selalu mendiskusikan temuan-temuan kepada ibu serta kepada siapa saja yang ia inginkan untuk berbagi informasi.
- Selalu mendiskusikan rencana dan intervensi serta pilihan yang sesuai dan tersedia bersama ibu
- Mengizinkan ibu untuk memilih siapa yang akan menemaninya selama persalinan.
- Mengizinkan ibu untuk memilih posisi apa saja yang diinginkan selama proses persalinan dan kelahiran.
- Menghindari penggunaan suatu tindakan medis yang tidak perlu (episiotomi, pencukuran dan enema).
- Memfasilitasi hubungan dini antara ibu dan bayi baru lahir.

D. Kesimpulan

1. Persalinan adalah proses atau rangkaian pengeluaran hasil konsepsi yaitu bayi kemudian disusul oleh plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir atau jalan lain tanpa ataupun dengan bantuan.
2. Tujuan Asuhan Persalinan yaitu memberikan asuhan yang tepat pada ibu bersalin dan sesuai dengan apa yang ibu butuhkan agar dapat kesehatan dan keselamatan ibu maupun janin dapat terjaga.
3. Jenis-jenis persalinan yaitu persalinan spontan, persalinan buatan dan persalinan anjuran. Sedangkan jenis persalinan berdasarkan usia kehamilan antara lain, abortus, immaturs, partus prematurs, partus maturs, dan partus post maturs.
4. Sebab-sebab terjadinya persalinan antara lain karena terjadinya penurunan kadar estrogen dan progesteron, meningkatnya kadar oxytocin, peregangan otot-otot rahim, faktor janin dan plasenta, berkurangnya nutrisi dan teori prostaglandin.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriza dkk. (2020). *Konsep Dasar Keperawatan Maternitas*. Yayasan kita menulis
- Fitriana Y & Nurwiandani W. (2018). *Asuhan persalinan, Konsep persalinan secara kompherensif dalam asuhan kebidanan*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Hindratni F dkk. (2022). *Pengantar Ilmu Kebidanan dan Etikolegal dalam Praktik Kebidanan*. Bandung. Media Sains Indonesia.
- Kurniarum A. (2016). *Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir*. Bandung. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Oxorn H & William R. (2010). *Ilmu Kebidanan, Patologi dan Fisiologi dalam persalinan*. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Sulfianti dkk. (2020). *Asuhan Kebidanan pada persalinan*. Surakarta. Yayasan kita menulis
- Yulizawati dkk. (2019). *Buku ajar asuhan kebidanan pada persalinan*. Sidoarjo. Indomedia Pustaka

BAB 2

LIMA BENANG MERAH PERSALINAN

Idah Ayu Wulandari, S.Si.T., M. Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 2.

LIMA BENANG MERAH PERSALINAN

Idah Ayu Wulandari, S.Si.T., M. Keb

A. Pendahuluan

Berdasarkan hasil estimasi, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 271.066.366 jiwa yang terdiri atas 136.142.501 jiwa penduduk laki-laki dan 134.923.865 jiwa penduduk perempuan. Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian ibu dalam indikator ini didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah semua kematian dalam ruang lingkup tersebut di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas (Hardhana et al., 2021)

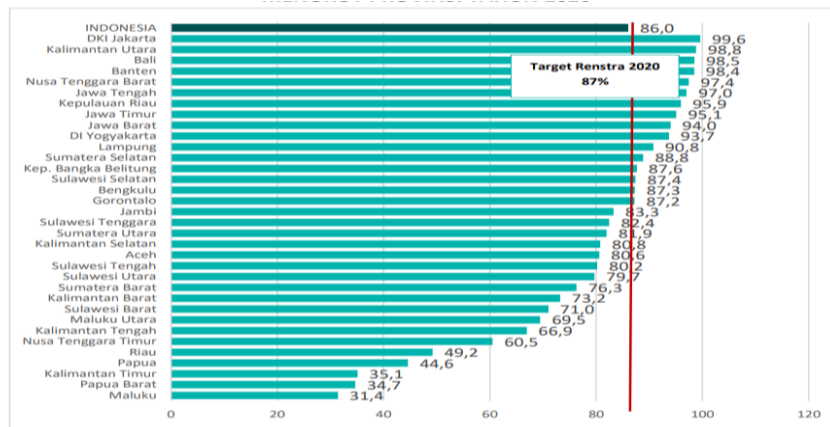
Berdasarkan penyebab, sebagian besar kematian ibu pada tahun 2020 disebabkan oleh perdarahan sebanyak 1.330 kasus, hipertensi dalam kehamilan sebanyak 1.110 kasus, dan gangguan sistem peredaran darah sebanyak 230 kasus (Hardhana et al., 2021)

Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan.

Upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Hardhana et al., 2021).

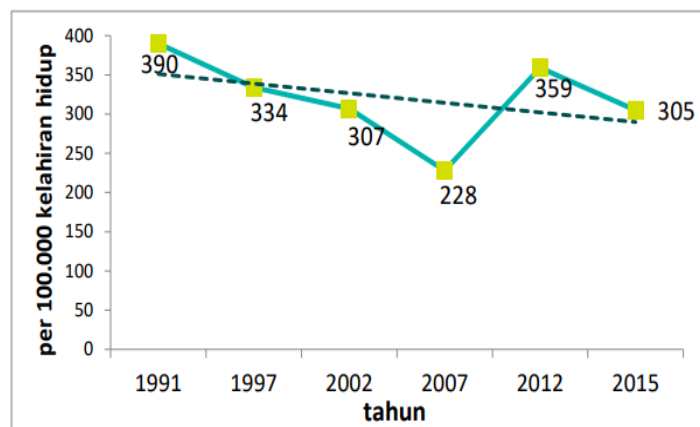
Dalam rangka menjamin ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sejak tahun 2015 setiap ibu bersalin diharapkan melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas pelayanan kesehatan (Simanullang & Diosi, 2019). Oleh sebab itu, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 menetapkan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai salah satu indikator upaya

kesehatan keluarga, menggantikan indikator pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Hardhana et al., 2021).



Gambar 2.1 Cakupan Persalihan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Provinsi tahun 2020

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021



Gambar 2.2 Angka Kematian Ibu Di Indonesia Per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 1991 – 2015

Sumber: BPS, SDKI 19191-2012 (*AKI tahun 2015 merupakan hasil SUPAS 2015)

Upaya pencegahan AKI khususnya pada proses persalinan adalah dengan pelaksanaan asuhan persalinan normal (APN). Pada APN, terdapat lima aspek dasar atau lima benang merah yang penting dan saling terkait dalam asuhan persalinan yang diberikan (JNPK-KR, 2017).

B. Tujuan

Pada bab ini membahas materi tentang lima benang merah dalam asuhan persalinan normal yang meliputi membuat keputusan klinik, asuhan sayang ibu dan sayang bayi, pencegahan infeksi, pencatatan (rekam medik) asuhan persalinan dan rujukan dengan melakukan pendekatan manajemen kebidanan untuk mempertahankan kualitas dan mutu layanan asuhan kebidanan.

C. Pembahasan

Asuhan persalinan normal terdapat lima aspek dasar atau lima benang merah yang penting dan saling terkait dalam asuhan persalinan yang bersih dan aman. Berbagai aspek tersebut melekat pada setiap persalinan, baik normal dan patalogis sehingga pada asuhan persalinan normal seorang bidan dapat diketahui perubahan perilakunya melakukan asuhan persalinan normal dilihat dari perilakunya dalam menerapkan lima benang merah. Lima benang merah tersebut meliputi membuat keputusan klinik, asuhan sayang ibu dan sayang bayi, pencegahan infeksi, pencatatan (rekam medik) asuhan persalinan dan rujukan. Lima benang merah dilaksanakan dalam asuhan persalinan dari awal sampai penanganan bayi baru lahir. Pada bab ini akan dibahas secara detail mengenai kelima benang merah tersebut (JNPK-KR, 2017).

1. Membuat keputusan klinik

Membuat keputusan merupakan proses yang menentukan untuk menyelesaikan masalah dan menentukan asuhan yang diperlukan oleh pasien. Keputusan itu harus akurat, komprehensif dan aman, baik bagi pasien dan keluarganya maupun petugas yang memberikan pertolongan (King et al., 2015)

Membuat keputusan merupakan suatu proses yang menentukan dalam melakukan suatu penyelesaian masalah dan asuhan yang diperlukan oleh pasien. Keputusan yang diambil hendaknya bersifat akurat, komprehensif bagi pasien, keluarga dan petugas kesehatan serta aman untuk dilaksanakan (Marshall & Raynor, 2020).

Keputusan klinik dihasilkan melalui serangkaian proses dan metode yang sistematis menggunakan informasi dan hasil dari olah kognitif dan intuitif serta dipadukan dengan kajian teoritis dan internesi berdasarkan bukti (evidence based), keterampilan dan pengalaman yang dikembangkan melalui berbagai tahap yang logis dan diperlukan dalam upaya untuk menyelesaikan masalah dan terfokus pada pasien. Beberapa hal yang diperlukan agar tercipta asuhan yang maksimal dan memenuhi standar kualitas pelayanan yang diharapkan semua pihak antara lain adalah pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang terpuji (Kartikasari et al., 2022).

Dalam membuat keputusan klinik, terdapat 7 langkah yang berurutan yaitu:

- a. Pengumpulan data
- b. Interpretasi data untuk mendukung diagnosis dan identifikasi masalah
- c. Menetapkan diagnosis kerja atau merumuskan masalah
- d. Menilai adanya kebutuhan dan kesiapan intervensi untuk menghadapi masalah
- e. Menyusun rencana asuhan(intervensi)
- f. Melaksanakan asuhan (implementasi)
- g. Memantau atau mengevaluasi efektifitas asuhan atau intervensi

2. Asuhan sayang ibu dan sayang bayi

Asuhan sayang ibu merupakan program yang direncanakan pemerintah untuk mengurangi tingginya angka kematian dan kesakitan para ibu yang diakibatkan oleh komplikasi kehamilan dan kelahiran. Asuhan sayang ibu dalam proses persalinan meliputi (JNPK-KR, 2017):

- a. Panggil ibu sesuai dengan namanya, hargai dan perlakukan ibu sesuai martabatnya
- b. Jelaskan semua asuhan dan perawatan kepada ibu sebelum memulai asuhan
- c. Jelaskan proses persalinan
- d. Anjurkan ibu untuk bertanya
- e. Dengarkan dan tanggapilah pertanyaan ibu
- f. Berikan dukungan pada ibu
- g. Anjurkan ibu untuk ditemani suami/keluarga
- h. Ajarkan keluarga cara memperhatikan dan mendukung ibu
- i. Lakukan praktek pencegahan infeksi yang baik
- j. Hargai privasi ibu
- k. Anjurkan ibu memilih posisi persalinan
- l. Anjurkan ibu untuk makan dan minum
- m. Hargai praktek tradisional yang tidak merugikan kesehatan ibu
- n. Hindari tindakan berlebihan yang membahayakan ibu
- o. Anjurkan ibu untuk memeluk bayinya sesegera mungkin
- p. Membantu memulai IMD
- q. Siapkan rencana rujukan (bila perlu)
- r. Mempersiapkan persalinan dengan baik

Asuhan sayang ibu dan sayang bayi pasca persalinan antara lain adalah:

- a. Anjurkan ibu untuk selalu berdekatan dengan bayinya (rawat gabung)
- b. Bantu ibu untuk membiasakan menyusui dan anjurkan pemberian ASI sesuai dengan permintaan

- c. Ajarkan ibu dan keluarga tentang nutrisi dan istirahat yang cukup setelah melahirkan
- d. Anjurkan suami dan anggota keluarga untuk memeluk bayi dan mensyukuri kelahiran bayi
- e. Ajarkan ibu dan anggota keluarga tentang gejala dan tanda bahaya yang mungkin terjadi dan anjurkan mereka untuk mencari pertolongan jika timbul masalah atau rasa khawatir

Menurut Keenan-Lindsay et al (2021), beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah proses persalinan telah berubah menjadi berpusat pada tenaga kesehatan, tempat persalinan dan asuhan yang diberikan. Kolaborasi perawatan ibu dan bayi yang berpusat pada keluarga didasarkan pada penghormatan terhadap kehamilan sebagai suatu yang alami dan persalinan merupakan proses psikologis yang normal. Ibu hamil harus didukung dalam pengambilan keputusan dalam menentukan tempat persalinan. Inisiasi menyusui dini merupakan strategi utama dalam meningkatkan cakupan ASI Eksklusif.

Menurut Perry et al (2018), beberapa hal yang berpengaruh terhadap tingkatan rasa nyeri ibu bersalin antara lain adalah faktor psikologi, budaya, kecemasan, pengalaman sebelumnya, mekanisme koping terhadap rasa nyeri, kenyamanan dan lingkungan.

3. Pencegahan infeksi

Pencegahan infeksi (PI) harus diterapkan dalam setiap aspek asuhan untuk melindungi ibu, bayi baru lahir, keluarga, penolong persalinan dan tenaga kesehatan lainnya. PI merupakan bagian yang esensial dari semua asuhan yang diberikan kepada ibu dan bayi baru lahir dan harus dilaksanakan secara rutin pada saat menolong persalinan dan kelahiran bayi, saat memberikan asuhan selama kunjungan antenatal atau pasca persalinan atau bayi baru lahir (Woodd et al., 2019).

Beberapa istilah tindakan dalam pencegahan infeksi antar lain adalah:

- a. Asepsis (teknik aseptik), merupakan semua usaha mencegah masuknya mikroorganisme ke tubuh yang berpotensi untuk menimbulkan infeksi dengan cara mengurangi atau menghilangkan sejumlah mikroorganisme pada kulit, jaringan dan benda mati.
- b. Antiseptik merupakan pencegah infeksi dengan cara membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada kulit dan jaringan tubuh dengan menggunakan larutan antiseptik
- c. Dekontaminasi adalah tindakan untuk memastikan bahwa petugas kesehatan dapat menangani secara aman berbagai benda yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh

- d. Mencuci dan membilas merupakan tindakan untuk menghilangkan semua cemar darah, cairan tubuh atau benda asing misalnya debu, kotoran dari kulit atau instrumen atau peralatan
- e. Desinfeksi merupakan tindakan untuk menghilangkan hampir semua atau sebagian besar mikroorganisme dari benda mati. Desinfeksi Tingkat Tinggi (DTT) merupakan tindakan untuk menghilangkan semua mikroorganisme (kecuali beberapa bakteri endospore) pada benda mati atau instrumen
- f. Sterilisasi merupakan tindakan untuk menghilangkan semua mikroorganisme termasuk endospore bakteri pada benda mati atau instrumen.

Tindakan pencegahan infeksi meliputi (Indonesia, 2017):

a. Cuci tangan

Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan jelas kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (alcohol-based handrubs) bila tangan tidak tampak kotor. Kuku petugas harus selalu bersih dan terpotong pendek, tanpa kuku palsu, tanpa memakai perhiasan cincin. Cuci tangan dengan sabun biasa/antimikroba dan bilas dengan air mengalir, dilakukan pada saat:

- 1) Bila tangan tampak kotor, terkena kontak cairan tubuh pasien yaitu darah, cairan tubuh sekresi, ekskresi, kulit yang tidak utuh, ganti Verband, walaupun telah memakai sarung tangan.
- 2) Bila tangan beralih dari area tubuh yang terkontaminasi ke area lainnya yang bersih, walaupun pada pasien yang sama

Indikasi kebersihan tangan yaitu:

- 1) Sebelum kontak pasien
- 2) Sebelum tindakan aseptik
- 3) Setelah kontak darah dan cairan tubuh
- 4) Setelah kontak pasien
- 5) Setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien

Kriteria memilih antiseptik adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki efek yang luas, menghambat atau merusak mikroorganisme secara luas (gram positif dan gram negatif, virus lipofilik, bacillus dan tuberkulosis, fungus serta endospore)
- 2) Efektifitas
- 3) Kecepatan efektifitas awal

- 4) Efek residu, aksi yang lama setelah pemakaian untuk meredam pertumbuhan
- 5) Tidak menyebabkan iritasi kulit
- 6) Tidak menyebabkan alergi



Gambar 2.3 Cara Kebersihan Tangan dengan Sabun dan Air



Gambar 2.4 Cara Kebersihan Tangan dengan Antisepsik Berbasis Alkohol
 Diadaptasi dari WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: First Global Patient Safety Challenge, World Health Organization, 2009.

b. Memakai sarung tangan dan perlengkapan pelindung lainnya

Seorang penolong persalinan hendaknya memakai sarung tangan sebelum menyentuh sesuatu yang basah (selaput mukosa, darah atau cairan tubuh lainnya, peralatan, sarung tangan atau sampah yang terkontaminasi). Terdapat 3 macam sarung tangan yaitu sarung tangan steril atau DTT (untuk prosedur apapun yang akan mengakibatkan kontak dengan karingan di bawah kulit seperti persalinan, penjaitan vagina atau pengambilan darah), sarung tangan bersih (untuk menangani darah atau cairan tubuh), dan sarung tangan rumah tangga yang tebal (untuk mencuci peralatan, menangani sampah dan juga membersihkan darah dan cairan tubuh) (Boelig et al., 2020).

Pemakaian alat pelindung diri (APD) seperti kaca amata pelindung, masker wajah, penutup kepala, celemek dan sepatu boots yang digunakan

untuk menghalangi atau membatasi petugas dari percikan cairan tubuh, darah atau cedera selama melaksanakan prosedur klinik (Indonesia, 2017)

Selama pandemi Covid 19, terdapat perubahan dalam penggunaan alat pelindung diri, khususnya selama persalinan berlangsung (Kemenkes RI, 2020a) FKTP memberikan layanan persalinan tanpa penyulit kehamilan/persalinan ATAU tidak ada tanda bahaya ATAU bukan kasus ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID-19. Penolong persalinan di FKTP menggunakan APD level-2. 6) Jika kondisi sangat tidak memungkinkan untuk merujuk kasus ODP, PDP, terkonfirmasi COVID-19 atau hasil skrining rapid test positif, maka pertolongan persalinan hanya dilakukan dengan menggunakan APD level3 dan Ibu bersalin dilengkapi dengan delivery chamber (Kemenkes RI, 2020b)

c. Menggunakan teknik aseptis atau aseptic

Kulit dan selaput mukosa merupakan bagian yang tidak bisa disterilkan, untuk itu penggunaan antiseptic dapat mengurangi jumlah mikroorganisme yang dapat mengkontaminasi luka terbuka dan menyebabkan infeksi

d. Memproses alat bekas pakai

e. Menangani peralatan tajam dengan aman

f. Menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan

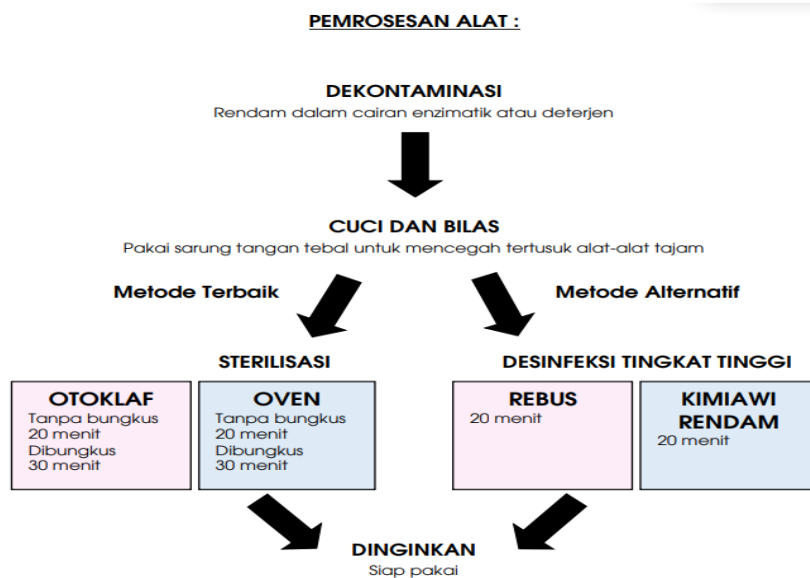
Terdapat beberapa cara pelaksanaan kewaspadaan standar, yaitu (Indonesia, 2017):

- a. Anggap setiap orang (klien maupun petugas) dapat menularkan infeksi
- b. Cuci tangan, upaya yang paling penting untuk mencegah kontaminasi silang
- c. Gunakan Alat Pelindung Diri
 - 1) Masker Bedah (Medical/Surgical mask)
 - 2) Pelindung Mata (Goggles)
 - 3) Pelindung Wajah (Face Shield)
 - 4) Sarung tangan pemeriksaan (Examination Gloves)
 - 5) Sarung tangan bedah (Surgical Gloves)
- d. Gunakan cairan antiseptik untuk membersihkan kulit maupun membran mukosa sebelum memasang AKDR, Implan, Tubektomi dan vasektomi
- e. Lakukan upaya kerja yang aman seperti tidak memasang tutup jarum suntik, memberikan alat-alat tajam dengan cara yang aman
- f. Buang bahan-bahan habis pakai dengan aman untuk melindungi petugas pengelola limbah medis dan untuk mencegah cedera maupun penularan infeksi kepada masyarakat
- g. Lakukan pemrosesan terhadap alat-alat setelah dipakai dengan cara mendekontaminasi dalam larutan cairan enzimatis/detergen selama 10

menit atau larutan lain yang direkomendasikan, selanjutnya dicuci dan disikat kemudian dibilas dengan air mengalir yang bersih kemudian disterilisasi atau Desinfeksi Tingkat Tinggi (DTT) .

Adapun cara menggunakan alat suntik yang aman adalah sebagai berikut:

- a. Gunakan alat suntik untuk satu kali pemakaian
- b. Jangan melepaskan jarum dari tabung suntik setelah selesai dipakai
- c. Jangan menutup kembali ,membengkokkan atau mematahkan jarum sebelum dibuang
- d. Dekontaminasi alat suntik sebelum dibuang
- e. Buang alat suntik dalam kontainer pembuangan yang tahan tusukan bila tidak dipakai lagi
- f. Pemusnahan alat dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi fasyankes dan sesuai dengan peraturan menteri kesehatan



Gambar 2.5 Cara Pemrosesan Alat

Dalam melakukan pemrosesan alat adalah sebagai berikut:

- a. Dekontaminasi (Pra Pencucian):
Masih memakai sarung tangan, rendam alat-alat selama 10 menit dalam larutan enzimatis atau air dengan deterjen WHO sejak tahun 2016 tidak merekomendasikan pemakaian Klorin 0,5% untuk Dekontaminasi
- b. Cuci dan Bilas
 - 1) Cuci semua alat-alat dalam ember berisi air dan deterjen pakai sarung tangan karet tebal

- 2) Sikat semua geligi, sambungan dan permukaan alat menggunakan sikat gigi
- 3) Sikat dibawah permukaan air agar muka tidak terpercik air cucian
- 4) Bilas dibawah air mengalir
- c. Sterilisasi
 - 1) Sterilisasi uap (Otoklaf): 1210C, 106 kpa, waktu yang diperlukan 20 menit untuk alat yang tidak dibungkus dan 30 menit untuk alat yang dibungkus
 - 2) Sterilisasi panas kering (Oven): 1700C selama 1 jam Untuk alat-alat tajam (gunting, jarum) sterilisasi dilakukan dengan suhu 1600C selama 2 jam
 - 3) Sterilisasi kimia: Glutaraldehyd (Cydex®) direndam selama 8 – 10 jam Bilas dengan air steril sebelum digunakan kembali atau sebelum disimpan
- d. Desinfeksi Tingkat Tinggi (DTT)
 - 1) DTT dengan Merebus: Seluruh alat harus terendam, rebus selama 20 menit dalam panci tertutup Mulai menghitung waktu air mulai mendidih Jangan memasukkan alat kedalam air mendidih Pakai alat tersebut sesegera mungkin atau simpan dalam wadah tertutup dan kering yang telah di DTT, bisa disimpan sampai 1 minggu
 - 2) DTT dengan Larutan Kimia: Rendam dalam Glutaraldehyd
- e. Pembuangan limbah terkontaminasi
 - 1) Gunakan sarung tangan rumah tangga
 - 2) Pindahkan limbah terkontaminasi ke tempat pembuangan dalam wadah tertutup
 - 3) Buang alat/benda tajam kedalam wadah tahan tusuk
 - 4) Cuci tangan, sarung tangan dan wadah yang telah digunakan untuk membuang limbah
 - 5) Pemusnahan alat dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi fasyankes dan sesuai dengan peraturan menteri kesehatan

4. Pencatatan (Rekam Medik) asuhan persalinan

Pencatatan (pendokumentasian) adalah bagian penting dari proses membuat keputusan klinik karena memungkinkan penolong persalinan untuk terus menerus memperhatikan asuhan yang diberikan selama proses persalinan dan kelahiran bayi. Partograf adalah bagian terpenting dari proses pencatatan selama persalinan.

Pencatatan rutin adalah penting karena :

- a. Sebagai alat bantu untuk membuat keputusan klinik dan mengevaluasi kesesuaian dan keefektifan asuhan atau perawatan, mengidentifikasi

kesenjangan pada asuhan yang diberikan dan untuk membuat perubahan dan peningkatan pada rencana asuhan atau perawatan.

- b. Sebagai tolak ukur keberhasilan dalam proses membuat keputusan klinik.
- c. Sebagai catatan permanen tentang asuhan, perawatan dan obat yang diberikan.
- d. Dapat dibagikan di antara para penolong persalinan sehingga lebih dari satu penolong persalinan akan memberikan perhatian dan asuhan pada ibu atau bayi baru lahir.
- e. Dapat mempermudah kelangsungan asuhan dari satu kunjungan ke kunjungan berikutnya, dari satu penolong persalinan ke penolong persalinan lainnya, atau dari seorang penolong persalinan ke fasilitas kesehatan lainnya.
- f. Dapat digunakan untuk penelitian atau studi kasus.
- g. Diperlukan untuk memberi masukan data statistik nasional dan daerah, termasuk catatan kematian dan kesakitan ibu atau bayi baru lah

Beberapa aspek – aspek penting dalam pencatatan adalah :

- a. Tanggal dan waktu asuhan diberikan
- b. Identifikasi penolong persalinan.
- c. Paraf atau tanda tangan (dari penolong persalinan) pada semua catatan.
- d. Mencakup informasi yang berkaitan secara tepat, dicatat dengan jelas dan dapat dibaca.
- e. Suatu sistem untuk memelihara catatan pasien sehingga selalu siap tersedia.
- f. Kerahasiaan dokumen – dokumen medis.

Ibu harus diberikan salinan catatan (catatan klinik antenatal, dokumen – dokumen rujukan, dan lain – lain) beserta panduan yang jelas mengenai :

- a. Maksud dari dokumen – dokumen tersebut
- b. Kapan harus dibawa
- c. Kepada siapa harus diberikan
- d. Bagaimana menyimpan dan mengamankannya, baik di rumah atau selama perjalanan ke tempat rujukan.

Beberapa hal yang perlu diingat antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Catat semua data, hasil pemeriksaan, diagnosis, obat – obat, asuhan atau perawatan, dan lain – lain
- b. Jika tidak dicatat, maka dapat dianggap bahwa asuhan tersebut tidak dilakukan
- c. Pastikan setiap partograf bagi setiap pasien diisi dengan lengkap dan benar.

5. Rujukan

Dalam persalinan, sangatlah sulit untuk menduga kapan penyulit akan terjadi, untuk itu pada saat ibu melakukan kunjungan antenatal hendaknya petugas kesehatan menganjurkan ibu untuk membahas dan membuat rencana rujukan Bersama suami dan keluarganya. Upayakan penolong persalinan mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan suami dan keluarganya untuk menjelaskan tentang perlunya rencana rujukan apabila diperlukan.

Jika ditemukan suatu masalah dalam persalinan, sering kali sulit untuk melakukan upaya rujukan dengan cepat, hal ini karena banyak faktor yang mempengaruhi. Penundaan dalam membuat keputusan dan pengiriman ibu ke tempat rujukan akan menyebabkan tertundanya ibu mendapat penatalaksanaan yang memadai, sehingga dapat menyebabkan tingginya angka kematian ibu. Rujukan tepat waktu merupakan bagian dari asuhan sayang ibu dan menunjang terwujudnya program *Safe Motherhood*. Di bawah ini merupakan akronim yang dapat digunakan petugas kesehatan dalam mengingat hal-hal penting dalam mempersiapkan rujukan untuk ibu dan bayi:

a. **B (Bidan)**

Pastikan bahwa ibu dan bayi baru lahir didampingi oleh penolong persalinan yang kompeten untuk melaksanakan gawat darurat obstetri dan BBL untuk dibawa ke fasilitas rujukan

b. **A (Alat)**

Bawa perlengkapan dan alat-alat untuk asuhan persalinan, masa nifas, dan BBL (tabung suntik, selang IV, alat resusitasi, dan lain-lain) bersama ibu ke tempat rujukan. Perlengkapan dan bahan-bahan tersebut mungkin diperlukan jika ibu melahirkan dalam perjalanan ke fasilitas rujukan.

c. **K (Keluarga)**

Beritahu Ibu dan Keluarga mengenai kondisi terakhir ibu dan bayi dan mengapa ibu dan bayi perlu dirujuk. Jelaskan pada mereka alasan dan tujuan merujuk ibu ke fasilitas rujukan tersebut

d. **S (Surat)**

Berikan surat keterangan rujukan ke tempat rujukan. Surat ini memberikan identifikasi mengenai ibu dan BBL cantumkan alasan rujukan dan uraikan hasil penyakit, asuhan atau obat-obatan yang diterima ibu dan BBL.

e. **O (obat)**

Bawa obat-obat esensial pada saat mengantar ibu ke fasilitas rujukan.

f. **K (Kendaraan)**

Siapkan kendaraan yang paling memungkinkan untuk merujuk ibu dalam kondisi cukup nyaman.

g. **U (Uang)**

Ingatkan keluarga untuk membawa uang dalam jumlah yang cukup untuk membeli obat-obatan yang diperlukan dan bahan-bahan kesehatan lainnya selama ibu dan bayi di fasilitas rujukan.

h. Da (Darah dan Doa)

Persiapan darah baik dari anggota keluarga maupun kerabat sebagai persiapan jika terjadi penyulit

Seorang penolong persalinan harus mengetahui lokasi fasilitas rujukan yang mampu untuk melaksanakan kasus kegawatdaruratan obstetric dan bayi baru lahir seperti pembedahan (termasuk operasi bedah sesar), tranfusi darah, persalinan menggunakan ekstraksi vakum atau cunam, pemberian antibiotic intravena, resusitasi bayi baru lahir dan asuhan lanjutan bagi bayi baru lahir. Adapun beberapa hal yang wajib diketahui oleh setiap penolong persalinan antara lain adalah informasi tentang pelayanan yang tersedia di tempat rujukan, ketersediaan pelayanan purna waktu, biaya pelayanan dan waktu serta jarak tempuh ketempat rujukan.

D. Kesimpulan

Penolong persalinan perlu menerapkan asuhan persalinan yang sesuai dengan kebutuhan ibu bersalin dimana di dalamnya penolong dituntut untuk menerapkan lima benang merah dalam persalinan, pengambilan keputusan sepenuhnya diserahkan kepada pasien dan keluarga dengan tetap memperhatikan keselamatan pasien dimana pasien dan keluarga telah diberikan informasi dengan jelas. Asuhan sayang ibu dan sayang bayi perlu diterapkan untuk mendukung kelancaran keseluruhan proses persalinan. Pencegahan infeksi yang diterapkan dengan baik dapat menurunkan risikoterjadinya penularan penyakit. Rekam medik atau pendokumentasian merupakan pengamatan proses persalinan dan rujukan yang tepat mampu mencegah kejadian morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi.

DAFTAR PUSTAKA

- Boelig, R. C., Manuck, T., Oliver, E. A., Di Mascio, D., Saccone, G., Bellussi, F., & Berghella, V. (2020). Labor and delivery guidance for COVID-19. *American Journal of Obstetrics and Gynecology MFM*, 2(2). <https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2020.100110>
- Hardhana, B., Sibuea, F., & Widiyanti, W. (Eds.). (2021). *PROFIL KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2020*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Indonesia, K. K. R. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*.
- JNPK-KR. (2017). *Asuhan Persalinan Normal*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Kartikasari, M. N. D., Suriati, I., Aryani, R., Susmita, Argani, N., Kurniawati, E., Susanti, Fajrina, E., Mona, S., Dwi A, W., Hajar, S., & Hasanah, S. (2022). *Dokumentasi Kebidanan*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Keenan-Lindsay, L., Sams, C., & O'Connor, C. L. (2021). *Perry's Maternal Child Nursing Care In Canada* (J. Hurlbutt (Ed.); Third edit). Elsevier Inc.
- Kemkes RI. (2020a). *Pedoman pelayanan antenatal, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir di Era Adaptasi Baru*.
- Kemkes RI. (2020b). Protokol Petunjuk Praktis Layanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Selama Pandemi COVID-19. *Protokol Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ri*, 4(April), 1–11. <https://covid19.go.id/p/protokol/protokol-b-4-petunjuk-praktis-layanan-kesehatan-ibu-dan-bbl-pada-masa-pandemi-covid-19>
- King, T. L., Brucker, M. C., Kriebs, J. M., Fahey, J. O., & Ggor, C. L. (Eds.). (2015). *Varney's Midwifery* (Fifth Editi). Jones & Bartlett Learning.
- Marshall, J. E., & Raynor, M. D. (2020). Myles's textbook for Midwifery. In J. Dunkley-Bent (Ed.), *Section 4 Labour* (Seventeenth). Elsevier Health Sciences.
- Perry, S. E., Hockenberry, M. J., & Lowdermilk, D. L. (2018). Maternal Child Nursing Care. In *Unit 4 Childbirth* (Sixth edit). Elsevier Health Sciences.
- Simanullang, E., & Diosi, R. I. (2019). The implementation of midwifery competency standards in applying behaviour of normal childbirth care (APN) on BIDAN PRAKTIK MANDIRI PERA. *3rd International Conference on Healthcare and Allied Sciences*, Vol. 30. N, 96–98. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.11.030>
- Woodd, S. L., Montoya, A., Barreix, M., Pi, L., Calvert, C., Rehman, A. M., Chou, D., & Campbell, O. M. R. (2019). Incidence of maternal peripartum infection: A systematic review and meta-analysis. *PLoS Medicine*, 16(12). <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002984>

BAB 3

KEBUTUHAN DASAR SELAMA PERSALINAN

Bdn. Pipih Salanti, S.ST, MKM



BAB 3

KEBUTUHAN DASAR SELAMA PERSALINAN

Bdn. Pipih Salanti, S.ST, MKM

A. Pendahuluan

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup di luar uterus melalui vagina ke dunia luar. Persalinan normal atau persalinan spontan adalah bila bayi lahir dengan letak belakang kepala tanpa melalui alat-alat atau pertolongan istimewa serta tidak melukai ibu dan bayi, dan umumnya berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam. Jadi persalinan adalah proses pengeluaran konsepsi yang telah cukup bulan melalui jalan lahir atau jalan lainnya, dengan bantuan atau tanpa bantuan. Kebutuhan dasar dalam persalinan sangat dibutuhkan Ibu terutama pada Ibu yang baru melahirkan anak pertama, dimana Ibu belum pernah merasakan bersalin dan belum ada bayangan untuk merasakan sakit pada proses persalinan. (RI, 2007)

Untuk menghilangkan perasaan tersebut maka kebutuhan dasar dalam persalinan harus diberikan supaya Ibu merasa nyaman dan siap untuk melahirkan bayinya. Pemantauan saat menjelang persalinan sangat penting dilakukan oleh setiap petugas kesehatan yang akan dan telah menolong kelahiran bayi, sebagai pemantauan dasar minimal pre dan pasca persalinan. Selama kala I,II,III, IV, petugas kesehatan harus memantau ibu terutama kebutuhan dasarnya agar ibu siap untuk menjalani persalinannya.(Manuaba, 1998)

B. Tujuan

1. Untuk memberikan rasa nyaman pada Ibu
2. Untuk memberikan Suport Pada Ibu
3. Untuk Meningkatkan rasa percaya diri pada Ibu
4. Untuk memberikan fisik yang kuat dalam menghadapi persalinan(Farrer, 1999)

C. Pembahasan

Kebutuhan dasar pada Ibu selama persalinan sangat di perlukan karena dapat mengurangi rasa nyeri pada saat ibu merasakan His dan dapat memberikan rasa nyaman pada ibu. dalam menjalani persalinan seorang Ibu perlu di damping oleh suami dan keluarga, penolong persalinan harus memberikan kenyamanan kepada Ibu pada saat persalinan, maka dari itu dukungan persalinan dan kehadiran seorang pendamping sangat dibutuhkan karena dengan adanya dukungan tersebut akan menghasilkan:

1. Kelahiran dengan bantuan vakum/forceps lebih sedikit
2. Sectio Caesaria untuk membantu kelahiran semakin berkurang

3. Skor APGAR < 7 lebih sedikit
4. Lamanya persalinan semakin pendek
5. Kepuasan ibu semakin besar dalam pengalaman melahirkan.

Besar artinya kehadiran seorang pendamping persalinan karena dapat berbuat banyak untuk membantu ibu saat persalinan antara lain :

1. Membantu menghitung kontraksi sehingga ibu mengetahui kemajuan persalinan
2. Memberi dorongan dan keyakinan pada ibu selama persalinan
3. Membantu menciptakan suasana nyaman dalam ruang bersalin
4. Membantu mengawasi pintu dan melindungi privasi ibu
5. Melaporkan gejala-gejala atau sakit pada bidan
6. Membantu ibu mengatasi rasa tidak nyaman fisik

Pengurangan Rasa Sakit

Penyebab rasa sakit dalam persalinan :

1. Kontraksi Uterus

- Umumnya dimulai dari bawah pinggang menyebar ke bagian bawah perut dan kaki
- Dalam medis sakit kontraksi dikategorikan bersifat tumpul (Visceral-Dull and Aching) (Benett, 1996)
- Merupakan nyeri primer melibatkan pinggang, punggung, perut dan pangkal paha
- Menyebabkan nyeri sekunder seperti mual, muntah, panas dingin, kram dan pusing.

Faktor-Faktor Yang Memperparah Rasa Sakit Pusdiknakes.(Pusdiknakes, 2003)

Selain faktor penyebab di atas, ada hambatan fisik dan psikologis pada ibu saat persalinan yang dapat menambah rasa sakit antara lain :

a. Faktor Fisik

- Tindakan bidan/dokter dalam menolong persalinan mis. Vakum/forceps, episiotomi, manual plasenta, induksi oksitosin
- Partus lama
- Penyakit yang timbul saat bersalin, asma, jantung, hipertensi
- Periksa dalam yang berulang-ulang

b. Faktor Psikologis

- Ibu melahirkan sendiri, tanpa pendamping
- Ibu mengalami kelelahan
- Stress, cemas dan tegang selama kontraksi
- Berfikir tentang sakit
- Tidak siap melahirkan atau kelahiran di luar jadwal yang diperkirakan

- Kehamilan yang tidak diinginkan
- Tenaga medis yang kurang bersahabat

Untuk membantu ibu mengurangi rasa nyeri persalinan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu :

a. Melalui Tindakan Medis

- Memberikan analgetik obat pereda sakit
- Suntikan epidural
- Blok saraf perineal dan pudendal
- Menggunakan mesin TENS

b. Melalui Metode Alternatif

- Menghadirkan pendamping persalinan
- Perubahan posisi dan pergerakan
- Sentuhan dan massage
- Hipnotis
- Kompres hangat dan dingin
- Berendam di air hangat
- Terapi akupunktur
- Visualisasi dan pemusatan perhatian
- Musik

Upaya untuk meredakan nyeri ibu selama kala II meliputi mengubah posisi, memberi perawatan mulut, menjaga kebersihan ranjang agar tetap kering, dan menghindari keributan dan suara percakapan di luar, atau hal-hal lain yang mengganggu konsentrasi (seperti tertawa, pembicaraan staf di dalam atau diluar kamar bersalin). Lima kebutuhan wanita bersalin:

1. Asuhan tubuh dan fisik.
2. Kehadiran seorang pendamping.
3. Penerimaan terhadap sikap dan perilakunya.
4. Informasi dan kepastian tentang hasil persalinan yang aman
5. Pengurangan rasa nyeri

Asuhan ini berorientasi pada tubuh Ibu selama dalam proses persalinan sehingga akan menghindarkan Ibu dari infeksi. Asuhan yang diberikan:

- a. Menjaga kebersihan diri
- b. Berendam
- c. Perawatan Mulut
- d. Kegunaan Handuk
- e. Pengipasan

f. Menjaga Kebersihan Diri

- Menganjurkan Ibu membasuh sekitar kemaluan setelah BAK atau BAB dan menjaganya agar tetap bersih dan kering.
- Mandi di bak atau shower sangat menyegarkan dan menimbulkan rasa santai dan sehat .

g. Berendam

- Beberapa wanita memilih menggunakan kolam untuk berendam pada kala I, beberapa wanita memilih melahirkan di dalam air dan yang lainnya telah memberikan komentar tentang betapa rileksnya mereka selama di dalam air.
- Perlu bak yg cukup dalam agar air daapt menutup abdomen ibu hidroterapi dan buoyancy (mengapung di permukaan air) yang menyejukkan dan membantu wanita berkoping terhadap kontraksinya.
- Air membantu relaksasi lalu serviks cepat berdilatasi, tapi setelah beberapa jam frekwensi dan intensitas his mulai berkurang dan Ibu harus keluar dari bak.

h. Perawatan Mulut

Ibu inpartu napasnya berbau, bibir kering dan pecah-pecah, tengorokan kering terutama jika untuk tanpa cairan oral dan perawatan mulut. timbul rasa tidak nyaman dan tidak menyenangkan bagi org disekitarnya.

Perawatan Yang Dapat Di berikan

- Gosok Gigi
- Mencuci mulut. Dengan memakai produk pencuci mulut yang menyegarkan nafas
- Pemberian gliserin untuk menghindari bibir kering
- Pemberian permen untuk mencegah aspirasi

i. Kegunaan Handuk

- Menghilangkan keringat di wajah
- Kompres hangat lembab atau panas

j. Pengipasan

- Ibu bersalin biasanya banyak mengeluarkan keringat , bahkan pada ruang persalinan dengan kontrol suhu terbaik mereka akan mengeluh berkeringat pada beberapa waktu tertentu
- Tempat persalinan yang tidak menggunakan pendingin akan terasa tidak nyaman
- Mengurangi rasa sakit
- Waktu persalinan lebih singkat
- Menurunkan angka persalinan dengan operasi sesar

- Menambah rasa percaya diri Ibu
- Kejadian Asfiksia menjadi berkurang

Bentuk Dukungan Pendamping

- Mengusap keringat Ibu
- Menemani atau membimbing Ibu jalan-jalan
- Memberikan minum
- Merubah posisi
- Menciptakan suasana kekeluargaan dan rasa nyaman
- Membantu Ibu bernafas saat kontraksi
- Mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati dan memberikan pujian kepada ibu
- Memijat punggung, kaki atau kepala Ibu dll

Penerimaan Terhadap Kelakuan dan Tingkah Laku

- Biarkan sikap dan tingkah lakunya , beberapa ibu mungkin akan berteriak-teriak pada puncak his, berusaha untuk diam dan ada pula yang menangis .
- Persalinan dan kelahiran merupakan hal yang fisiologis, tapi banyak Ibu yang tidak siap untuk menghadapi persalinannya.wanita perlu perhatian yang lebih banyak dari suami, keluarga, bahkan bidan penolong.
- Asuhan berupa pemberian dukungan mental dan penjelasan kepada Ibu bahwa rasa sakit yang dialami merupakan suatu proses yang harus dilalui dan diharapkan ibu tenang dalam keadaan menghadapi persalinan.

Informasi dan Kepastian Tentang Hasil Persalinan

- Setiap Ibu membutuhkan informasi tentang kemajuan persalinannya, sehingga ia mampu mengambil keputusan .
- Ibu juga perlu di yakinkan bahwa kemajuan persalinannya normal
- Kita hendaknya menyadari bahwa kata-kata mempunyai pengaruh yang sangat kuat negative atau positif.

Meliputi :

- Penjelasan tentang proses dan perkembangan persalinan
- Jelaskan semua hasil pemeriksaan
- Pengurangan rasa takut
- Penjelasan tentang prosedur dan adanya pembatasan

Kebutuhan dasar ibu bersalin yaitu:

- 1) Dukungan emosional, dukungan dari suami, orang tua dan kerabat yang disukai ibu sangat diperlukan dalam mengurangi rasa tegang dan membantu kelancaran proses persalinan dan kelahiran bayi. Penolong persalinan juga dapat memberikan dukungan dan semangat kepada ibu dan anggota keluarga dengan menjelaskan tahapan dan kemajuan proses persalinan dan kelahiran bayinya.
- 2) Kebutuhan makanan dan cairan, selama persalinan anjurkan ibu sesering mungkin minum dan makanan ringan.
- 3) Kebutuhan eliminasi, kandung kencing harus dikosongkan setiap dua jam atau lebih sering jika kandung kemih ibu terasa penuh selama proses persalinan. Kandung kemih yang penuh akan menghambat penurunan bagian terbawah janin.
- 4) Mengatur posisi, peranan bidan adalah mendukung ibu dalam pemilihan posisi apapun, menyarankan alternatif hanya apabila tindakan ibu tidak efektif atau membahayakan bagi diri sendiri maupun bagi bayinya.
- 5) Peran pendamping, kehadiran suami atau orang terdekat ibu untuk memberikan dukungan pada ibu sehingga ibu merasa lebih tenang dan proses persalinannya dapat berjalan dengan lancar.
- 6) Pengurangan rasa nyeri, mengurangi rasa nyeri bisa dilakukan dengan pijatan. Pijatan dapat dilakukan pada lumbosakralis dengan arahan melingkar. (JNPK, 2017)

Persiapan perlengkapan, bahan dan obat yang diperlukan

Harus tersedia daftar perlengkapan, bahan dan obat yang diperlukan untuk asuhan persalinan dan kelahiran bayi serta adanya serah terima antar petugas pada saat pertukaran waktu jaga. Setiap petugas harus memastikan kelengkapan dan kondisinya dalam keadaan aman dan siap pakai.

Bidan harus mampu memberikan perasaan kehadiran meliputi: mendengarkan dan melakukan observasi, melakukan kontak fisik, bersikap tenang dan bisa menenangkan pasien. Hasil penelitian (*Randomized Controlled Trial*) membuktikan bahwa dukungan fisik, emosional dan psikologis selama persalinan dan kelahiran sangat efektif dan memberikan pengaruh apabila dilakukan pendampingan terus-menerus. Adapun pengaruhnya adalah: mengurangi kelahiran dengan tindakan vacum, forceps, dan operasi sesar, mengurangi kejadian APGAR score bayi kurang dari 7, memperpendek lama persalinan, dan kepuasan ibu semakin besar dalam pengalaman persalinan.

Kebutuhan cairan dan nutrisi

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu bahwa pemberian makanan padat dengan pasien yang memerlukan anestesi tidak disetujui. Motilitas, absorpsi dan sekresi asam lambung menurun. Hal ini dapat menyebabkan makanan dapat tertinggal di lambung sehingga dapat terjadi aspirasi pneumonia. Namun demikian, kebutuhan akan cairan masih diperbolehkan. Selama persalinan, ibu memerlukan minum dan sangat dianjurkan minum minuman yang manis dan berenergi.

Sebagian ibu masih berkeinginan untuk makan selama fase laten persalinan, tetapi memasuki fase aktif, hanya ingin minum saja. Pemberian makan dan minum selama persalinan merupakan hal yang tepat, karena memberikan lebih banyak energi dan mencegah dehidrasi (dehidrasi dapat menghambat kontraksi/tidak teratur dan kurang efektif). Oleh karena itu, anjurkan ibu makan dan minum selama persalinan dan kelahiran bayi, anjurkan keluarga selalu menawarkan makanan ringan dan sering minum pada ibu selama persalinan. (Mochtar, 1998)

Kebutuhan eliminasi

Selama persalinan terjadi penekanan pada pleksus sakrum oleh bagian terendah janin sehingga menyebabkan retensi urin maupun sering berkemih. Retensi urin terjadi apabila:

1. Tekanan pada pleksus sakrum menyebabkan terjadinya inhibisi impuls sehingga vesica uretra menjadi penuh tetapi tidak timbul rasa berkemih;
2. Distensi yang menghambat saraf reseptor pada dinding vesica uretra;
3. Tekanan oleh bagian terendah pada vesica uretra dan uretra;
4. Kurangnya privasi/postur yang kurang baik;
5. Kurangnya kesadaran untuk berkemih; dan
6. Anestesi regional, epidural, blok pudendal sehingga obat mempengaruhi saraf vesica uretra. (Saifuddin, 2001)

Pemenuhan kebutuhan eliminasi selama persalinan perlu difasilitasi agar membantu kemajuan persalinan dan pasien merasa nyaman. Oleh karena itu, anjurkan ibu untuk bereliminasi secara spontan minimal 2 jam sekali selama persalinan, apabila tidak mungkin dapat dilakukan kateterisasi. (Prawirohardjo.S, 2002)

Pengaruh kandung kemih penuh selama persalinan, sebagai berikut:

1. Menghambat penurunan bagian terendah janin, terutama bila berada di atas spina isciadika;
2. Menurunkan efisiensi kontraksi uterus;
3. Menimbulkan nyeri yang tidak perlu;
4. Meneteskan urin selama kontraksi yang kuat pada kala II;
5. Memperlambat kelahiran plasenta; dan

6. Mencetuskan perdarahan pasca persalinan dengan menghambat kontraksi uterus.

D. Kesimpulan

Setiap Ibu bersalin membutuhkan perhatian lebih baik dari penolong persalinannya atau dari pendampingnya yaitu suami dan keluarganya. Untuk mengurangi itu semua maka kebutuhan dasar persalinan sangat di harapkan, tentunya dengan memberikan penjelasan kepada penolong cara menghilangkan rasa nyeri pada saat His datang, bagaimana cara relaksasi yang benar, bagaimana cara menghadapi persalinan dengan aman dan nyaman. Seorang penolong harus selalu mendampingi pasiennya mulai dari ada rasa ingin melahirkan sampai melahirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Benett (1996) *Myles Textbook for midwives*. 12th edn. United Kingdom.
- Farrer, H. (1999) *Perawatan Maternitas*. JAKARTA.
- JNPK (2017) *Kesehatan Reproduksi*. JAKARTA: JNPK-KR.
- Manuaba (2017) *Ilmu Kebidanan, Penyakit kandungan*. JAKARTA: EGC.
- Mochtar, R. (1998) *Sinopsis Obstetri*. 2nd edn. JAKARTA: EGC.
- Prawirohardjo.S (2016) *Ilmu Kebidanan*. JAKARTA: YBPSP.
- Pusdiknakes (2003) *Asuhan Intrapartum*. JAKARTA: WHO-JHPIEGO.
- RI, D. (2007) *Asuhan Persalinan Normal*. JAKARTA.
- Saifuddin (2010) *Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal & Neonatal*. JAKARTA: JNPKKR.

BAB 4

PSIKOLOGI MASA PERSALINAN

Ernita Prima Noviyani, S.ST.,Bdn.,M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

A. Pendahuluan

Di tahun 2017, sekitar 810 wanita meninggal karena sebab yang dapat dicegah terkait dengan kehamilan dan persalinan. Wilayah Afrika (Sahara) dan Asia Selatan menyumbang sekitar 86% (254.000) dari perkiraan kematian ibu global pada tahun 2017. Afrika menyumbang sekitar dua pertiga (196.000) kematian ibu, sementara Asia Selatan menyumbang hampir seperlima (58.000) (World Health Organization., 2019). Menurut WHO kematian ibu adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/ cedera (Kementrian Kesehatan RI, 2014). Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015, angka kematian ibu di Indonesia menempati posisi 305 per 100 ribu kelahiran hidup (Archadi, 2019). Menilik capaian ini, angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang sudah menempati posisi 40-60 per 100 ribu kelahiran hidup (Agung, 2020). Pada tahun 2017 angka kematian setelah melahirkan (neonatal) di Indonesia sebanyak 15 per seribu kelahiran hidup, dengan jumlah tersebut Indonesia menempati urutan ke sepuluh sebagai negara dengan angka kematian neona (Dunkel Schetter & Tanner, 2012). Hal tertinggi di dunia (Untari & Rohmah, 2016). (dalam Isnaini et al., 2020)

Selama kehamilan terjadi perubahan fisiologi pada fisik dan psikologi ibu akibat adanya tumbuh kembang janin dan persiapan persalinan (Soma-Pillay et al., 2016). Perubahan tersebut membuat ibu hamil rentan pada kondisi stres, kecemasan dan keluhan lain terkait dengan kesehatan psikologi. Kekhawatiran dan kecemasan pada ibu hamil apabila tidak ditangani dengan serius akan membawa dampak dan pengaruh terhadap fisik dan psikis, baik pada ibu maupun janin. Wanita yang menderita stres dan cemas saat kehamilan usia trimester ketiga, akan mengalami peningkatan risiko kelainan bawaan berupa kegagalan penutupan celah palatum, risiko operasi *sectio caesarea*, persalinan dengan alat, kelahiran prematur, melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan dalam jangka panjang berkaitan dengan gangguan perilaku dan emosi anak

Ibu hamil dengan gangguan kesehatan psikologi misal stres dan kecemasan berisiko mengalami kelahiran prematur, lahir dengan berat yang rendah, perpanjangan durasi persalinan, gangguan kekebalan tubuh, gangguan metabolik dan obesitas, serta terjadinya hipertensi dalam kehamilan dan depresi postpartum (Dunkel Schetter & Tanner, 2012). Risiko kelahiran prematur meningkat sebesar 1,55 kali dibandingkan dengan kehamilan sehat. (Santos et al., 2021).

Tingkat kecemasan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ibu hamil maupun janin yang didalam kandungan. Tingkat kecemasan yang rendah pada ibu hamil dapat mengurangi komplikasi yang ditimbulkan sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi Angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia, sedangkan tingkat kecemasan yang tinggi dapat memperberat komplikasi yang terjadi dan meningkatkan AKI dan AKB, dimana dalam penelitian diambil sampel 45 responden ibu hamil yang mengalami tingkat kecemasan sedang mengalami hipertensi sebesar 52,7% sedangkan yang mengalami tingkat kecemasan tinggi mengalami preeclampsia sebesar 57,8% (Trisiani et al., 2016).

Salah satu upaya untuk menurunkan gangguan kesehatan psikologi yang dihadapi ibu hamil adalah dengan program kelas ibu hamil. Kelas Ibu Hamil merupakan program pelatihan untuk menghadapi kelahiran di bawah pengawasan dan bimbingan dokter kandungan atau bidan yang sudah berpengalaman. Tujuan mengikuti kelas ini adalah mempersiapkan diri ibu hamil secara fisik dan mental. Selain itu, ibu hamil juga dapat bertemu dengan ibu hamil yang lain dengan kondisi yang sama sehingga bisa saling bertukar informasi dan memberi dukungan (Fadillah et al., 2018).

B. Tujuan

- 1) Memahami faktor yang mempengaruhi Psikologis masa persalinan
- 2) Memahami masalah psikologis yang dapat terjadi pada masa persalinan
- 3) Memahami dan menerapkan kebutuhan psikologis masa persalinan

C. Pembahasan

Persalinan adalah salah satu peristiwa penting dan bersejarah yang dialami oleh kehidupan seluruh wanita di bumi ini. Hakikat manusia menurut perspektif psikologi adalah seorang wanita yang percaya bahwa kita dianggap sempurna ketika dapat melahirkan seorang anak. Ini merupakan peristiwa yang sangat positif dimana dapat menjadi masa transisi yang terasa menyenangkan untuk menghadapi ke tahap kehidupannya yang baru. Persalinan juga disebut sebagai saat-saat yang berat dalam hidup. Mengapa? Karena disinilah terjadi pertarungan nyawa antara hidup dan mati. Rasa cemas, panik disertai ketakutan yang tinggi, ketidakpastian ditambah sakit yang luar biasa timbul menjelang proses kelahiran. Rasa ini timbul akibat kekhawatiran yang muncul akan proses persalinan yang dialaminya dengan calon (Husnul Lail, 2019).

1) Faktor yang Mempengaruhi Psikologis Masa Persalinan

Rasa cemas dan gelisah sering menghantui ibu hamil ketika masa persalinan. Adapun masalah factor yang menimbulkan masalah psikologis pada masa persalinan adalah: 1) kekhawatiran, 2) takut dan kematian, 3)

trauma akan kelahiran, 4) perasaan bersalah, 5) kecemasan, 6) gelisah, 7) narsistis, 8) stress, 9) konflik batin, 10) sedih sekaligus bahagia.

2) Masalah Psikologis yang Terjadi pada Masa Persalinan

a. Kecemasan

Kecemasan adalah hal yang biasanya terjadi menjelang persalinan. Ibu hamil yang menantikan proses kelahiran pertama kali biasanya akan mulai gugup dan cemas. Ia tidak berhenti memikirkan hal-hal yang menurutnya berbahaya. Tentu saja, apabila kecemasan ini tidak dikelola dengan baik, maka kondisi psikis ibu tersebut akan semakin memburuk. Tidak menutup kemungkinan pula ia bisa sampai mengalami gangguan obsesif kompulsif (Nababan, 2021).

Ibu hamil dengan gangguan kesehatan psikologi misal stres dan kecemasan berisiko mengalami kelahiran prematur, lahir dengan berat yang rendah, perpanjangan durasi persalinan, gangguan kekebalan tubuh, gangguan metabolik dan obesitas, serta terjadinya hipertensi dalam kehamilan dan depresi postpartum (Dunkel Schetter & Tanner, 2012). Resiko kelahiran prematur meningkat sebesar 1,55 kali dibandingkan dengan kehamilan sehat. (Santos et al., 2021).

Tingkat kecemasan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ibu hamil maupun janin yang didalam kandungan. Tingkat kecemasan yang rendah pada ibu hamil dapat mengurangi komplikasi yang ditimbulkan sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi Angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia, sedangkan tingkat kecemasan yang tinggi dapat memperberat komplikasi yang terjadi dan meningkatkan AKI dan AKB, dimana dalam penelitian diambil sampel 45 responden ibu hamil yang mengalami tingkat kecemasan sedang mengalami hipertensi sebesar 52,7% sedangkan yang mengalami tingkat kecemasan tinggi mengalami preeklampsia sebesar 57,8% (Trisiani et al., 2016).

Untuk mengatasi kecemasan ini, maka dukungan dari orang terdekat (suami atau keluarga) benar-benar dibutuhkan. Cara menghilangkan kecemasan ini efektif. Mendengar pengalaman yang menenangkan akan lebih baik, sebab bagaimana pun juga seringkali ibu yang akan melahirkan justru terpapar oleh informasi-informasi yang semakin membuatnya khawatir.

Dukungan keluarga sangat diharapkan oleh seorang ibu hamil dalam menghadapi proses persalinan, dengan dukungan keluarga yang baik akan mengurangi stressor pada ibu sehingga proses persalinan lebih lancar dan cepat tanpa menimbulkan komplikasi. Para ibu yang didampingi oleh seorang sahabat atau keluarga dekat (khususnya suami selama proses

persalinan berlangsung memiliki resiko lebih kecil mengalami komplikasi yang memerlukan tindakan medis dari pada mereka yang tanpa pendampingan (dalam Arifin et al., 2015).

b. Ketakutan

Ketakutan berbeda dengan kecemasan. Kecemasan merupakan suatu bentuk kekhawatiran pada objek yang tidak jelas (hanya ada di pikiran dan tidak jelas bentuknya seperti apa). Sementara itu, ketakutan merupakan bentuk kekhawatiran pada sesuatu yang jelas objeknya. Dalam masa persalinan, seorang wanita bisa saja menjadi takut pada proses persalinan normal. Ia membayangkan apakah janin yang akan dilahirkannya selamat atau tidak. Atau kesakitan yang ada pada saat bersalinan apakah ia sanggup jalani atau tidak.

Untuk mengatasi ketakutan, maka seorang wanita perlu ditenangkan terlebih dahulu. Mendengarkan apa yang menjadi keluhannya adalah hal yang baik yang bisa dilakukan. Sikap menggurui atau memintanya berhenti takut justru tidak akan membantu mengurangi ketakutannya (Nababan, 2021).

c. Sikap Pasif

Sikap pasif timbul manakala seorang wanita hamil memiliki keengganan pada saat akan melahirkan. Ini juga didorong dengan dukungan yang lemah dari lingkungan sekitar. Perhatian suami dan keluarga yang kurang akan menimbulkan sikap yang pasif dari seorang Wanita hamil. Oleh karenanya, penting untuk memberikan dukungan kepadanya. Untuk mengatasi sikap pasif ini, kita bisa memberikan sistem dukungan yang baik berupa bentuk perhatian dan kasih sayang kepadanya. Bagaimana pun juga, hal ini akan sangat berpengaruh pada kelancaran proses persalinannya nanti (Nababan, 2021).

d. Hipermaskulin

Kondisi hipermaskulin menggambarkan bagaimana seorang calon ibu merasa goyah keinginannya, antara ingin atau tidak punya anak. Padahal, ia sudah berada di saat-saat menjelang persalinannya. Akibatnya, emosinya menjadi tidak stabil. Ini biasanya terjadi pada Wanita yang memang berkarir. Pikirannya menjadi buyar karena ia ingin mempertahankan cara dia bekerja, tetapi di sisi lain juga merindukan kehadiran anak. Gangguan psikologi pada masa reproduksi bisa menjadi salah satu penyebabnya.

Untuk mengatasi hal ini maka kita bisa memberikan sistem dukungan yang baik. mendengarkan keluhannya dan sama-sama mencari penyelesaian bersama adalah hal yang tepat untuk dilakukan (Nababan, 2021).

e. Hiperaktif

Menjelang persalinan, seorang wanita juga bisa menjadi lebih hiperaktif karena ia ingin segera melaksanakan proses persalinan. Oleh karenanya, ia menjadi lebih banyak beraktivitas demi proses persalinan yang berlangsung sesegera mungkin. Menenangkan ibu hamil dengan cara memberikan pengertian- pengertian tentang proses persalinan adalah hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. psikologi konseling juga bisa dilakukan agar wanita menjadi lebih siap(Nababan, 2021).

f. Kompleks Maskulin

Kompleks maskulin adalah bentuk dari hiperaktif yang tidak tertangani. Pada saat persalinan, seorang wanita menjadi lebih agresif lagi. Sikapnya menunjukkan bahwa proses persalinan yang ia alami harus segera selesai dan tidak ingin membuang-buang waktu. Sikapnya menjadi lebih pengatur pada orang-orang di sekitarnya. Untuk mengatasi gangguan psikologi pada masa persalinan ini, maka ada baiknya tenaga medis yang membantu persalinan menghadirkan orang paling terdekatnya (suami) (Nababan, 2021).

g. Halusinasi Hipnagonik

Pada saat akan bersalin, seorang wanita pasti akan mengalami kontraksi. Ada fase istirahat selama kontraksi tersebut. Seorang ibu bisa mengalami kondisi tidur semu. Di sinilah terjadi kondisi halusinasi hipnagonik. Ia akan menjadi tidak tenang karena muncul pikiran-pikiran yang tidak-tidak. Bahkan, kadang bisa juga muncul gangguan psikosomatis. Untuk mengatasinya, maka kita bisa tetap mempertahankan interaksi pada ibu menjelang persalinan (Nababan, 2021).

h. *Sindrom Baby Blues*

Biasanya terjadi setelah proses persalinan. *Bounding attachment* yang kurang baik menyebabkan seorang ibu justru menolak kehadiran bayinya. Oleh karenanya, dukungan berupa pemberian motivasi dan juga langkah-langkah untuk siap mengalami perubahan status menjadi ibu bisa diberikan supaya sindrom ini tidak terjadi (Nababan, 2021).

3) Kebutuhan Psikologis Masa Persalinan

a) Pemberian Sugesti

Tujuan dari pemberian sugesti adalah untuk memberikan pengaruh pada ibu dengan pemikiran yang dapat diterima secara logis. Sugesti yang diberikan berupa **sugesti positif** yang mengarah pada Tindakan memotivasi ibu untuk melalui proses persalinan sebagaimana mestinya. Adapun sugesti positif yang diberikan yaitu dengan mengatakan pada ibu bahwa proses persalinan yang ibu hadapi akan berjalan lancar dan normal, ucapkan hal tersebut berulang kali untuk memberikan keyakinan pada ibu

bahwa segalanya akan baik-baik saja. Bidan juga dituntut untuk selalu bersikap ramah dan sopan, dan menyenangkan hati ibu dan suami/keluarga. Sikap ini akan menambah besarnya sugesti yang telah diberikan (Suwanti & Kurniarum, 2015)

Psikologi ibu hamil yang merasakan cemas dapat mempengaruhi power, dalam hal ini kontraksi uterus. Kecemasan yang muncul pada ibu hamil jika tidak ditangani dengan tepat, maka akan memicu hormon stress pada hipotalamus yang nantinya dapat menyebabkan ketegangan otot tubuh termasuk ketegangan pada otot uterus sehingga kontraksi uterus menjadi inadkuat. Ibu hamil yang cemas dan takut akan proses persalinan, dapat mengeluarkan adrenalin. Adrenalin yang akan menghambat pelepasan oksitosin yang diperlukan untuk kemajuan persalinan. Pemberian sugesti positif dalam *hypnobirthing* dapat membantu ibu rileks dan siap menghadapi persalinan (Murdingsih et al., 2021).

Hal lainnya yang bisa dilakukan agar memiliki sugesti positif ialah dengan mengucapkan istighfar sama dengan sugesti diri agar otak terangsang untuk melepaskan hormon anti-stres dan terakhir mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an bisa membantu menenangkan pikiran yang gelisah, penuh amarah, dan cenderung negatif (Nurhayati, 2020). Pada penelitian didapatkan bahwa responden yang mengikuti Terapi Tadabbur Al'Qur'an mengalami penurunan kecemasan $p=0,032$ ($<0,05$) dibandingkan responden yang tidak mengikuti Terapi Tadabbur Al'Qur'an. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Terapi Tadabbur Al'Qur'an dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menurunkan kecemasan menjelang persalinan (Prapto et al., 2015).

b) Mengalihkan Perhatian

Mengalihkan perhatian dalam masa persalinan dimana mengalihkan perhatian dari rasa sakit yang dihadapi selama proses persalinan berlangsung dapat mengurangi rasa sakit yang sebenarnya. Secara psikologis, apabila ibu merasakan sakit, dan bidan tetap focus pada rasa sakit dengan menaruh rasa empati/belas kasihan yang berlebihan, maka rasa sakit justru akan bertambah. Saat kontraksi berlangsung dan ibu masih tetap merasakan nyeri pada ambang yang tinggi, maka upaya-upaya mengurangi rasa nyeri misal dengan teknik relaksasi, pengeluaran suara, dan atau pijatan harus tetap dilakukan (Suwanti & Kurniarum, 2015).

Pada hasil jurnal penelitian menunjukkan bahwa perbandingan tingkat intensitas nyeri pada kelompok kontrol pada *pre test* dan *post test* menunjukkan $p=0,051 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat perbedaan

intensitas nyeri sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok kontrol. Sedangkan perbandingan intensitas nyeri pada kelompok yang mendapatkan kombinasi teknik relaksasi dan pijatan *pre-test* dan *post-test* diperoleh hasil $p=0,001<0,05$ yang berarti terdapat perbedaan yaitu adanya penurunan intensitas nyeri sebelum dan sesudah pemberian kombinasi teknik relaksasi dan pijatan sebesar 2,93. Terdapat hubungan antara pemberian kombinasi teknik relaksasi dan pijatan terhadap lama waktu persalinan dengan indikator pembukaan serviks ($p = 0,000$). Nilai APGAR Score pada bayi baru lahir antara kelompok yang mendapatkan kombinasi teknik relaksasi dan pijatan 7-10 dikategorikan normal. Penerapan kombinasi teknik relaksasi dan pijatan dapat digunakan sebagai bagian integral dalam memberikan asuhan dasar pertolongan persalinan untuk membantu ibu mengurangi nyeri persalinan dan mempercepat proses persalinan (Ekayani, 2017).

Nyeri saat persalinan pada dasarnya disebabkan oleh kontraksi yang kuat saat persalinan dan merupakan hal alami. Setiap wanita memiliki rasa sakit yang berbeda. Nyeri dapat terjadi karena fisik atau lainnya faktor fisiologis atau bisa juga timbul karena emosi atau perasaan pada wanita tersebut. Hal ini karena dari faktor sugesti negatif yang masuk ke pikiran bawah sadar, dimana pikiran bawah sadar tidak dapat membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Ketegangan dan ketakutan yang dirasakan ibu menyebabkan nyeri saat persalinan, sehingga memperlambat proses persalinan. Nyeri persalinan dapat dikontrol dengan 2 metode, yaitu farmakologi dan non farmakologi. Metode pereda nyeri farmakologis adalah nyeri metode pereda nyeri menggunakan obat-obatan kimia, sedangkan metode non farmakologi adalah pereda nyeri secara alami metode tanpa menggunakan obat kimia dengan melakukan teknik relaksasi yang bersifat eksternal tindakan yang mempengaruhi respons internal individu melawan rasa sakit. Manajemen nyeri dengan tindakan relaksasi meliputi relaksasi otot, pernapasan dalam, pijat, meditasi dan perilaku. Studi Pustaka dalam sebuah penelitian *literatur review* menggunakan metode pengumpulan data dari studi penelusuran/penelusuran sistematik database terkomputerisasi (Pubmed, BMC, Cochrain review dan Google Scholar), dalam bentuk jurnal penelitian dan artikel ulasan. Teknik relaksasi pernapasan merupakan teknik yang bersifat nyeri teknik pertolongan yang memberikan masukan terbesar karena teknik relaksasi dalam persalinan dapat mencegah kesalahan berlebihan setelah melahirkan. Relaksasi pernapasan selama persalinan dapat mempertahankan komponen sistem saraf simpatik dalam keadaan hemostasis sehingga tidak terjadi peningkatan dalam suplai darah,

mengurangi kecemasan dan ketakutan sehingga ibu dapat beradaptasi dengan nyeri saat persalinan (Azizah et al., 2021).

c) Membangun Kepercayaan

1) Dukungan Bidan

Membangun kepercayaan pada masa persalinan dimana kepercayaan merupakan salah satu poin yang penting dalam membangun citra diri positif ibu dan membangun sugesti positif dari bidan. Ibu bersalin yang memiliki kepercayaan diri yang baik, bahwa proses persalinan yang dihadapi akan berjalan dengan lancar. Secara psikologis telah mengaktifkan alam bawah sadar ibu untuk bersikap dan berperilaku positif selama proses persalinan. Untuk membangun sugesti yang baik, ibu harus mempunyai kepercayaan pada bidan sebagai penolongnya. Bidan mampu melakukan pertolongan persalinan dengan baik sesuai standar, didasari pengetahuan dasar dan keterampilan yang baik serta mempunyai pengalaman yang cukup (Suwanti & Kurniarum, 2015).

Dalam penelitian terdapat hubungan dukungan bidan terhadap tingkat kecemasan, bahwa bidan harus berperan dalam memberikan pelayanan pada ibu bersalin, mencegah terjadinya depresi saat atau setelah melahirkan. Cemas menghadapi persalinan adalah hal yang wajar tetapi seorang bidan harus mampu menghadapi hal tersebut dan mampu memberikan motivasi serta solusi untuk menurunkan kecemasan ibu (Astutik Yuni & Sutriyani, 2017).

2) Dukungan Suami/Keluarga

Selain dukungan dari bidan, dukungan keluarga sangat diharapkan oleh seorang ibu hamil dalam menghadapi proses persalinan, dengan dukungan keluarga yang baik akan mengurangi stressor pada ibu sehingga proses persalinan lebih lancar dan cepat tanpa menimbulkan komplikasi. Para ibu yang didampingi oleh seorang sahabat atau keluarga dekat (khususnya suami selama proses persalinan berlangsung memiliki resiko lebih kecil mengalami komplikasi yang memerlukan tindakan medis dari pada mereka yang tanpa pendampingan (dalam Arifin et al., 2015). Dukungan keluarga adalah sikap tindakan dan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarga yang lainnya. Kecemasan dianggap sebagai salah satu faktor penghambat kinerja fungsi-fungsi kognitif seseorang seperti berkonsentrasi, mengingat, dan pemecahan masalah. Faktor yang mempengaruhi kecemasan yaitu potensi stressor, malnutrisi, keadaan

fisik, selisih usia, jenis kelamin pengetahuan, dan sosial ekonomi (dalam Arifin et al., 2015).

Dalam keluarga dukungan suami mempunyai hubungan yang lebih dominan terhadap tingkat kecemasan. Dukungan suami sangat penting bagi ibu bersalin karena suami adalah orang yang terdekat tentu sangat dibutuhkan. Suami merupakan *main supporter* (pendukung utama) pada masa kehamilan. Dukungan suami sangat penting bagi ibu bersalin mengingat ibu bersalin banyak mengalami kesulitan dan kecemasan dalam masa ini. Kehadiran pendamping persalinan selama proses persalinan dapat memberikan pengaruh positif terhadap ibu, dengan adanya pendamping persalinan (suami) ibu dapat berbagi rasa sakit dan suami dapat memberikan penghiburan pada istri dengan memegang tangan istri dan memberikan motivasi agar istri lebih kuat dalam menjalani proses persalinan. Kecemasan ibu bersalin akan meningkat seiring dimulainya persalinan, sehingga pengaruh motivasi dari suami sangat penting untuk menurunkan kecemasan tersebut (Astutik Yuni & Sutriyani, 2017).

3) Pengetahuan Ibu (dengan Pendidikan/Kelas Ibu Hamil)

Di Indonesia pendidikan ibu hamil/kelas ibu hamil disebut kelas ibu hamil. Beberapa Artikel penelitian dalam *systematic review* berfokus pada dampak kelas pada ibu hamil dimana kesehatan psikologis ibu hamil adalah tingkat ketakutan, kecemasan dan stres kesiapan ibu hamil dalam menghadapi persalinan (Rahardjo Putri et al., 2022). Stres kehamilan merangsang gangguan pada kesejahteraan ibu, janin selama kehamilan hingga pascapersalinan, seperti kehamilan dan depresi pascapersalinan lahir prematur. Stres meningkatkan hormon adrenalin dan menurunkannya oksitosin. Selain itu, stres dapat menyebabkan kekakuan otot pada ibu hamil mengganggu aktivitas otot rahim dan memperpanjang persalinan (Ghooshchian S, 2011).

Kelas ibu hamil dirancang untuk membantu para ibu mendapatkan informasi terkait kehamilan dan persalinan sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang mereka butuhkan. Kelas ibu hamil mulai berkembang dari segi kebutuhan materi, metode yang dipakai, dan peserta untuk meningkatkan efektifitas kelas ibu hamil sebagai sarana edukasi ibu hamil dan lingkungannya, khususnya suami (Fernández Fernández-Arroyo, n.d., 2020). Kelas ibu hamil juga memberikan intervensi pada aspek emosional dan

motivasi, sehingga memungkinkan ibu hamil untuk memberdayakan dirinya sendiri (Rezapour et al., 2021).

Dalam *systematic review* didapatkan salah satu kesimpulan bahwa partisipasi pada kelas ibu hamil dapat menurunkan tingkat stres ibu hamil apabila dibandingkan dengan ibu yang tidak mengikuti kelas ibu hamil (Çankaya & Şimşek, 2021). Dibandingkan dengan kelompok kontrol, ibu yang mengikuti pendidikan antenatal lebih banyak *self-efficacy* persalinan, dukungan dan kontrol yang dirasakan lebih besar dalam kelahiran, dan lebih sedikit rasa takut akan kelahiran dan gejala Gangguan Stres Pascatrauma setelah melahirkan (semua perbandingan, $p < 0,05$) (Gökçe İsbir et al., 2016).

Menurut analisa peneliti, pemberian intervensi kelas ibu hamil dapat menurunkan tingkat stres karena materi dan metode yang diberikan dapat memberikan stimulasi berupa informasi sehingga menjadikan ibu sampai dengan tahapan *application* terhadap informasi tersebut. Dalam studi kualitatif, mayoritas wanita yang berpartisipasi dalam program persiapan persalinan melaporkan bahwa informasi yang mereka terima membantu mereka mengurangi kecemasan selama kehamilan dan persalinan (Miquelutti et al., 2013). Pengetahuan tentang persalinan dan informasi yang salah tentang persalinan akan menyebabkan ketakutan. Pendidikan antenatal efektif dalam mengurangi ketakutan karena memberikan informasi tentang kelahiran dan secara positif mengubah informasi yang salah tentang kelahiran (Rahardjo Putri et al., 2022).

Selain menurunkan nyeri, kecemasan dan ketakutan, kelas ibu hamil dapat meningkatkan efikasi diri persalinan/persiapan persalinan, menurunkan trauma dan stres pasca persalinan. Informasi yang diberikan secara terprogram dalam kelas ibu hamil memungkinkan seorang ibu dan keluarga untuk memberdayakan diri menghadapi proses persalinan yang akan dihadapi. Peningkatan pemahaman terkait tanda bahaya, proses persalinan, pendampingan dan pengurangan nyeri dengan teknik relaksasi menjadi salah satu upaya persiapan persalinan normal pada ibu hamil trimester III (Kalayil Madhavanprabhakaran et al., 2016).

Dengan memberikan materi dan fasilitator yang disesuaikan dengan usia kehamilan pada pelaksanaan kelas ibu hamil, dapat meningkatkan pengetahuan yang benar dan informasi yang salah dapat dikurangi. Selain itu, interaksi dan berbagi pengalaman yang nyata di antara peserta kelas ibu hamil dapat menjadi cara untuk meningkatkan pengetahuan pengalaman dan mengubah sikap dan

perilaku untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan ibu hamil (Andriani et al., n.d, 2016). Ada 6 prinsip yang ada pada kelas ibu hamil dan telah ada sejak 60 tahun yang lalu, antara lain: mengutamakan persalinan alami, bebas bergerak/memilih posisi saat persalinan, dukungan keluarga dan tenaga kesehatan, menghindari intervensi rutin yang tidak perlu, menghindari posisi terlentang terlalu lama dan rawat gabung antara ibu dan bayi (Lothian, 2016).

D. Kesimpulan

Adapun faktor psikologis ibu selama persalinan ialah kekhawatiran, takut dan kematian, trauma akan kelahiran, perasaan bersalah, kecemasan, gelisah, narsistis, stress, konflik batin, sedih sekaligus bahagia.

Faktor psikologis yang dialami ibu dapat menjadi masalah dan mengganggu selama proses persalinan, adapun masalah psikologis masa persalinan diantaranya kecemasan, ketakutan, sikap pasif, hipermaskulin, hiperaktif, kompleks maskulin, halusinasi hipnagonik, serta sindrom *baby blues*.

Pemenuhan kebutuhan psikologis pada ibu bersalin harus diperhatikan dengan baik oleh bidan, karena keadaan psikologis ibu bersalin sangat berpengaruh pada proses dan hasil akhir persalinan. Kebutuhan ini berupa dukungan emosional baik dari bidan maupun pendamping persalinan (suami/anggota keluarga). Komunikasi efektif antara bidan dengan ibu bersalin dan pendamping persalinan, merupakan poin terpenting dalam pemenuhan kebutuhan psikologis ibu bersalin. Kebutuhan psikologis ibu bersalin dapat terpenuhi dengan baik melalui upaya: memberikan sugesti positif, mengalihkan perhatian terhadap rasa sakit dan ketidaknyamanan selama persalinan,, membangun kepercayaan dengan komunikasi yang efektif, serta meningkatkan pengetahuan ibu dalam mempersiapkan persalinan dengan mengikuti pendidikan/ kelas ibu hamil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung. (2020, November 15). *AKI di Indonesia Masih Tinggi*. <https://Ugm.Ac.Id/Berita/17548-Aki-Diindonesia-Masih-Tinggi>.
- Andriani, Y., Hari Respati, S., & Parama Astirin, O. (n.d.). Effectiveness of Pregnant Woman Class in The Prevention of Pregnancy Anemia in Banyuwangi, East Java. *Journal of Maternal and Child Health*, 2016(4), 230–241. <https://doi.org/10.26911/thejmch.2016.01.04.04>
- Archadi, E. L. (2019). *Kematian Maternal dan Neonatal di Indonesia*.
- Arifin, A., Kundre, R., Rompas, S., Studi, P., Keperawatan, I., Kedokteran, F., Sam, U., & Manado, R. (2015). *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kecemasan Ibu Hamil Menghadapi Proses Persalinan Di Puskesmas Budilatama Kecamatan Gadung Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah* (Vol. 3).
- Astutik Yuni, V., & Sutriyani, T. (2017). Hubungan Senam Hamil, Dukungan Suami dan Dukungan Bidan dengan Tingkat Kecemasan Ibu Menjelang Persalinan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 5(1), 140–148. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/care/article/view/399/397>
- Azizah, N., Eka Rahmawati, V., Vitiasari Dessy, F., Ilmu Kesehatan, F., Pesantren Tinggi Darul, U., & Jombang, U. (2021). Teknik Relaksasi dalam Proses Persalinan : Literatur Review. *JURNAL EDUNursing*, 5(2). <http://journal.unipdu.ac.id>
- Çankaya, S., & Şimşek, B. (2021). Effects of Antenatal Education on Fear of Birth, Depression, Anxiety, Childbirth Self-Efficacy, and Mode of Delivery in Primiparous Pregnant Women: A Prospective Randomized Controlled Study. *Clinical Nursing Research*, 30(6), 818–829. <https://doi.org/10.1177/1054773820916984>
- Dunkel Schetter, C., & Tanner, L. (2012). Anxiety, depression and stress in pregnancy: Implications for mothers, children, research, and practice. In *Current Opinion in Psychiatry* (Vol. 25, Issue 2, pp. 141–148). <https://doi.org/10.1097/YCO.0b013e3283503680>
- Ekayani, K. N. P. (2017). Kombinasi Teknik Relaksasi Dan Pijatan Bagi Ibu Bersalin Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri, Lama Persalinan Dan Apgar Score Bayi Baru Lahir. *Jurnal Kesehatan Prima*, 11(2), 93–103. <https://poltekkes-mataram.ac.id/wp-content/uploads/2018/01/2.-Ni-Putu-Ekayani.pdf>
- Fadillah, G., Si, S., Reni, M. S., Istiningrumm, B., Sc, M., Letak, T., Cover, /, Arrosyid, R., Ruwindya, Y., Diterbitkan, A. M., Diii, :, Kimia, A., Matematika, F., Ilmu, D., & Alam, P. (2018). *SEMINAR NASIONAL VOKASI INDONESIA*. 1.
- Fernández Fernández-Arroyo, M. (n.d.). *Childbirth Education: Comparative Analysis*. www.intechopen.com

- Ghooshchian S. (2011). The role of fear of pain and related psychological variables in prediction of cesarean labor. In *Original Article) AMUJ (Arak Medical University Journal* (Vol. 14, Issue 56).
- Gökçe İsbir, G., İnci, F., Önal, H., & Yıldız, P. D. (2016). The effects of antenatal education on fear of childbirth, maternal self-efficacy and post-traumatic stress disorder (PTSD) symptoms following childbirth: an experimental study. *Applied Nursing Research*, 32, 227–232. <https://doi.org/10.1016/j.apnr.2016.07.013>
- Husnul Lail, N. (2019). *Modul Asuhan Kebidanan Komprehensif*.
- Ibu Hamil Terhadap Kesehatan Psikologis Ibu Hamil dan Persiapan Persalinan, K., Rahardjo Putri, N., Amalia, R., & Indri Kusmawati, I. (2022). Kelas Ibu Hamil Terhadap Kesehatan Psikologis Ibu Hamil dan Persiapan Persalinan: Systematic Review. *Indonesian Journal of Midwifery (IJM)*, 5(1). <http://jurnal.unw.ac.id/index.php/ijm> Available at: <http://jurnal.unw.ac.id:1254/index.php/ijm/issue/view/125>
- Isnaini, I., Hayati, E. N., & Bashori, K. (2020). Identifikasi Faktor Risiko, Dampak dan Intervensi Kecemasan Menghadapi Persalinan pada Ibu Hamil Trimester Ketiga. *Analitika*, 12(2), 112–122. <https://doi.org/10.31289/analitika.v12i2.3382>
- Kalayil Madhavanprabhakaran, G., Sheila D’Souza, M., & Nairy, K. (2016). Effectiveness of Childbirth Education on Nulliparous Women’s Knowledge of Childbirth Preparation, Pregnancy Anxiety and Pregnancy Outcomes. *Nursing and Midwifery Studies*, 6(1). <https://doi.org/10.5812/nmsjournal.32526>
- Kementrian Kesehatan RI. (2014, September). *Situasi Kesehatan Ibu*. [Www.Depkes.Go.Id](http://www.depkes.go.id).
- Lothian, J. (2016). Does Childbirth Education Make a Difference? *The Journal of Perinatal Education*, 25(3), 139–141. <https://doi.org/10.1891/1058-1243.25.3.139>
- Miquelutti, M. A., Cecatti, J. G., & Makuch, M. Y. (2013). *Antenatal education and the birthing experience of Brazilian women: a qualitative study*. <http://www.biomedcentral.com/1471-2393/13/171>
- Murdingsih, Rohmah, & Prilisia Anggraini, S. (2021). Pengaruh Sugesti Positif terhadap Kecemasan Ibu Bersalin. *Journal Complementary of Health*, 1, 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.36086/jch.v1i1.1112>
- Nababan, L. (2021). *Modul Ajar Psikologi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas*.
- Nurhayati, E. (2020). *Psikologi Kehamilan dalam Perspektif Al-Qur’an*. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/429/1/2020-ENENG%20NURHAYATI-14043010163.pdf>
- Prapto, D. A. P., Fuad, H., & Rumiani, N. (2015). *Al-Qur’an Tadabbur Therapy to Reduce Anxiety on the First Delivery*. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/intervensipsikologi.vol7.iss2.art1>

- Rezapour, T., Barzegari, M., Sharifi, E., Malmir, N., Ghiasvand, H., Salehi, M., Noroozi, A., & Ekhtiari, H. (2021). Neuroscience-Informed Psychoeducation for Recovery: A Program to Promote Metacognition in People With Substance Use Disorders. *Basic and Clinical Neuroscience*, 12(5), 597–606. <https://doi.org/10.32598/bcn.2021.809.3>
- Santos, J. L., Moreira, F., Ribeiro, P. F., Canadas, M. J., Novais, A., & Lomba, A. (2021). A farming systems approach to linking agricultural policies with biodiversity and ecosystem services. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 19(3), 168–175. <https://doi.org/10.1002/fee.2292>
- Soma-Pillay, P., Nelson-Piercy, C., Tolppanen, H., & Mebazaa, A. (2016). Physiological changes in pregnancy. *Cardiovascular Journal of Africa*, 27(2), 89–94. <https://doi.org/10.5830/CVJA-2016-021>
- Suwanti, E., & Kurniarum, A. (2015). *Modul 4 Kebutuhan Dasar Ibu Bersalin*. https://www.slideshare.net/pjj_kemenkes/modul-4-kb-2-kebutuhan-psikologis-ibu-bersalin
- Trisiani, D., Hikmawati, R., Bhakti, S., & Bandung, K. (2016). *Hubungan Kecemasan Ibu Hamil Terhadap Kejadian Preeklampsia Di Rsud Majalaya Kabupaten Bandung: Vol. I* (Issue 3).
- Untari, M. M., & Rohmah, F. A. (2016). Kecemasan Ibu Hamil Ditinjau Dari Intensitas Membaca Al-Qur'an Dan Kelompok Usia. *Indonesian Psychological Jurnal*, 13.
- World Health Organization. (2019, September). *Maternal Mortality*. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/maternal-mortality>

BAB 5

PEMERIKSAAN FISIK PADA IBU BERSALIN

Diani Magasida, S.Si.T.,M.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 5

PEMERIKSAAN FISIK PADA IBU BERSALIN

Diani Magasida, S.Si.T., M.Keb

A. Pendahuluan

Dalam memberikan asuhan kebidanan persalinan pada ibu, bidan dituntut untuk dapat menganalisa data, mendiagnosis masalah, melakukan rencana asuhan dan evaluasi terhadap ibu. Pengkajian merupakan tahap yang paling utama dalam proses asuhan kebidanan, dimana pada tahap ini bidan melakukan pengkajian data yang diperoleh dari hasil anamnesis riwayat kesehatan ibu dan keluarga dan pemeriksaan fisik. Setelah melakukan pengkajian selanjutnya bidan melakukan pemeriksaan fisik dan mendiagnosis masalah sehingga rencana asuhan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan ibu.

B. Tujuan

Melalui pengalaman belajar di laboratorium, mahasiswa mampu:

1. Memahami pemeriksaan fisik secara umum
2. Melakukan penilaian segera (*rapid assessment*) pada ibu bersalin
3. Memeriksa Riwayat Persalinan Terdahulu
4. Mengenali Tanda & Gejala Kegawayan pada Persalinan
5. Melakukan Pemeriksaan Fisik pada Ibu Bersalin
6. Melakukan Asuhan Sayang Ibu

C. Pembahasan

1. Definisi Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik adalah sebuah proses dari seorang ahli medis memeriksa tubuh pasien untuk menemukan tanda klinis penyakit. Hasil pemeriksaan akan dicatat dalam rekam medis. Rekam medis dan pemeriksaan fisik akan membantu dalam penegakan diagnosis dan perencanaan perawatan pasien. Biasanya, pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis, mulai dari bagian kepala dan berakhir pada anggota gerak. Setelah pemeriksaan organ utama diperiksa dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, beberapa tes khusus mungkin diperlukan seperti test neurologi. (Manalau, 2016)

Pemeriksaan fisik merupakan proses pemeriksaan tubuh pasien untuk menentukan ada atau tidaknya masalah fisik. Tujuan pemeriksaan fisik adalah untuk mendapatkan informasi valid tentang kesehatan pasien. Pemeriksa harus dapat mengidentifikasi, menganalisis dan menyusun informasi yang terkumpul menjadi suatu penilaian komprehensif. (Sugiarto et al., 2018).

2. Penilaian Segera

Penilaian segera sangat diperlukan agar bidan dapat memutuskan perawatan atau tindakan darurat yang diperlukan untuk ibu bersalin dan untukantisipasi rujukan. Jika pada penilaian awal tidak ditemukan masalah, maka bidan perlu menggali riwayat kehamilan, persalinan dan penyakit ibu secara rinci kemudian melakukan pemeriksaan fisik untuk mengidentifikasi sejauh mana kemajuan persalinan ibu dan apakah temuan dari hasil anamnesis ibu akan mempengaruhi kemajuan tersebut.

2.1 Hal-hal yang Dilakukan dalam Penilaian Segera

- a. Hal yang Diperlukan
 - Buku KIA atau kartu status pasien
 - Partograf untuk mencatat kemajuan persalinan
 - Sarung tangan steril
 - Fetoscope untuk mendengarkan detak jantung bayi
 - Termometer untuk mengukur suhu ibu
 - Timer untuk menentukan Batasan waktu saat mengukur detak jantung janin dan denyut nadi ibu
 - Manset pengukur tekanan darah dengan stetoskop
 - Penyeka (3-4 bola kain kasa yang dibasahi dengan larutan antiseptik seperti savlon (*chlorhexidene 2-4%*) untuk membersihkan perineum sebelum melakukan vaginal exercise. Bisa menggunakan air hangat dan sabun jika tidak ada larutan antiseptik.
- b. Pengecekan Tanda-tanda Vital
 - Tekanan darah normal berkisar antara 90/60 mmHg hingga di bawah 140/90 mmHg.
 - Denyut nadi ibu kisaran normal adalah 80-100 denyut/menit dan tidak lebih besar dari 110 denyut/menit pada ibu bersalin
 - Suhu rata-rata 37°C, jika antara 37,5-38,4°C ibu mengalami demam ringan. Jika suhunya 38,5°C atau lebih ibu mengalami demam tinggi

2.2 Memeriksa Riwayat Persalinan Terdahulu

- a. Tanyakan tentang jumlah kehamilan dan kelahiran sebelumnya. Riwayat bisa dituliskan sebagai berikut :

Graviditas adalah jumlah total kehamilan sebelumnya, terlepas dari hasil, termasuk keguguran spontan atau aborsi sebelum 28 minggu masa kehamilan.

 - Gravidita 1 atau primigravida: kehamilan pertama
 - Gravidita 2: kehamilan kedua dan seterusnya
 - Multigravida: hamil dua kali atau lebih (jumlah tidak ditentukan)

Paritas adalah jumlah bayi yang dilahirkan hidup atau mati setelah 28 minggu kehamilan.

- Nullipara atau Para 0: tidak ada kehamilan yang mencapai 28 minggu
 - Primipara atau Para 1: satu kelahiran setelah 28 minggu
 - Para 2: dua kelahiran setelah 28 minggu
 - Multipara: dua atau lebih kelahiran setelah 28 minggu (jumlah tidak ditentukan)
 - Grand multipara: lima atau lebih kelahiran setelah 28 minggu
- b. Tuliskan hari taksiran persalinan janin
- Untuk mengetahui hari perkiraan lahir, bidan harus menanyakan kapan hari pertama haid terakhirnya (HPHT). Hal ini akan membantu dalam perhitungan perkiraan tanggal lahir dan usia kehamilan janin. Menghitung hari perkiraan lahir dan usia kehamilan akan membantu untuk mengidentifikasi apakah persalinan prematur, cukup bulan atau lebih bulan. Jika ibu tidak ingat HPHT maka bisa ditanyakan kapan dia pertama kali merasakan gerakan bayinya (mempercepat atau tendangan janin). Gerakan janin akan terasa pada minggu ke 18-20 pada primigravida ibu dan minggu ke 16-18 pada multigravida. (The Open University UK, 2015)

3. Tanda & Gejala Kegawatan pada Persalinan

Untuk menganamnesa tanda gejala kegawatan, bidan bisa bertanya kepada ibu terkait gejala apa saja yang mengarah pada kegawatan. Gejala kegawatan diantaranya, pendarahan vagina, sakit kepala terus-menerus, penglihatan kabur, kejang, kehilangan kesadaran, sakit perut epigastrium, demam, kebocoran cairan ketuban sebelum awal persalinan dan keputihan abnormal. Jika ibu melaporkan gejala bahaya di atas, rujuk ibu ke fasilitas kesehatan terdekat sesegera mungkin.

4. Pemeriksaan Fisik pada Ibu Bersalin

Pemeriksaan fisik pada ibu bersalin lebih difokuskan pada area abdomen, vagina dan serviks untuk memantau dilatasi serviks dan kemajuan persalinan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat dilakukan pemeriksaan, yaitu :

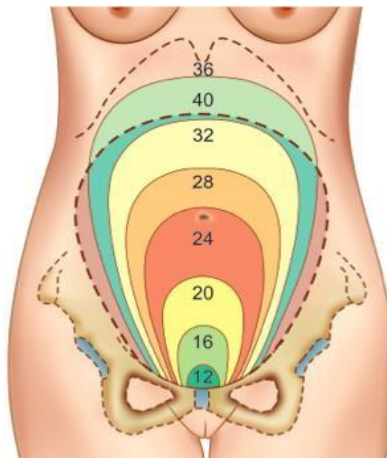
- a. Jaga privasi ibu
- b. Ikuti prinsip asuhan sayang ibu
- c. Periksa ibu secara komprehensif
- d. Carilah tanda-tanda anemia (pucat di dalam kelopak mata, kuku pucat dan gusi)
- e. Perhatikan perubahan warna kekuningan pada mata (jaundice), yang menandakan penyakit hati. (The Open University UK, 2015)

4.1 Pemeriksaan Abdomen

Aspek yang harus diperiksa pada abdomen ibu bersalin diantaranya yaitu ukuran, bentuk dan bekas luka.

a. Ukuran

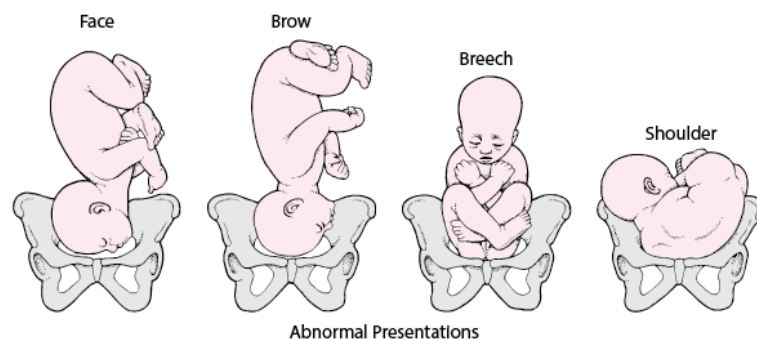
Periksa ukuran perut ibu, apakah sesuai dengan usia kehamilannya. Periksa keadaan janin, jika terlalu kecil mungkin kehamilan ibu tidak berkembang dengan baik atau jika perut ibu lebih besar dari usia kehamilan, ibu mungkin hamil dengan gemeli atau ibu mengalami kondisi yang disebut polihidramnion (kelebihan cairan ketuban). Jika perut ibu terlalu besar atau terlalu kecil, rujuk ibu ke fasilitas kesehatan.



Gambar 5.1
Tinggi Fundus Uteri Sesuai dengan Usia Kehamilan Ibu
(Chalid et al., 2019)

b. Bentuk

Periksa bentuk perut ibu apakah berbentuk oval? (sedikit lebih lebar di bagian atas rahim dan lebih sempit di segmen bawah). Jika iya, maka janin tunggal presentasi kepala, hanya saja perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut untuk mengetahui apakah pada serviks terba vertex, muka atau alis. Jika bentuknya bulat seperti bola, hal tersebut merupakan salah satu tanda malpresentasi (bokong atau bahu).



Gambar 5.2
Malpresentasi Janin

Pada gambar pertama, janin berekstensi maksimal sehingga oksiput berada dekat pada punggung janin dan menjadikannya presentasi muka. Pada gambar kedua, janin berekstensi sedang sehingga saat dilakukan pemeriksaan dalam akan teraba dahi dengan petunjuk teraba bagian sinsiput yang berada diantara ubun-ubun besar dan pangkal hidung. Pada gambar ketiga, yaitu presentasi bokong sehingga saat dilakukan pemeriksaan dalam maka akan teraba bagian bokong bayi. Pada gambar ke empat yaitu presentasi bahu karena letak bayi yang melintang pada uterus. Presentasi ini ditandai dengan letak kepala bayi pada satu sisi dan bokong pada sisi yang lain. Umumnya, posisi bokong lebih tinggi daripada kepala. (Nurhayati, 2019)

c. Bekas Luka

Amati apakah ibu memiliki bekas luka operasi dari persalinan sebelumnya? Bekas luka biasanya berada tepat di atas simfisis pubis. Jika sebelumnya ibu telah menjalani operasi SC, maka bidan bisa merujuknya ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaringan parut pada uterus dengan riwayat SC berisiko ruptur uteri selama persalinan saat ini. (The Open University UK, 2015)

4.1.1 Palpasi Abdomen

Palpasi berarti memeriksa perut ibu dengan tangan pada posisi tertentu atau memindahkannya dengan cara tertentu dan menggunakan tingkat tekanan tertentu. Pada pemeriksaan palpasi abdomen, minta ibu untuk berbaring telentang dan menekuk kakinya di lutut, dengan kakinya datar di tempat tidur.

Pada pemeriksana palpasi abdominal, dulakukan pemeriksaan Leopold, yaitu:

a. Leopold I

- Letakkan sisi lateral telunjuk kiri pada puncak fundus uteri untuk menentukan tinggi fundus. Perhatikan agar jari tersebut tidak mendorong uterus ke bawah (jika diperlukan, fiksasi uterus bawah dengan meletakkan ibu jari dan telunjuk tangan kanan dibagian lateral depan kanan dan kiri, setinggi tepi atas simfisis).
- Angkat jari telunjuk kiri (dan jari-jari yang memfiksasi uterus bawah) kemudian atur posisi pemeriksa sehingga menghadap ke bagian kepala ibu.
- Letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada fundus uteri dan rasakan bagian bayi yang ada pada bagian tersebut dengan jalan menekan secara lembut dan menggeser telapak tangan kiri dan kanan secara bergantian



Gambar 5.3
Pemeriksaan Leopold II
(Chalid et al., 2019)

b. Leopold II

- Letakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan dan telapaktangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara sejajar dan pada ketinggian yang sama.
- Mulai dari bagian atas, tekan secara bergantian atau bersamaan (simultan) telapak tangan kiri dan kanan, kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang (punggung) atau bagian-bagian kecil (eksteremitas).



Gambar 5.4
Pemeriksaan Leopold II
(Chalid et al., 2019)

c. Leopold III

Atur posisi pemeriksa pada sisi kanan dan menghadap ke bagian kepala ibu.

- Letakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah, telapaktangan kanan pada dinding lateral kanan bawah perut ibu.

- Tekan secara lembut dan bersamaan/bergantian untuk menentukan bagian terbawah bayi (bagian keras, bulat dan hampir homogen, adalah kepala sedangkan tonjolan yang lunak dan kurang simetris, adalah bokong).



Gambar 5.5
Pemeriksaan Leopold III
(Chalid et al., 2019)

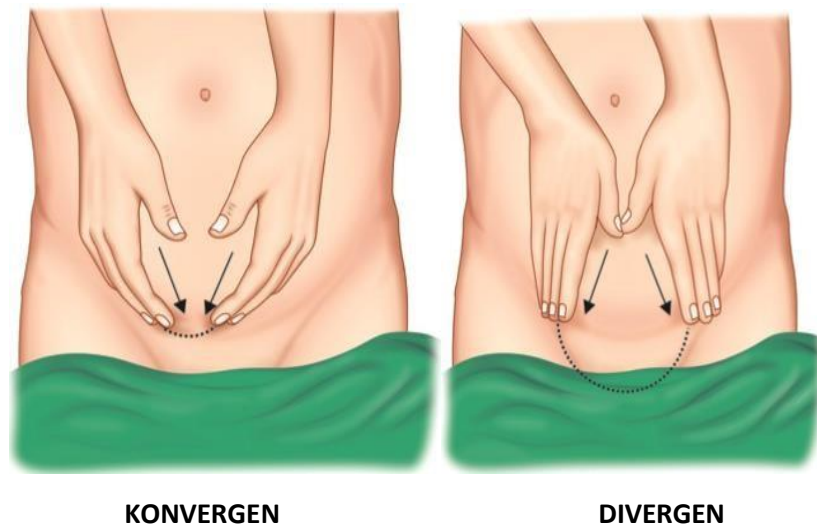
d. Leopold IV

- Letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus bawah, ujung-ujung jari tangan kiri dan kanan berada pada tepi atas simfisis.
- Temukan kedua ibu jari kiri dan kanan, kemudian rapatkan semua jari-jaritan yang meraba dinding bawah uterus.



Gambar 6
Pemeriksaan Leopold IV
(Chalid et al., 2019)

- Perhatikan sudut yang dibentuk oleh jari-jari kiri dan kanan (konvergen atau divergen)



Gambar 5.7

Kovergen dan Divergen

(Chalid et al., 2019)

- Setelah itu, pindahkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pada bagian terbawah bayi (bila presentasi kepala, upayakan memegang bagian kepala di dekat leher dan bila presentasi bokong, upayakan untuk memegang pinggang bayi).
- Fiksasikan bagian tersebut ke arah pintu atas panggul kemudian letakkan jari-jari tangan kanan di antara tangan kiri dan simfisis untuk menilai seberapa jauh bagian terbawah telah memasuki pintu atas panggul. (Chalid et al., 2019)

4.1.2 Pengukuran Detak Jantung Janin (DJJ)

Setelah kontraksi, periksa DJJ untuk mengukur denyut jantung janin. Hitung jumlah DJJ selama satu menit penuh setiap 30 menit sekali selama fase aktif kala I persalinan dan setiap 5 menit selama kala II persalinan. Bila ada kelainan denyut jantung janin (kurang dari 120 atau lebih dari 160 denyut per menit) dan terjadi terus menerus selama 10 menit, curigai adanya gawat janin dan segera rujuk ke fasilitas kesehatan, kecuali kemajuan persalinan berlangsung baik dan bayi dapat segera dilahirkan. (The Open University UK, 2015)

4.1.3 Penilaian Kontraksi Uterus

Untuk menilai frekuensi dan durasi kontraksi, letakkan tangan di atas perut ibu, di sekitar fundus. Kontraksi terjadi ketika perut mulai kencang dan menjadi keras. Hitung frekuensinya, yaitu jumlah kontraksi dalam 10 menit dan durasi (waktu berlalu selama setiap

kontraksi dalam hitungan detik). Masukkan hasil pengukuran kontraksi ke dalam partograph.

4.2 Pemeriksaan Vagina

Fungsi pemeriksaan vagina adalah untuk:

- a. Menentukan apakah ibu sudah memasuki fase persalinan dilihat dengan adanya tanda-tanda pasti persalinan
- b. Menilai kemajuan persalinan dengan mengukur peningkatan dilatasi serviks dan turunnya janin ke jalan lahir
- c. Mengidentifikasi presentasi dan posisi janin
- d. Mendeteksi molase pada tengkorak janin (sejauh mana mereka tumpang tindih di bawah tekanan dari jalan lahir)
- e. Mengkaji ukuran panggul ibu dan kecukupannya untuk jalan lahir janin
- f. Memeriksa warna cairan ketuban (The Open University UK, 2015)

4.2.1 Memeriksa Genitalia Eksterna dan Interna

Penilaian akhir pada pemeriksaan ibu bersalin ini adalah dengan melakukan pemeriksaan genitalia eksterna dan interna ibu untuk menilai adanya tanda-tanda sebagai berikut :

- Keluarnya cairan abnormal (kekuningan kental atau putih dan berbau busuk) dari vagina atau luka meradang pada genitalia eksterna ibu yang mungkin disebabkan oleh infeksi saluran kemih atau infeksi menular seksual.
- Bekas luka vagina karena cedera selama kelahiran sebelumnya, atau dari ibu pernah mendapatkan tindakan mutilasi alat kelamin (sunat perempuan) karena hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya fistula selama persalinan
- Ada pembengkakan di vagina dan jika ada apakah bisa menghalangi jalan keluarnya dari bayi?

Jika terdapat tanda-tanda di atas, maka ibu harus segera di rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi kecuali persalinan sudah lanjut dan bayi akan segera lahir.

5. Asuhan Sayang Ibu

- a. Memberikan Layanan yang Bisa Diterima Ibu, seperti :
 - 1) Menghormati kepercayaan, tradisi, dan budaya ibu
 - 2) Mempertimbangkan kesejahteraan emosional, psikologis, dan social ibu
 - 3) Memberikan saran yang relevan dan layak sesuai dengan kebutuhan ibu
- b. Mengupayakan pendampingan persalinan oleh suami atau keluarga ibu sehingga ibu bisa kooperatif selama masa persalinan. Bidan kemudian mengajari hal-hal yang perlu dilakukan saat mendampingi ibu selama

persalinan seperti memberikan motivasi, doa dan bidan memberitahukan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga.

- c. Mempertimbangkan dan menghormati hak-hak ibu:
 - 1) Haknya atas informasi tentang kesehatannya dan bayinya
 - 2) Haknya untuk mendapat informasi tentang proses persalinan dan kemajuan persalinan
 - 3) Haknya untuk memberikan atau menahan izin/persetujuannya untuk semua pemeriksaan dan prosedur.
- d. Setiap petugas menggunakan keterampilan interpersonal yang baik dan berkomunikasi secara efektif dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh ibu dan keluarga(The Open University UK, 2015)
- e. Temuan pemeriksaan fisik harus dijelaskan kepada ibu dan keluarga dan sehingga ibu dan keluarga mampu memutuskan untuk mendapatkan Tindakan atau ashan selanjutnya. (World Health Organization, 2020)

D. Kesimpulan

Pemeriksaan fisik pada ibu bersalin lebih difokuskan pada area abdomen, vagina dan serviks untuk memantau dilatasi serviks dan kemajuan persalinan. Pada pemeriksaan abdomen dilakukan pemeriksaan 3 S (*size, shape, scar*) atau ukuran, bentuk dan bekas luka pada abdomen, mengukur Detak Jantung Janin (DJJ) dan Mengukur kontraksi Uterus. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan vagina meliputi pemeriksaan genitalia interna dan eksterna. Terakhir adalah asuhan sayang ibu. Pada asuhan sayang ibu, bidan memberikan asuhan yang bisa diterima ibu, mengupayakan pendamping ibu selama persalinan, menghormati hak-hak ibu, KIE dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga.

DAFTAR ISI

- Chalid, M. T., Riu, D. S., Idrus, A., Susiawaty, & Wewengkang, E. (2019). *Manual Clinical Skill Lab Pemeriksaan Obstetri* (I. Sunarno & M. Farid (eds.); 1st ed.). Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin.
- Manalau, N. V. (2016). Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik oleh Perawat Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. *Jurnal Skolastik Keperawatan*, 2(1), 13–19.
- Nurhayati, E. (2019). *Patologi & Fisiologi Persalinan* (1st ed.). Pustaka Baru Press.
- Sugiarto, Harioputro, D. R., Suselo, Y. H., Munawaroh, S., Moelyo, A. G., Lestari, A., Werdiningsih, Y., & Suryawan, A. (2018). *Buku Manual Keterampilan Klinik Topik Basic Physical Examination : Teknik Inspeksi, Palpasi, Perkusi dan Auskultasi*. https://skillslab.fk.uns.ac.id/wp-content/uploads/2018/08/MANUAL-IPPA_2018-smt-1.pdf
- The Open University UK. (2015). *Labour and Delivery Care Blended Learning Module for the Health Extension Programme*. <https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=270&printable=1>
- World Health Organization. (2020). *WHO Labour Care Guide User's Manual* (1st ed.).

BAB 6

LANGKAH – LANGKAH PERSALINAN

Rina Octavia, S.ST,. Bd., M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 6.

LANGKAH – LANGKAH PERSALINAN

Rina Octavia, S.ST., Bd., M.Kes

A. Pendahuluan

Menurut *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2016 Angka Kemataian Ibu (AKI) di dunia 305 per 100.000 kelahiran hidup, AKI di negara berkembang 230 per 100.000 kelahiran hidup, AKI di Asia Timur 33 per 100.000 kelahiran hidup, Asian Selatan 190 per 100.000 kelahiran hidup, Asia Tenggara 140 per 100.000 kelahiran hidup, dan Asia Barat 74 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu di dunia adalah pra kondisi yang ada 28% hipertensi dalam kehamilan 14%, komplikasi abortus 8%, perdarahan 27%, infeksi 11%, partus lama dan lainnya 8%, dan pengumpulan darah (embolis) 3% (WHO, 2018).

Menurut WHO, pada tahun 2016 Angka Kematian Bayi di dunia 34 per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi di Negara maju 5 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi di Asia Timur 11 per 1.000 kelahiran hidup, Asia Selatan 43 per 1.000 kelahiran hidup, dan Asia Tenggara 24 per 1.000 kelahiran hidup. penyebab angka kematian bayi adalah *asfiksia* (kesulitan bernafas), *laturitas*, *hipotermi*, dan *infeksi*. Kesehatan ibu yang tidak baik dan penyakit ibu yang tidak diobati dengan benar juga dapat menyebabkan bayi lahir premature dan berat bayi lahir rendah (BBLR) di Indonesia mencapai 350.000 bayi setiap tahunnya. (WHO, 2018).

Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 100.000 kelahiran hidup di Indonesia, 305 di antaranya berakhir dengan kematian sang ibu (Profil Kesehatan Indonesia, 2015). Penyebab tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah perdarahan, eklampsia, aborsi tidak aman (*unsafe abortion*), partus lama dan infeksi (Profil Kesehatan Indonesia, 2017).

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan dari tahun ke tahun AKB mengalami penurunan signifikan. Dari 68 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada 1991, hingga 24 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 (SDKI, 2017).

Upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah AKI dan AKB dengan 5 strategi yaitu pertama, kerjasama dengan sektorterkait dan pemerintah daerah. Kedua pemberian Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), mulai tahun 2011 di puskesmas sudah berlaku dan sampai saat ini setiap puskesmas mendapatkan BOK. Ketiga menetapkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) berupa indikator komposit (status kesehatan, perilaku, lingkungan, dan akses pelayanan kesehatan). Keempat penempatan tenaga straregi (Dokter dan Bidan) dan penyediaan fasilitas

kesehatan di daerah-daerah. Kelima kementrian kesehatan membuat program baru untuk memberikan pelayanan KB yang berkualitas. (Kementrian Kesehatan RI, 2018).

Angka kematian ibu dan bayi merupakan tolat ukur dalam menilai kesehatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, melalui pembuatan berbagai program kesehatan, pemerintah berupaya keras menurunkan angka kematian ibu dan bayi, contohnya adalah dengan upaya Gerakan Sayang Ibu (GSI), *safe motherhood*, dan penempatan berbagai bidan diberbagai desa.

Pelaksanaan berbagai program kesehatan tersebut sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten agar dapat mencapai tujuannya, terutama bidan. Bidan berperan penting sebagai ujung tombak atau orang yang berada di garis terdepan karena merupakan tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan wanita sebagai sasaran program. Oleh sebab itu, bidan perlu senantiasa meningkatkan kompetensinya, salah satunya dengan meningkatkan pemahaman asuhan kebidanan mulai dari wanita hamil hingga nifas serta asuhan kebidanan untuk kesehatan bayi (Anita Lockhart RN. MSN, Dr. Lyndon Saputra, 2014).

Untuk mencegah mortalitas pada wanita hamil dilakukan kunjungan yang tepat dengan Kunjungan ANC paling sedikit 4 kali selama kehamilan yaitu jadwal asuhan cukup 4 kali dengan Pemeriksaan ANC yang lengkap adalah K1, K2, K3, dan K4. Hal ini berarti minimal dilakukan sekali kunjungan antenatal hingga usia kehamilan 28 minggu, sekali kunjungan ANC selama kehamilan 28 sampai 36 minggu, dan 2 kali kunjungan ANC pada usia kehamilan diatas 36 minggu. (Prawirohardjo, 2012).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik menulis tentang langkah – langkah persalinan normal sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Buku ini di tulis bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang langkah – langkah persalinan fisiologis, agar tenaga kesehatan khusus nya bidan dapat memberikan asuhan kebidanan persalinan fisiologis kepada semua pasien yang telah dilakukan pengkajian dan pemeriksaan saat pertama kali dating ke pusat layanan kesehatan.

2. Tujuan Khusus

- a. Bidan mampu melakukan pengkajian saat persalinan.
- b. Bidan mampu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada klien dalam proses persalinan.
- c. Bidan dapat menegakan diagnosa yang tepat dalam proses persalinan.
- d. Bidan mampu mengenali diagnosa potensial dalam proses persalinan.
- e. Bidan mampu merencanakan tindakan yang akan dilakukan dalam proses persalinan.

- f. Bidan mampu melakukan seluruh tindakan yang telah direncanakan dalam proses persalinan.
- g. Bidan mampu mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan dalam proses persalinan.

C. Pembahasan

1. 60 Langkah penatalaksanaan APN Menurut JNPK-KR (2017) :

Mengenali Gejala dan Tanda Kala II

- 1) Mendengar dan melihat tanda Kala Dua Persalinan
 - a) Ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran
 - b) Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rectum dan vagina
 - c) Perineum tampak menonjol
 - d) Vulva dan sfingter ani membuka

Menyiapkan pertolongan persalinan

- 2) Pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan menatalaksana komplikasi segera pada ibu dan bayi baru lahir.

Untuk asuhan bayi baru lahir atau resusitasi → siapkan :

- a) Tempat datar, rata, bersih, kering dan hangat
- b) 3 handuk kain bersih dan kering (termasuk ganjal bahu bayi)
- c) Alat penghisap lender
- d) Lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi

Untuk ibu :

- a) Menggelar kain di perut bawah ibu
- b) Menyiapkan oksitosin 10 IU
- c) Alat suntik steril pakai di dalam partus set
- 3) Pakai celemek plastic atau dari bahan yang tidak tembus cairan
- 4) Melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai, cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir kemudian keringkan tangan dengan tissue atau handuk pribadi yang bersih dan kering
- 5) Pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam
- 6) Masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik (gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT atau Steril dan pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik).

Memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin

- 7) Membersihkan vulva vagina dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari anterior (depan) ke posterior (belakang) menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi air DTT
 - a) Jika introitus vagina, perineum atau anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang
 - b) Buang kapas atau kasa pembersih (terkontaminasi) dalam wadah yang tersedia
 - c) Jika terkontaminasi, lakukan dekontaminasi, lepaskan dan rendam sarung tangan tersebut dalam larutan klorin 0,5 % → Langkah 9 #. Pakai sarung tangan DTT/Steril untuk melaksanakan Langkah lanjutan
- 8) Lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap
 - a) Bila selaput ketuban masih utuh saat pembukaan sudah lengkap maka lakukan amniotomi
- 9) Dekontaminasi sarung tangan (celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5 %, lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik, dan rendam dalam klorin 0,5 % selama 10 menit). Cuci tangan setelah sarung tangan dilepaskan dan setelah itu tutup kembali partus set
- 10) Periksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi uterus mereda (relaksasi) untuk memastikan DJJ masih dalam batas normal (120-160 x/menit)
 - a) Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal
 - b) Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ, semua temuan pemeriksaan dan asuhan yang diberikan ke dalam partograf

Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses meneran

- 11) Beritahukan pada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin cukup baik, kemudian bantu ibu menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya
 - a) Tunggu hingga timbul kontraksi atau rasa ingin meneran, lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin (ikuti pedoman penatalaksanaan fase aktif) dan dokumentasikan semua temuan yang ada
 - b) Jelaskan pada anggota keluarga tentang peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu dan meneran secara benar
- 12) Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran jika ada rasa ingin meneran atau kontraksi yang kuat. Pada kondisi itu, ibu diposisikan

setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman.

- 13) Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ingin meneran atau timbul kontraksi yang kuat :
 - a) Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif
 - b) Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai
 - c) Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya (kecuali posisi berbaring terlentang dalam waktu yang lama)
 - d) Anjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi
 - e) Anjurkan keluarga memberi dukungan dan semangat untuk ibu
 - f) Berikan cukup asupan cairan per-oral (minum)
 - g) Menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai
 - h) Segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir setelah pembukaan lengkap dan dipimpin meneran ≥ 120 menit (2 jam) pada primigravida atau ≥ 60 menit (1 jam) pada multigravida
- 14) Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam selang waktu 60 menit

Persiapan untuk melahirkan bayi

- 15) Letakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut bawah ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm
- 16) Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian sebagai alas bokong ibu
- 17) Buka tutup partus set dan periksa kembali kelengkapan peralatan dan bahan
- 18) Pakai sarung tangan DTT/Steril pada kedua tangan

Pertolongan untuk melahirkan bayi

Lahirnya Kepala

- 19) Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering, tangan yang lain menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi fleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu meneran secara efektif atau bernapas cepat dan dangkal
- 20) Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat (ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi), segera lanjutkan proses kelahiran bayi
 - a) Jika tali pusat melilit leher secara longgar, lepaskan lilitan lewat bagian atas kepala bayi

- b) Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di dua tempat dan potong tali pusat di antara dua klem tersebut.
- 21) Setelah kepala lahir, tunggu putaran paksi luar yang berlangsung secara spontan

Lahirnya Bahu

- 22) Setelah putaran paksi luar selesai, pegang kepala bayi secara biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang

Lahirnya badan dan tungkai

- 23) Setelah kedua bahu lahir, satu tangan menyangga kepala dan bahu belakang, tangan yang lain menelusuri lengan dan siku anterior bayi serta menjaga bayi terpegang baik
- 24) Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai dan kaki. Pegang kedua mata kaki (masukkan telunjuk diantara kedua kaki dan pegang kedua kaki dengan melingkarkan ibu jari pada satu sisi dan jari-jari lainnya pada sisi yang lain agar bertemu dengan jari telunjuk)

Asuhan bayi baru lahir

- 25) Lakukan penilaian (selintas) :
- a) Apakah bayi cukup bulan ?
 - b) Apakah bayi menangis kuat dan/ atau bernapas tanpa kesulitan?
 - c) Apakah bayi bergerak dengan aktif ?
- Bila salah satu jawaban adalah “TIDAK”, lanjut ke langkah resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia (lihat Penuntun Belajar Resusitasi Bayi Asfiksia)
- Bila semua jawaban adalah “YA”, lanjut ke-26
- 26) Keringkan tubuh bayi
- Keringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya (kecuali kedua tangan) tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/kain yang kering. Pastikan bayi dalam posisi dan kondisi aman di perut bagian bawah ibu.
- 27) Periksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir (hamil tunggal) dan bukan kehamilan ganda (gemelli)
- 28) Beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik

- 29) Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 unit (intramuskuler) di 1/3 distal lateral paha (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin)
- 30) Setelah dua menit sejak bayi lahir (cukup bulan), jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2-3 cm dari pusar bayi. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan yang lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu, dan klem tali pusat pada sekitar 2 cm distal dari klem pertama
- 31) Pemotongan dan pengikatan tali pusat
 - a) Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut
 - b) Ikat tali pusat dengan benang DTT/Steril pada satu sisi kemudian lingkarkan lagi benang tersebut dan ikat tali pusat dengan simpul kunci pada sisi lainnya
 - c) Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah di sediakan
- 32) Letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit ibu dan bayi. Luruskan bahu bayi sehingga dada bayi menempel di dada ibunya. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting susu atau areola mammae ibu
 - a) Selimuti ibu-bayi dengan kain kering dan hangat, pasang topi di kepala bayi
 - b) Biarkan bayi melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam
 - c) Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusui untuk pertama kali akan berlangsung 10-15 menit. Bayi cukup menyusui dari satu payudara
 - d) Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam walaupun bayi sudah berhasil menyusui

Manajemen Aktif Kala III Persalinan (MAK III)

- 33) Pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva
- 34) Letakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah ibu (di atas sipisis), untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat
- 35) Pada saat uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang-atas (dorso-kranial) secara hati-hati (untuk mencegah inversion uteri). Jika plasenta tidak lepas setelah 30-40 detik, hentikan peregangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya kemudian ulangi kembali prosedur di atas.

- a) Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu/suami untuk melakukan stimulasi putting susu.

Mengeluarkan Plasenta

- 36) Bila pada penekanan bagian bawah dinding depan uterus ke arah dorsal ternyata diikuti dengan pergeseran tali pusat ke arah distal maka lanjutkan dorongan ke arah kranial hingga plasenta dapat dilahirkan
- a) Ibu boleh meneran tetapi tali pusat hanya ditegangkan (jangan ditarik secara kuat terutama jika uterus tak berkontraksi) sesuai dengan sumbu jalan lahir (ke arah bawah sejajar lantasi atas)
- b) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta
- c) Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat :
- Ulangi pemberian oksitosin 10 unit IM
 - Lakukan kateterisasi (gunakan teknik aseptik) jika kandung kemih penuh
 - Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan
 - Ulangi tekanan dorso-kranial dan penegangan tali pusat 15 menit berikutnya
 - Jika plasenta tak lahir dalam 30 menit sejak bayi lahir atau terjadi perdarahan maka segera lakukan tindakan plasenta manual
- 37) Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpelepas kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan
- a) Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput kemudian gunakan jari-jari tangan atau klem ovum DTT/Steril untuk mengeluarkan selaput yang tertinggal

Rangsangan Taktil (Masase) Uterus

- 38) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus, letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi (fundus teraba keras)
- a) Lakukan Tindakan yang diperlukan (Kompresi Bimanual Internal, Kompresi Aorta Abdominalis, Tampon Kondom Kateter) jika uterus tidak berkontraksi dalam 15 detik setelah rangsangan taktil/masase. (lihat penatalaksanaan atonia uteri)

Menilai Perdarahan

- 39) Evaluasi kemungkinan perdarahan dan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila terjadi laserasi derajat 1 atau derajat 2 dan atau menimbulkan perdarahan. *Bila ada robekan yang menimbulkan perdarahan aktif, segera lakukan penjahitan*
- 40) Periksa kedua sisi plasenta (maternal-fetal) pastikan telah dilahirkan lengkap. Masukkan plasenta ke dalam kantung plastic atau tempat khusus

Asuhan pasca persalinan

- 41) Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam
- 42) Pastikan kandung kemih kosong. Jika penuh, lakukan kateterisasi

Evaluasi

- 43) Celupkan tangan yang masih memakai sarunga tangan kedalam larutan klorin 0,5%, bersihkan noda darah dan cairan tubuh, dan bilas di air DTT tanpa melepas sarung tangan kemudian keringkan dengan tissue atau handuk pribadi yang bersih dan kering
- 44) Ajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi
- 45) Memeriksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik
- 46) Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah
- 47) Pantau keadaan bayi dan pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik (40-60 x/menit)
 - a) Jika bayi sulit bernapas, merntih, atau retraksi, di resusitasi dan segera merujuk ke rumah sakit
 - b) Jika bayi napas terlalu cepat atau sesak napas, segera rujuk ke RS Rujukan
 - c) Jika kaki teraba dingin, pastikan ruangan hangat. Lakukan kembali kontak kulit ibu-bayi dan hangatkan ibu-bayi dalam satu selimut.

Kebersihan dan keamanan

- 48) Bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Bersihkan cairan ketuban, lendir dan darah di ranjang atau disekitar ibu berbaring. Menggunakan larutan klorin 0,5% lalu bilas dengan air DTT. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering
- 49) Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang ia inginkan

- 50) Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi
- 51) Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai
- 52) Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%
- 53) Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, lepaskan sarung tangan ke dalam keadaan terbalik dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit
- 54) Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian keringkan tangan dengan tissue atau handuk pribadi yang bersih dan kering
- 55) Pakai sarung tangan bersih/DTT untuk memberikan vitamin K1 (1mg) intramuskuler di paha kiri anterolateral dan salep mata profilaksis infeksi dalam 1 jam pertama kelahiran
- 56) Lakukan pemeriksaan fisik lanjutan (setelah 1 jam kelahiran bayi). Pastikan kondisi bayi tetap baik. (pernafasan normal 40-60 x/menit dan temperature tubuh normal 36.5 – 37.5 °C) setiap 15 menit
- 57) Setelah satu jam pemberian vitamin K1 berikan suntikan imunisasi Hepatitis B di paha kanan bawah lateral. Letakkan bayi didalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu dapat di susukan
- 58) Lepaskan sarung tangan ke dalam keadaan terbalik dan direndam di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit
- 59) Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian keringkan dengan tissue atau handuk pribadi yang masih bersih dan kering.

Dokumentasi

- 60) Lengkapi partograph (halaman depan dan belakang)

2. Pembahasan langkah – langkah dalam proses persalinan

Setelah Bidan menguasai langkah – langkah proses persalinan dengan tepat, maka selama proses persalinan bidan harus mampu melakukan pengkajian dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh agar dapat menegakan diagnosa persalinan. Dalam hal ini bidan dapat mengidentifikasi masalah dan diagnosa potensial yang terjadi pada klien tersebut, yang nantinya akan mempengaruhi rencana tindakan yang akan dilakukan selama proses persalinan berlangsung.

Langkah – langkah proses persalinan akan berjalan dengan fisiologis jika sejak awal tidak dilakukan intervensi yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Setelah dilakukan dengan benar langkah – langkah proses persalinan maka akan mempengaruhi hasil akhir dari proses persalinan. Selain itu proses persalinan juga di pengaruhi oleh 5 faktor, yaitu *power, pasanger, passage,*

penolong dan psikologi. Dalam faktor penolong, di harapkan melakukan langkah yang sesuai dengan prosedur.

Setiap langkah dalam proses persalinan dilakukan atas dasar keadaan klien selama proses persalinan berlangsung, mulai dari kala 1, kala 2, kala 3 sampai kala 4 persalinan. Selain itu Bidan juga harus melakukan pendokumentasian catatan perkembangan dan Partograf (alat bantu menilai kemajuan persalinan). Dalam pencatatan proses persalinan ini akan terlihat secara menyeluruh keadaan klien dan semua langkah yang dilakukan penolong secara tepat.

Seiring berkembang nya pengetahuan melalui penelitian yang ada, maka Langkah – langkah persalinan fisiologi juga semakin merubah perilaku tenaga kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan, untuk itu bidan sebagai penolong persalinan wajib melakukan langkah – langkah pertolongan persalinan yang sesuai dengan prosedur, sehingga dapat mengurangi resiko terjadi nya angka kematian ibu dan bayi.

Langkah – langkah persalinan saat ini yang dilakukan oleh tenaga kesehatan khusus nya bidan sudah mengurangi angka kematian ibu dan bayi, namun tetap harus dikembangkan lagi agar angka – angka tersebut tidak muncul dari penyebab persalinan. Sehingga proses persalinan dapat berjalan sesuai diagnosa yang telah ditegakan di awal.

Dalam melakukan langkah – langkah proses persalinan harus melihat kondisi klien agar dapat mengetahui masalah potensial ataupun diagnosa potensial yang terjadi selama proses persalinan. Dalam melakukan proses persalinan sebaiknya sesuai dengan urutan yang telah di tetapkan agar dapat mengurangi resiko yang terjadi baik untuk ibu maupun bayi.

Sebagai contoh tahapan persalinan yang dilakukan bidan yang berubah dari 58 langkah menjadi 60 langkah asuhan persalinan normal adalah sebagai berikut :

TABEL 6.1
PERBANDINGAN ASUHAN PERSALINAN NORMAL
ANTARA 58 LANGKAH DAN 60 LANGKAH

58 LANGKAH		60 LANGKAH	
I. Gejala dan tanda Kala 2		I. Gejala dan tanda Kala 2	
1	Dengar, lihat dan periksa	1	Dengar dan lihat
	Dorongan meneran, tekanan anus, perineum menonjol, vulva membuka		Dorongan meneran, tekanan anus, perineum menonjol, vulva membuka
II. Siap pertolongan persalinan		II. Siap pertolongan persalinan	
2	Siap alat, bahan dan obat - obatan	2	Siap alat, bahan dan obat - obatan
	Resusitasi		Resusitasi
	Gelar kain		Gelar kain
	Oksitosin dan alat suntik dalam partus set		Oksitosin dan alat suntik dalam partus set
3	Alat Pelindung Diri (APD)	3	Alat Pelindung Diri (APD)
4	Cuci tangan	4	Cuci tangan
5	Pakai sarung tangan Disinfektan Tingkat Tinggi (DTT)	5	Pakai sarung tangan Disinfektan Tingkat Tinggi (DTT)
6	Masukan Oksitosin	6	Masukan Oksitosin
III. Memastikan pembukaan lengkap		III. Memastikan pembukaan lengkap	
7	Vulva Hygienie	7	Vulva Hygienie
8	Periksa dalam	8	Periksa dalam
9	Dekontaminasi sarung tangan	9	Dekontaminasi sarung tangan
10	Periksa Denyut Jantung janin (DJJ)	10	Periksa Denyut Jantung janin (DJJ)
IV. Siap Ibu dan Keluarga		IV. Siap Ibu dan Keluarga	
11	Beritahu dan siapkan posisi ibu	11	Beritahu dan siapkan posisi ibu
12	Minta keluarga Bantu ibu	12	Minta keluarga Bantu ibu
13	Bimbingan Meneran	13	Bimbingan Meneran
14	Anjurkan Ibu	14	Anjurkan Ibu
V. Persiapan pertolongan kelahiran bayi		V. Persiapan pertolongan kelahiran bayi	
15	Letakan handuk bersih	15	Letakan handuk bersih
16	Letakan kain bersih	16	Letakan kain bersih
17	Pastikan kelengkapan alat	17	Pastikan kelengkapan alat
18	Pakai sarung tangan Disinfektan Tingkat Tinggi (DTT) Kedua tangan	18	Pakai sarung tangan Disinfektan Tingkat Tinggi (DTT) Kedua tangan
VI. Persiapan pertolongan kelahiran bayi		VI. Persiapan pertolongan kelahiran bayi	
Lahirnya kelapa		Lahirnya kelapa	
19	Lindungan Perineum, menahan kepala bayi tetap defleksi	19	Lindungan Perineum, menahan kepala bayi tetap defleksi
20	Periksa lilitan tali pusat	20	Periksa lilitan tali pusat
21	Tunggu putar paksi luar	21	Tunggu putar paksi luar
Lahirnya bahu		Lahirnya bahu	
22	Biparietal, gerakan kearah bawah dan atas	22	Biparietal, gerakan kearah bawah dan atas
Lahirnya badan dan tungkai		Lahirnya badan dan tungkai	
23	Sanggah kepala, lengan dan siku bawah	23	Kedua bahu lahir, topang kepala dan bahu

	Tangan atas telusuri dan pegang lengan dan siku sebelah atas		Tangan atas telusuri dan pegang lengan dan siku sebelah atas
24	Telusuri tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai dan kaki	24	Telusuri tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai dan kaki
	Pegang kedua mata kaki		Pegang kedua mata kaki
VII. Penanganan bayi baru lahir		VII. Penanganan bayi baru lahir	
25	Lakukan Penilaian sepintas	25	Lakukan Penilaian sepintas
26	Keringkan, ganti handuk, posisikan	26	Keringkan, ganti handuk, posisikan
27	Periksa bayi kedua	27	Periksa bayi kedua
28	Beritahu ibu	28	Beritahu ibu
29	Suntik oksitosin	29	Suntik oksitosin
30	Jepit tali pusat	30	Jepit tali pusat
31	Potong, ikat tali pusat	31	Potong, ikat tali pusat
32	Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	32	IMD, Selimuti ibu dan bayi, topi bayi
33	selimuti ibu dan bayi, pasang topi		
VIII. Penatalaksanaan kala 3		VIII. Manajemen Aktif Kala 3	
34	Pindahkan klem 5 - 10 cm dari vulva	33	Pindahkan klem tali pusat
35	Satu tangan di tepi atas symphysis mendeteksi kontraksi, tangan lain regangkan tali pusat	34	Satu tangan di tepi atas symphysis mendeteksi kontraksi, tangan lain regangkan tali pusat
36	Saat berkontraksi, tegangkan tali pusat kearah bawah, tangan lain dorso kranial	35	Saat berkontraksi, tegangkan tali pusat kearah bawah, tangan lain dorso kranial
Mengeluarkan plasenta		Mengeluarkan plasenta	
37	Lakukan peregangkan dan dorso kranial hingga plasenta lepas	36	Bila di ikuti pergeseran tali pusat ke arah distal lanjutkan dorongan hingga plasenta dapat dilahirkan
	Ibu diminta meneran sambil penolong meregangkan sejajar lantai dan kemudian kearah atas mengikuti poros jalan, tetap lakukan dorso kranial	37	Saat plasenta di introitus vagina, lahirkan, putar dan pilin, tempatkan
38	Lahirkan plasenta		
Rangsangan taktil (masase uterus)		Rangsangan taktil (masase uterus)	
39	Masasse uterus	38	Masasse uterus
IX. Menilai Perdarahan		IX. Menilai Perdarahan	
40	Periksa plasenta	39	Periksa plasenta
41	Evaluasi laserasi	40	Evaluasi laserasi
X. Melakukan asuhan pasca persalinan		X. Melakukan asuhan pasca persalinan	
42	Pastikan kontraksi dan tidak terjadi perdarahan pervaginam	41	Pastikan kontraksi dan tidak terjadi perdarahan pervaginam
43	Beri cukup waktu IMD minimal 1 jam	42	Celupkan sarung tangan
44	Timbang, Ukur panjang badan, tetes mata, vitamin K1 setelah 1 jam IMD		
45	Imunisasi HBO setelah 1 jam vitamin K		

Evaluasi		Evaluasi	
46	Lanjutkan pemantauan kontraksi dan perdarahan	43	Pastikan kandung kemih kosong
	2-3 kali dalam 15 menit pertama	44	Ajarkan ibu/keluarga masase
	Setiap 15 menit pada 1 jam pertama	45	Evaluasi dan estimasi perdarahan pervaginam
	Setiap 20-30 menit pada jam kedua	46	Periksa nadi dan pastikan Keadaan umum ibu baik
47	Ajarkan ibu/keluarga masase	47	Pantau kondisi bayi
48	Evaluasi dan estimasi perdarahan pervaginam		
49	Periksa nadi dan kandung kemih setiap 15 menit (1jam pertama) dan 30 menit (jam kedua)		
	Periksa suhu tiap jam selama 2 jam pertama		
50	Periksa pernapasan dan suhu bayi		
Kebersihan dan Keamanan		Kebersihan dan Keamanan	
51	dekontaminasi, cuci dan bilas	48	Dekontaminasi, cuci dan bilas
52	Buang bahan terkontaminasi	49	Buang bahan terkontaminasi
53	Bersihkan badan ibu, pakaikan bersih dan kering	50	Bersihkan badan ibu, pakaikan bersih dan kering
54	Pastikan ibu nyaman, bantu berikan ASI, keluarga ibu beri makan minum	51	Pastikan ibu nyaman, bantu berikan ASI, keluarga ibu beri makan minum
55	Dekontaminasi tempat bersalin	52	Dekontaminasi tempat bersalin
56	Celupkan sarung tangan	53	Celupkan sarung tangan
57	Cuci tangan	54	Cuci tangan
		55	Pakai sarung tangan untuk pemeriksaan fisik bayi
		56	satu jam pertama : salep mata, vitamin K, pemeriksaan fisik, pernapasan dan suhu
		57	Imunisasi HBO setelah satu jam vitamin K
		58	Celupkan sarung tangan
		59	Cuci tangan
Dokumentasi		Dokumentasi	
58	Lengkap partograf	60	Lengkap partograf

D. Kesimpulan

Asuhan persalinan normal akan berjalan dengan lancar dipengaruhi oleh 5 faktor dalam persalinan 5 faktor, yaitu power, passenger, passage, penolong dan psikologi. Sebagai penolong persalinan sebaiknya harus mengikuti Langkah – Langkah persalinan sesuai dengan prosedur yang ada untuk mengurangi resiko dari proses persalinan tersebut.

Setelah kita melakukan Langkah – Langkah persalinan dengan baik maka penolong dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi yang di sebabkan oleh persalinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. 2011. *Asuhan Postnatal Care*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Arantika dan Fatimah, 2019. *Patologi kehamilan* yogyakarta : pustaka baru press.
- Astuti. Sri, dkk. 2017. *Asuhan ibu dalam masa kehamilan* jakarta : Erlangga.
- Manuaba, 2014. *Ilmu kebidanan, penyakit kandungan dan kb*. Jakarta : EGC.
- Saifudin, A. 2014. *Buku panduan praktis pelayanan kesehatan maternal dan neonatal*. Jakarta: yayasan Bina pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Walyani, E. S. 2014. *Asuhan kebidanan pada kehamilan*. Yogyakarta : PT Pustaka Baru.
- _____. 2015. *Konsep Kebidanan* . Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- JNPK-KR, 2017. *Asuhan persalinan normal, Asuhan esensial bagi Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir serta penatalaksanaan komplikasi segera pasca persalinan dan nifas*. Jakarta : JNPK-KR.
- Prawirohardjo, Sarwono, 2018. *Ilmu kebidanan*, Jakarta : Bina Pustaka.
- _____. 2014. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT. Bina Pustaka.
- _____. 2016. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT. Bina Pustaka.
- Mochtar, R. 2012. *Sinopsis Obstetri : Obstetri Fisiologi, Obstetri Patologi*. Jakarta: EGC.
- Maryunani, A. 2012. *Inisiasi Menyusu Dini, ASI Eksklusif dan Manajemen Laktasi*. Jakarta: Trans Info Media.
- Marmi. 2014. *Asuhan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Rukiah, Ai Yeyeh. 2013. *Asuhan Kebidanan I Kehamilan*. Jakarta: CV. Trans Info Media.
- Irianti dkk, B. E. 2015. *Asuhan Kehamilan Berbasis Bukti Paradigma Baru Dalam Asuhan Kebidanan*. Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Sulistyawati, A. 2013. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta : Salemba Medika.

BAB 7

TAHAPAN PERSALINAN

Fatmawati, SST., M.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 7

TAHAPAN PERSALINAN

Fatmawati, SST., M.Keb

A. Pendahuluan

Proses Persalinan 95% berjalan secara normal dan spontan, tetapi dapat juga dapat terjadi komplikasi. Faktor yang mempengaruhi persalinan yaitu power, passage, dan passenger. Dengan demikian pertolongan persalinan memerlukan observasi yang lebih tepat dan ketat (Manuaba, 2009)

Proses dalam persalinan terasa akan menyenangkan karena si kecil yang selama sembilan bulan akan terlahir ke dunia. Di sisi lain persalinan juga menjadi mendebarakan khususnya bagi calon ibu baru, dimana terbayang bagaimana proses persalinan yang sangat menyakitkan, mengeluarkan energi yang begitu banyak, dan sebuah perjuangan yang cukup melelahkan. Pada primipara proses persalinan berlangsung lebih lama dibanding pada multipara karena ibu belum berpengalaman melahirkan. Otot-otot jalan lahir masih kaku dan belum dapat mengejan dengan baik, sedangkan pada multipara proses persalinan pada kala dua akan terjadi lebih cepat karena adanya pengalaman persalinan yang lalu dan disebabkan otot-otot jalan lahir yang lebih lemas (Varney et al., 2008).

Persalinan ini dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu kala I, II, III dan IV. Dengan mengetahui tahapan ini maka pada ibu, mahasiswa kebidanan khususnya maupun tenaga kesehatan lebih memahami asuhan dan tindakan dalam proses persalinan sehingga dapat memberikan asuhan secara komprehensif. Dalam beberapa tahapan persalinan tersebut banyak beberapa hal yang dilalui, sehingga sangat perlu sekali dalam memahami proses persalinan secara normal. Untuk membantu mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan dan keetrampilan dalam pertolongan persalinan. Pada buku ini akan dipelajari secara ringkas tahapan dalam proses persalinan.

B. Tujuan

Setelah mempelajari topik ini diharapkan dapat :

1. Memahami tahapan persalinan dalam Kala I meliputi Pengertian, Perubahan Fisiologis kala I, Perubahan *Psikologis* kala I dan Masalah Dan Penyulit Pada Kala I
2. Memahami tahapan persalinan dalam Kala II meliputi Pengertian kala II, Tanda Dan Gejala Kala II
3. Memahami tahapan persalinan dalam Kala III meliputi Pengertian Kala III, Tanda – Tanda Lepasnya Plasenta, Metode Pelepasan Plasenta, Pengeluaran Plasenta, Pemeriksaan Plasenta, Deteksi dan Komplikasi Kala III

4. Memahami tahapan persalinan dalam Kala IV meliputi Pengertian Kala IV, Pemantauan dan evaluasi dan tanda bahaya kala IV

C. Pembahasan

1. Kala I (Pembukaan)

1.1 Pengertian Kala I

Menurut (Hatini, 2019), kala 1 atau disebut kala pembukaan. Waktu membukanya serviks hingga menjadi pembukaan lengkap (10 cm). His belum begitu kuat, datang setiap 10-15 menit, dan tidak mengganggu. Pada primigravida kala 1 berlangsung 12-13 jam, sedangkan pada multigravida berlangsung sekitar 7 jam.

a. Klasifikasi

1) Fase Laten

- a) Dimulai sejak awal kontraksi yang mengakibatkan penipisan dan pembukaanserviks bertahap.
- b) Pembukaan terjadi lambat hingga diameter 3 cm.
- c) Durasi <8 jam.
- d) Pada primipara sekitar 20 jam sedangkan multipara 14 jam. Kontraksi mulai teratur dengan lama 20-30 detik, dan tidak terlalu nyeri.

2) Fase Aktif

- a) Frekuensi dan lama kontraksi meningkat (kontraksi adekuat/ ≥ 3 kali dalam 10 menit, selama ≥ 40 detik).
- b) Pembukaan serviks dari 4 cm ke 10 cm, kecepatan 1 cm/lebih per jam.
- c) Terjadi penurunan bagian terendah janin.
- d) Pembukaan pada primigravida 1 cm/jam, pada multigravida 2 cm/jam, hal ini digunakan sebagai dasar perkiraan perhitungan pembukaan lengkap.
- e) Berlangsung dalam 3 fase sesuai kurva Friedman, meliputi:
 - ✓ **Periode Akselerasi**, pembukaan 3 cm ke 4 cm selama 2 jam.
 - ✓ **Periode Dilatasi Maksimal**, pembukkaan 4 cm ke 9 cm maksimal selama 2 jam.
 - ✓ **Periode Deselerasi**, pembukaan 9 cm ke 10 cm (lengkap) selama 2 jam (secaralambat).

Fase tersebut terjadi pada primigravida, sedangkan pada multigravida terjadi lebih pendek. Pada pembukaan 10 cm, tidak teraba lagi porsio uteri, segmen bawah rahim, serviks, dan vagina karena telah menjadi saluran. Ketuban akan pecah sendiri ketika

pembukaan hampir/sudah lengkap tapi bisa juga dipecahkan sesuai indikasi, namun jika pecah sebelum pembukaan 5 cm disebut ketuban pecah dini.

b. Tanda dan Gejala

Menurut (Borrelli et al., 2020), meliputi :

1. Kesakitan akibat his yang lebih kuat, sering, dan teratur.
2. Keluar lendir bercampur darah yang lebih banyak.
3. Kadang kala ketuban sudah pecah sendiri.
4. Serviks mulai pembukaan dan penipisan.

1.2 Perubahan Fisiologi Kala I

Menurut (Prawirohardjo, 2014), selama rentan waktu dari adanya his sampai pembukaan lengkap 10 cm terjadi beberapa perubahan yang fisiologis. Perubahan fisiologis kala I meliputi :

a. Perubahan pada *serviks*

1) Pendataran pada *serviks/effacement*

Pendataran pada *serviks* adalah pendekatan dari *kanalis servikalis* yang semula berupa sebuah saluran panjang 1-2 cm, menjadi sebuah lubang saja dengan pinggir yang tipis.

2) Pembukaan *serviks*

Pembukaan *serviks* disebabkan karena pembesaran *Ostium Uteri Eksternum* (OUE) karena otot yang melingkar di sekitar *ostium* meregang untuk dilewati kepala. Pada pembukaan 10 cm atau pembukaan lengkap, bibir *portio* tidak teraba lagi.

b. Perubahan sistem *kardiovaskuler*

1) Tekanan darah

Tekanan darah meningkat selama kontraksi uterus dengan kenaikan *sistolik* rata-rata 10-20 mmHg dan kenaikan *diastolik* rata-rata 5-10 mmHg. Diantara kontraksi tekanan darah akan turun seperti sebelum masuk persalinan dan akan naik lagi jika terjadi kontraksi. Posisi tidur terlentang selama persalinan akan mengakibatkan adanya penekanan uterus terhadap pembuluh darah besar (*aorta*), yang menyebabkan sirkulasi darah baik ibu maupun janin akan terganggu, ibu biasanya mengalami *hipotensi* dan janin mengalami asfiksia.

2) Denyut jantung

Denyut jantung meningkat selama kontraksi. Dalam posisi terlentang denyut jantung akan menurun. Denyut jantung antara kontraksi sedikit lebih tinggi dibandingkan selama periode segera sebelum persalinan.

3) Perubahan sistem respirasi

Pada respirasi atau pernapasan terjadi kenaikan sedikit dibandingkan sebelum persalinan, hal ini disebabkan adanya rasa nyeri, kekhawatiran serta penggunaan teknik pernapasan yang tidak benar.

4) Kontraksi uterus

Kontraksi uterus terjadi karena adanya rangsangan pada otot polos uterus dan penurunan hormon *progesterone dan estrogen* yang menyebabkan keluarnya hormon oksitosin.

5) Pembentukan segmen atas rahim dan segmen bawah rahim

Segmen Atas Rahim (SAR) dibentuk oleh *corpus* uteri yang sifatnya aktif yaitu berkontraksi, dan dinding tambah tebal dengan majunya persalinan serta mendorong anak keluar.

6) Perubahan *hematologist*

Haemoglobin akan meningkat 1,2 gram/100 ml selama persalinan dan kembali ke tingkat pra persalinan pada hari pertama setelah persalinan apabila tidak terjadi kehilangan darah selama persalinan. Jumlah sel darah putih meningkat secara *progres* selama kala I persalinan sebesar 5000 s/d 15000 WBC sampai dengan akhir pembukaan lengkap.

7) Perubahan *renal*

Polyuri sering terjadi selama persalinan, dikarenakan oleh *kardiak out-put* yang meningkat serta disebabkan oleh *glomerulus* serta aliran *plasma* ke *renal*. *Polyuri* tidak begitu kelihatan dalam posisi terlentang yang mengurangi aliran *urine* selama kehamilan.

8) Perubahan *gastrointestinal*

Kemampuan pergerakan gastrik serta penyerapan makanan padat berkurang, menyebabkan pencernaan hampir berhenti disela persalinan dan menyebabkan konstipasi. Makanan yang masuk ke lambung selama fase pendahuluan atau fase kemungkinan besar akan tetap berada dalam perut selama persalinan. Rasa mual-muntah bukanlah hal yang jarang, hal ini menunjukkan berakhirnya kala I persalinan.

9) Perubahan suhu badan

Suhu badan akan sedikit meningkat selama persalinan, suhu mencapai tingkat tertinggi selama persalinan dan segera setelah kelahiran. Kenaikan ini dianggap normal asal tidak melebihi 0,5 – 10 C. Suhu badan yang naik sedikit merupakan yang wajar namun jika

keadaan ini berlangsung lama, kenaikan suhu mengindikasikan *dehidrasi*.

10) Perubahan pada *vagina* dasar panggul

Pada kala I ketuban ikut meregang, bagian atas vagina yang sejak kehamilan mengalami perubahan sedemikian rupa akan bisa dilalui bayi, setelah ketuban pecah segala perubahan terutama pada dasar panggul ditimbulkan oleh bagian depan anak, bagian depan yang maju tersebut ke dasar panggul di regang menjadi saluran dengan dinding yang tipis, waktu kepala sampai di vulva, lubang vulva menghadap kedepan atas dan dari luar peregangannya oleh bagian depan tampak pada *perineum* yang menonjol dan menjadi tipis, sedangkan anus semakin terbuka, regangan yang kuat ini dimungkinkan karena bertambahnya pembuluh darah pada bagian vagina dan dasar panggul. Tetapi saat jaringan tersebut robek, akan menimbulkan perdarahan yang banyak (Rukiyah et al., 2014).

1.3 Perubahan Psikologis kala I

Perubahan psikologi pada ibu bersalin selama kala I antara lain sebagai berikut:

- a. Kontraksi uterus yang terus menerus terjadi dapat menimbulkan rasa cemas yang dipicu oleh kurangnya dukungan lingkungan bersalin baik dalam segi tempat maupun pendamping persalinan sehingga timbul krisis situasional
- b. Memperlihatkan ketakutan atau kecemasan, yang menyebabkan wanita mengartikan ucapan pemberi perawatan atau kejadian persalinan secara *pesimistik* atau *negatif*.
- c. Mengajukan banyak pertanyaan atau sangat waspada terhadap sekelilingnya.
- d. Memperlihatkan tingkah laku saat membutuhkan.
- e. Memperlihatkan reaksi keras terhadap kontraksi ringan atau terhadap pemeriksaan.
- f. Menunjukkan kebutuhan yang kuat untuk mengontrol tindakan pemberi perawatan.
- g. Tampak “lepas kontrol” dalam persalinan (saat nyeri hebat, menggeliat kesakitan, panik, menjerit, tidak merespon saran atau pertanyaan yang membantu).
- h. Respon “melawan atau menghindari”, yang dipicu oleh adanya bahaya fisik, ketakutan, kecemasan dan bentuk stress lainnya (Ilmiah, 2015).

1.4 Masalah Dan Penyulit Pada Kala I

Indikasi – indikasi untuk melakukan tindakan dan/atau rujukan segera selama kala I persalinan:

- a. Perdarahan pervaginam selain dari lender bercampur darah (“*show*”)
- b. Ketuban pecah bercampur dengan sedikit *mekonium* disertai tanda-tanda gawat janin
- c. Ketuban telah pecah (lebih dari 24 jam) yang disebabkan oleh tekanan hidrostatik air ketuban dan terjadinya kenaikan tekanan pada intrauterine atau ketuban pecah pada kehamilan kurang bulan (usia kehamilan kurang 37 minggu).
- d. Tanda-tanda atau gejala-gejala infeksi maternal: temperature tinggi $>38^{\circ}\text{C}$, menggigil, nyeri *abdomen*, cairan ketuban yang berbau. Infeksi maternal ini dapat disebabkan oleh ketuban pecah dini yang menjadi port entry bakteri
- e. Tekanan darah $>160/100$ dan/ atau terdapat protein urin.
- f. DJJ <100 atau >180 x/menit pada dua kali penilaian dengan jarak 5 menit.
- g. *Primipara* dalam persalinan fase aktif dengan palpasi kepala janin masih 5/5.
- h. Presentasi ganda/majemuk (adanya bagian janin, seperti lengan atau tangan, bersamaan dengan presentasi belakang kepala).
- i. Tali pusat menumbung (jika tali pusat masih berdenyut)
- j. Tanda dan gejala syok : Nadi cepat, lemah (lebih dari 110 x/menit), tekanan darahnya rendah (sistolik kurang dari 90 mmHg), pucat, berkeringat atau kulit lembab, dingin, napas cepat (lebih dari 30 x/menit), cemas, bingung atau tidak sadar, dan produksi urin sedikit (kurang dari 30 ml/jam)
- k. Tanda dan gejala persalinan dengan fase laten yang memanjang dimana pembukaan serviks kurang dari 4 cm setelah 8 jam, dan kontraksi teratur (lebih dari 2 dalam 10 menit)
- l. Tanda dan gejala belum *inpartu* yaitu, kurang dari 2 kontraksi dalam 10 menit, berlangsung kurang dari 20 detik, tidak ada perubahan *serviks* dalam waktu satu sampai dua jam.
- m. Tanda dan gejala partus lama yaitu, pembukaan *serviks* mengarah ke sebelah kanan garis waspada, pembukaan serviks kurang 1 cm per jam, dan kurang dari dua kontraksi dalam waktu 10 menit, masing-masing berlangsung kurang 40 detik (Pranoto, 2014).

2. Kala II (kala pengeluaran)

2.1 Pengertian kala II

Kala II persalinan disebut juga kala pengeluaran yang merupakan peristiwa terpenting dalam proses persalinan karena objek yang dikeluarkan adalah objek utama yaitu bayi (Ilmiah, 2015).

Menurut (Borrelli et al., 2020), kala 2 atau disebut kala pengeluaran janin. Dimulai dari pembukaan 10 cm/lengkap hingga bayidilahirkan. Pada primigravida berlangsung selama 2 jam dan multigravida selama 1 jam.

2.2 Tanda Dan Gejala Kala II

Kala II dimulai sejak pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi, gejala dan tanda kala II adalah :

- a. Adanya pembukaan lengkap (tidak teraba lagi bibir portio), ini terjadi karena adanya dorongan bagian terbawah janin yang masuk kedalam dasar panggul karena kontraksi uterus yang kuat sehingga portio membuka secara perlahan.
- b. His yang lebih sering dan kuat ($\pm$ 2-3 menit 1 kali) dan timbul rasa mencedan, karena biasanya dalam hal ini bagian terbawah janin masuk ke dasar panggul sehingga terjadi tekanan pada otot-otot dasar panggul, yang secara *reflektoris* menimbulkan rasa mencedan.
- c. Adanya pengeluaran darah bercampur lendir, di sebabkan oleh adanya robekan *serviks* yang meregang.
- d. Pecahnya kantung ketuban, karena kontraksi yang menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan yang besar antara tekanan di dalam *uterus* dan diluar *uterus* sehingga kantung ketuban tidak dapat menahan tekanan isi *uterus* akhirnya kantung ketuban pecah.
- e. Anus membuka, karena bagian terbawah janin masuk ke dasar panggul sehingga menekan *rectum* dan rasa buang air besar, hal ini menyebabkan anus membuka. Vulva terbuka, perineum menonjol, karena bagian terbawah janin yang sudah masuk ke Pintu Bawah Panggul (PBP) dan ditambah pula dengan adanya his serta kekuatan mencedan menyebabkan *vulva* terbuka dan *perineum* menonjol, karena *perineum* bersifat elastis.
- f. Bagian terdepan anak kelihatan pada *vulva*, karena *labia* membuka, *perineum* menonjol menyebabkan bagian terbawah janin terlihat di *vulva*, karena ada his dan tenaga mencedan menyebabkan bagian terbawah janin dapat dilahirkan (Ilmiah, 2015).

3. Kala III (kala uri)

3.1 Pengertian Kala III

Kala III dimulai sejak bayi lahir sampai lahirnya plasenta atau uri. Partus kala III disebut juga kala uri. Kala III merupakan periode waktu dimana

penyusutan volume rongga uterus setelah kelahiran bayi. Penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perlengketan plasenta. Oleh karena tempat perlengketan menjadi kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah, maka plasenta menjadi berlipat, menebal dan kemudian lepas dari dinding *uterus* (Kuswanti & Melina, 2014).

Menurut (Borrelli et al., 2020), kala 3 atau disebut kala pengeluaran plasenta. Waktu yang digunakan untuk pelepasan dan pengeluaran plasenta yang dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Prosesnya berlangsung 5-30 menit setelah bayi dilahirkan. Jika lebih dari itu, harus dilakukan penanganan lebih atau dirujuk.

3.2 Tanda – Tanda Lepasnya Plasenta

a. Berubahan Bentuk dan Tinggi Fundus

Setelah bayi lahir dan sebelum *miometrium* mulai berkontraksi, uterus berbentuk bulat penuh dan tinggi fundus biasanya dibawah pusat. Setelah uterus berkontraksi dan plasenta terdorong kebawah, uterus berbentuk segi tiga, atau seperti buah pir atau alpukat dan fundus berada diatas pusat (sering kali mengarah ke sisi kanan).

b. Tali pusat memanjang

Tali pusat terlihat menjulur keluar melalui vulva (tanda *ahfeld*)

c. Semburan darah yang mendadak dan singkat.

Darah yang terkumpul dibelakang plasenta akan membantu mendorong plasenta keluar dibantu oleh gaya gravitasi. Apabila kumpulan darah (*retroplacenta pooling*) dalam ruang diantara dinding uterus dan permukaan dalam plasenta melebihi kapasitas tampungnya, darah tersembur keluar dari tepi plasenta yang lepas (Rukiyah et al., 2014).

3.3 Metode Pelepasan Plasenta

a. Metode *Scultze*

Metode yang lebih umum terjadi adalah plasenta terlepas dari satu titik dan merosot ke vagina melalui lubang dalam kanton amnion, permukaan fetal plasenta muncul pada vulva dengan selaput ketuban yang mengikuti dibelakang seperti payung terbalik saat terkelupas dari dinding uterus.

b. Metode *Matthews Duncan*

Plasenta turun melalui bagian samping dan masuk ke *vulva* dengan pembatas *lateral* terlebih dahulu seperti kancing yang memasuki lubang baju, sehingga sebagian plasenta tidak berada dalam kantong. Walaupun demikian sebagian selaput ketuban berpotensi tertinggal dengan metode ini karena selaput ketuban tidak terkelupas semua selengkap metode *Schultze*. Metode ini berkaitan dengan plasenta letak rendah didalam uterus. Proses pelepasan berlangsung lebih lam dan darah yang hilang

sangat banyak karena hanya sedikit serat oblik dibagian bawah segmen (Jannah, 2017).

3.4 Pengeluaran Plasenta

Plasenta yang sudah lepas dan menempati segmen bawah rahim, kemudian melalui *serviks*, vagina dan dikeluarkan ke *introitus vagina* (Kuswanti & Melina, 2014).

Dari tempat ini plasenta di dorong keluar oleh tenaga mengejan, 20% secara spontan dan selebihnya memerlukan pertolongan. Plasenta dikeluarkan dengan melakukan tindakan manual apabila : Perdarahan lebih dari 400 sampai 500 cc, terjadi restensio plasenta, bersamaan dengan tindakan yang di sertai *narkosa*, dari anamnesis terdapat perdarahan *hibitualis*.

Lahirnya plasenta lebih baik dengan bantuan penolong dengan sedikit tekanan pada fundus uteri setelah plasenta lepas. Tetapi pengeluaran plasenta jangan dipaksakan sebelum terjadi pelepasan karena di khawatirkan menyebabkan *inversio uteri*. Traksi pada tali pusat tidak boleh digunakan untuk menarik plasenta keluar dari uterus. Pada saat *korpis* di tekan, tali pusat tetap di regangkan. *Maneuver* ini diulangi sampai plasenta mencapai *introitus*, setelah *introitus* penekanan dilepaskan.

Tindakan hati-hati diperlukan untuk mencegah membran tidak terputus dan tertinggal jika membrane robek pegang robekan tersebut dengan klem dan tarik perlahan. Periksa plasenta secara hati-hati untuk memastikan tidak ada bagian plasenta yang tertinggal (Rukiyah et al., 2014).

3.5 Pemeriksaan Plasenta

- a. Pemeriksaan plasenta meliputi hal-hal sebagai berikut :
- b. Selaput ketuban utuh atau tidak
- c. Plasenta (ukuran plasenta) yang terdiri atas : Bagian maternal, jumlah *kotiledon*, keutuhan pinggir *kotiledon*, bagian *fetal*, utuh atau tidak.
- d. Tali pusat, meliputi : Jumlah *arteri* dan *vena*, adakah *arteri* atau *vena* yang terputus untuk mendeteksi plasenta *suksepturia*, dan *insersi* tali pusat apakah *sentral*, *marginal*, panjang tali pusat (Jannah, 2017).

3.6 Deteksi dan Komplikasi Kala III

- a. Perdarahan kala III. Perdarahan pasca persalinan adalah perdarahan atau hilangnya darah 500 cc atau lebih yang terjadi setelah anak lahir. Perdarahan dapat terjadi sebelum, selama, atau sesudah ahirnya plasenta. Perdarahan menurut waktunya dibagi atas :
 - 1) Perdarahan post partum primer (*early postpartum hemorrhage*) yang terjadi dalam 24 jam setelah anak lahir.
 - 2) Perdarahan postpartum skunder (*late postpartum homorrhage*) yang terjadi antara 24 jam dan 6 minggu setelah anak lahir (Ilmiah, 2015).

3) Penyebab perdarahan kala III yaitu :

a) *Atonia Uteri* didefinisikan sebagai suatu kondisi kegagalan berkontraksi dengan baik setelah persalinan. Pada kondisi tertentu, otot rahim tersebut tidak mampu berkontraksi atau walaupun ada, kontraksi tersebut kurang kuat. Akibatnya perdarahan yang terjadi dari tempat implantasi plasenta tidak akan berhenti sehingga kondisi tersebut sangat membahayakan ibu.

b) Laserasi Jalan Lahir atau Robekan *Perineum* (Nurasiah et al., 2014). Robekan *perineum* terjadi hampir semua persalinan pertama dan tidak jarang juga pada persalinan berikutnya. Akan tetapi, hal tersebut dapat di hindari atau dikurangi dengan cara mencegah kepala janin melewati dasar panggul dengan cepat.

c) *Retensio Plasenta*

Retensio plasenta adalah keadaan plasenta yang tertahan atau belum lahir hingga melebihi waktu 30 menit setelah bayi lahir. Plasenta biasanya terlepas dari tempat implantasinya pada keadaan normal 15 menit setelah bayi lahir. Penyebab dari *Retensio Plasenta* yaitu:

(1) Plasenta belum terlepas dari dinding rahim karena tubuh terlalu melekat lebih dalam. Berdasarkan tingkat perlekatannya, kondisi plasenta menjadi:

- *Plasenta adhesif*, yang melekat pada *desidua endometrium* lebih dalam.
- *Plasenta akreta*, imlantasi *chorion* memasuki sebagian *miometrium*.
- *Plasenta inkreta*, imlantasi menembus hingga *miometrium*.
- *Plasenta parkreta*, menembus sampai *serosa* atau *peritoneum* dinding rahim.

(2) Plasenta telah lepas, tetapi belum keluar karena:

- *Atonia uteri*, yang dapat menyebabkan perdarahan.
- Terdapat lingkaran kontraksi pada bagian rahim akibat kesalahan penanganan kala III sehingga menghalangi plasenta untuk keluar (*plasenta inkarserata*).

d) Kelainan Pembekuan

Darah Perdarahan yang telah di jelaskan sebelumnya umumnya terjadi akibat pembekuan darah *intravascular* merata dan kelainan bawaan pada mekanisme pembekuan darah. Penyakit kelainan pembekuan darah seperti amfibrinogenemia atau hipofibrinogenemia sangat membahayakan jiwa ibu, bila tidak cepat di tanggulangi (Jannah, 2017).

4. Kala IV (Kala pemantauan)

4.1 Pengertian Kala IV

Kala IV ditetapkan sebagai waktu dua jam setelah plasenta lahir lengkap, hal ini dimaksudkan agar dokter, bidan atau penolong persalinan masih mendampingi anita setelah persalinan selama 2 jam (2 jam *post partum*). Dengan cara ini kejadian-kejadian yang tidak diinginkan karena perdarahan postpartum dapat dikurangi atau dihindarkan (Tritten, 2012).

Menurut (Manuaba, 2009), kala 4 atau disebut kala observasi. Dimulai dari lahirnya plasenta hingga 2 jam setelah proses tersebut. Observasi pada 1 jam pertama dilakukan setiap 15 menit dan pada 1 jam kedua setiap 30 menit, dengan total observasi sebanyak 6 kali dalam 2 jam paska persalinan.

Setelah kelahiran plasenta, periksa kelengkapan dari plasenta dan selaput ketuban. Jika masih ada sisa plasenta dan selaput ketuban yang tertinggal dalam uterus akan mengganggu kontraksi uterus sehingga menyebabkan perdarahan. Jika dalam waktu 15 menit uterus tidak berkontraksi dengan baik, maka akan terjadi atonia uteri. Oleh karena itu, diperlukan tindakan rangsangan taktil (*masase fundus uteri*), dan bila perlu dilakukan *kompresi bimanual* (Borrelli et al., 2020).

a. Pemeriksaan Serviks, Vagina dan Perineum

Untuk mengetahui apakah ada tidaknya robekan jalan lahir, periksa darah *perineum*, *vagina* dan *vulva*. Setelah bayi lahir, *vagina* akan mengalami peregangan, oleh kemungkinan *edema* dan lecet. *Introitus vagina* juga akan tampak terluka dan terbuka. Sedangkan vulva bisa berwarna merah, bengkak dan mengalami lecet (Rukiyah et al., 2014).

b. Pemantauan dan Evaluasi Lanjut

Sebagian besar kematian ibu pada periode pasca persalinan terjadi pada 6 jam pertama setelah persalinan. Kematian ini disebabkan oleh infeksi, perdarahan dan eklampsia. Oleh karena itu pemantauan selama dua jam pertama persalinan postpartum sangat penting (Rukiyah et al., 2014).

4.2 Pemantauan dan evaluasi Kala IV

Pemantauan dan evaluasi lanjut dapat berupa :

a. Tanda Vital

Pemantauan dan evaluasi lanjut tanda vital meliputi usaha untuk memastikan bahwa uterus berkontraksi dengan baik, tidak terjadi perdarahan vagina atau alat genitalia lainnya, plasenta dan selaput ketuban telah lahir lengkap, kandung kemih kosong, luka pada *perineum* terawat baik dan tidak terjadi *hematoma*. Selain itu ibu dan bayi berada dalam keadaan baik.

Tanda syok pada ibu harus diperhatikan seperti nadi cepat dan lemah (110 kali/menit), tekanan darah rendah sistolik kurang dari 90 mmHg, pucat, berkeringat, dingin kulit lembab, napas cepat, kesadaran menurun, dan protein urin sangat sedikit. Perhatikan pula tanda dehidrasi, gejala infeksi, gejala *preeklamsi* hingga *eklamsi* dan pemantauan suhu tubuh untuk mencurigai terjadinya infeksi.

b. Kontraksi Uterus

Kontraksi uterus yang baik pada uterus adalah bahwa uterus terasa keras dan tidak lembek dan tinggi fundus uteri berada 1-2 jari dibawah pusat setelah melahirkan. Pemeriksaan kontraksi dilakukan 15 menit pada satu jam pertama pascapartum, dan 30 menit satu jam kedua pasca *post partum*.

c. *Lokla*

Selama beberapa hari persalinan, *lokea* tampak merah karena ditemukan eritrosit atau disebut juga *lokea rubra*. Setelah 3 sampai 4 hari, *lokea* menjadi pucat atau *lokea serosa*, dan hari ke 10, *lokea* tampak putih atau putih kekuning-kuningan atau *lokea alba*. *Lokea* yang berbau busuk menjadi indikasi dugaan *endometrosis*.

d. Kandung Kemih

Kandung kemih harus terus dipertahankan dalam keadaan kosong, kandung kemih yang penuh dapat menghalangi kontraksi maksimal sehingga perdarahan dapat terjadi. Pemantauan kontraksi selama satu jam pertama dilakukan empat kali dalam 15 menit dan pada jam kedua, dua kali dalam 30 detik.

e. *Perineum*

Setelah persalinan, keadaan *perineum* harus juga menjadi perhatian. Apabila terjadi luka jahit, perlu diperhatikan tanda-tanda infeksi, menjaga kebersihan area luka jahitan. Kebersihan luka yang tidak terjaga dapat memicu infeksi (Jannah, 2017).

4.3 Tanda Bahaya Kala IV

Selama kala IV, bidan harus memberitahu ibu dan keluarga tentang tanda bahaya : Demam, perdarahan aktif, pembekuan darah banyak, bau busuk dari vagina, pusing, lemas luar biasa, kesulitan dalam menyusui, nyeri panggul atau *abdomen* yang lebih dari kram uterus biasa (Ilmiah, 2015).

D. Kesimpulan

Dengan mengetahui tahapan persalinan ini akan memberikan pemahaman tentang rangkaian proses dalam persalinan, yang dimulai dari Kala I, Kala II, Kala III dan kala IV sehingga dapat memberikan asuhan yang komprehensif kepada ibu dan lebih kompeten dalam pelaksanaan asuhan persalinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Borrelli, S., Evans, K., Pallotti, P., Evans, C., Eldridge, J., & S., H. (2020). Mixed-methods systematic review: Childbearing women's views, experiences, and decision-making related to epidural analgesia in labour. *Journal of Advanced Nursing*, 76(12), 3273–3292.
- Hatini, E. (2019). *Asuhan Kebidanan kehamilan*. Wineka Media.
- Ilmiah, W. (2015). *Buku Ajar Asuhan Persalinan Normal*. Nuha Medika.
- Jannah, N. (2017). *ASKEB II Persalinan Berbasis Kompetensi*. EGC.
- Kuswanti, I., & Melina, F. (2014). *ASKEB II Persalinan*. Pustaka Pelajar.
- Manuaba. (2009). *Ilmu kebidanan penyakit kandungan dan keluarga berencana untuk Pendidikan Bidan*. EGC.
- Nurasiah, A., Rukmawati, A., & DL., B. (2014). *Asuhan Persalinan Normal Bagi Bidan*. PT. Refika Aditama.
- Pranoto, I. (2014). *Patologi Kebidanan*. Fitramaya.
- Prawirohardjo, S. (2014). *Ilmu Kebidanan*. PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Rukiyah, A., Yulianti, L., Maemunah, & L, S. (2014). *Asuhan Kebidanan II Persalinan Edisi Revisi*. CV. Trans Info Media.
- Tritten, J. (2012). Fourth Stage of Labor and Midwifery. *Midwifery Today*, 102.
- Varney, H., Kriebs, J., & Gegor, C. (2008). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan, Volume 2*. EGC.

BAB 8

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSALINAN

Bd. Mariza Mustika Dewi, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSALINAN

Bd. Mariza Mustika Dewi, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb

A. Pendahuluan

Persalinan adalah pengeluaran hasil konsepsi berupa janin, plasenta, dan selaput ketuban yang diawali dari proses membuka dan menipisnya serviks dikarenakan kontraksi dari uterus yang menyebabkan menurunnya bagian terbawah janin sehingga keluar dari jalan lahir. Persalinan terjadi ketika usia 9 bulan atau 40 minggu. Persalinan umumnya terjadi dalam 18 jam pada presentasi tanpa komplikasi. Persalinan normal yaitu proses persalinan yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, memiliki onset yang spontan, selesai dalam 4 jam dan sebelum 24 jam sejak dimulai awitan, memiliki janin tunggal dengan presentasi vertex dan oksiput pada bagian anterior pelvis, terlaksana tanpa abtuan, tidak ada komplikasi, dan mencakup kelahiran plasenta yang normal (Sulfianti et al., 2020). Persalinan berjalan lancar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bekerja bersama-sama dan efisien. Apabila salah satu faktor tersebut mengalami kelainan, maka persalinan normal tidak akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan fisiologi. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor *passenger*, *passage*, *power*, *position*, psikologis, dan *provider*.

B. Tujuan

1. Untuk memahami faktor *passenger* dalam persalinan dengan benar
2. Untuk memahami faktor *passage* dalam persalinan dengan benar
3. Untuk memahami faktor *power* dalam persalinan dengan benar
4. Untuk memahami faktor *position* dalam persalinan dengan benar
5. Untuk memahami faktor psikologis dalam persalinan dengan benar
6. Untuk memahami faktor *provider* dalam persalinan dengan benar

C. Pembahasan**1. Passenger (Janin)**

Janin adalah salah satu faktor yang mempengaruhi persalinan dengan kontribusi ukuran kepala janin, presentasi, letak janin, berat badan janin, posisi atau sikap janin, maupun jumlah janin. Malpresentasi atau malformasi janin dapat mempengaruhi persalinan normal. Plasenta adalah suatu bagian dari hasil konsepsi yang harus dikeluarkan pun dianggap sebagai faktor yang mengertai keluarnya janin (Yulizawati et al., 2019). Faktor janin dalam persalinan normal fisiologisnya adalah janin bersikap fleksi yaitu kepala, tulang punggung, dan kaki dalam keadaan fleksi serta lengan bersilang didada. Persalinan normal umumnya dapat dijalani dengan janin yang memiliki taksiran berat badan Antara 2500 – 3500

gram dengan DJJ yang normal yaitu berkisar Antara 120-160x/menit dengan jumlah janin tunggal.

Ukuran janin dapat dilihat dari ukuran kepala janin yang meliputi diameter dan ukuran circumference serta ukuran badan janin yang meliputi bahu dan bokong (Fitriahadi & Utami, 2020).

a. Ukuran Kepala Janin

1) Diameter

- a) Diameter sub Oksipito bregmatika sebesar 9,5 cm
- b) Diameter oksipito frontalis, yaitu jarak Antara tulang oksiput dengan tulang frontal sebesar 12 cm
- c) Diameter mento oksipitalis, adalah diameter paling besar yang terjadi pada presentasi dahi yaitu 13,5 cm
- d) Diameter sub mentobregmatika, yaitu sebesar 9,5 cm pada presentasi muka
- e) Diameter melintang biparietalis sebesar 9,5 cm
- f) Diameter melintang bitemporalis sebesar 8 cm

2) Ukuran circumference atau ukuran kepala keliling

- a) Circumference fronto oksipitalis sebesar 34 cm
- b) Circumference mento oksipitalis sebesar 35 cm
- c) Circumference sub oksipito bregmatika 32 cm

b. Ukuran Badan Janin

- 1) Bahu dengan jarak antara kedua acromion sebesar 12 cm dengan lingkaran bahu 34 cm
- 2) Diameter intertrokanterika atau lebar bokong 12 cm dengan lingkaran bokong 27 cm

Presentasi janin dapat diartikan sebagai bagian terbawah janin yang masuk ke dalam pintu atas panggul sejak awal atau pertama kali hingga melalui jalan lahir saat persalinan sudah aterm (Fitriahadi & Utami, 2020). Presentasi janin dapat dideteksi dengan pemeriksaan Leopold sejak kehamilan; yaitu dengan bagian keras, bulat, dan melenting untuk presentasi kepala; dan bagian kurang bulat, lunak, dan tidak melenting untuk presentasi bokong.

Letak merupakan hubungan antar sumbu panjang janin terhadap sumbu panjang ibu, atau bisa diartikan dengan hubungan punggung ibu dan janin. Letak terbagi menjadi vertical dan horizontal.

a. Vertical

Dikatakan letak vertical apabila sumbu panjang janin sejajar dengan sumbu panjang ibu

b. Horizontal

Dikatakan horizontal apabila sumbu panjang janin membentuk sudut terhadap sumbu panjang ibu.

Posisi adalah hubungan antara empat quadran panggul ibu dengan bagian presentasi janin, contohnya adalah posisi oksipito kanan depan, oksipito transversa, oksipito kanan belakang, oksipito kiri belakang, dan oksipito kiri depan (Fitriahadi & Utami, 2020).

Sikap adalah hubungan bagian tubuh janin yang berhubungan satu dengan lainnya dengan postur yang khas. Pada persalinan normal, punggung janin fleksi maksimal dengan kepala fleksi ke arah dada, dan paha fleksi ke arah sendi lutut, tangan disilangkan di depan dada dan tali pusat terletak di antara tungkai dan lengan (Fitriahadi & Utami, 2020). Sikap ini bersama dengan kontraksi uterus akan menghasilkan mekanisme yang lebih baik pada panggul (Yeyeh, 2013).

2. Passage

Jalan lahir yaitu panggul ibu yang terdiri dari bagian tulang yang keras, dasar panggul, vagina, dan introitus vagina. Janin harus berhasil menyesuaikan diri terhadap jalan lahir yang relatif kaku namun tetap aman, maka dari itu diperlukan pemeriksaan panggul yang akurat agar bayi dapat melewati jalan lahir ibu tanpa kompresi pada kepalanya akibat Disproporsi Kepala Panggul (DKP) (Yulizawati et al., 2019).

Panggul terdiri dari empat tulang yaitu tulang pangkal paha, tulang sacrum, dan tulang koksige (Harwijayanti et al., 2022).

a) Tulang pangkal paha (os coxae)

Tulang pangkal paha memiliki tiga bagian yaitu os ilium, os ischium, dan os pubikum.

1) Os ilium

Yaitu tulang usus yang berukuran terbesar dari bagian panggul lain yang memiliki batas dinding atas dan belakang pelvis

2) Os ischium

Os ischium terletak di bawah os ilium dengan tonjolan yaitu spina ischiadika. memiliki lengkung dinamakan incisura ischiadica minor dan memiliki bagian bawah yang menebal disebut tuber ischiadicum yang berfungsi sebagai penopang ketika duduk

3) Os pubikum

Yaitu tulang kemaluan yang membentuk lubang yang disebut foramen obturator

b) Tulang kelangka (os sakrum)

Tulang ini berbentuk segitiga dengan pada bagian atas dan puncak bagian ujung bawah. Bagian depan teratas yaitu promontorium. Promontorium dapat dikatakan sebagai indikator panggul sempit apabila saat pemeriksaan dalam dapat teraba oleh penolong.

c) Tulang tungging (os koksigis)

Tulang ini sering disebut tulang ekor yang dibentuk oleh 3 hingga 5 ruas tulang yang saling berhubungan membentuk segitiga. Pada akhir kehamilan, tulang ini bersifat mobile.

Panggul memiliki bidang semu sebagai rujukan untuk mengetahui kemajuan persalinan dengan menentukan seberapa jauh kepala turun ke panggul yang diketahui dari pemeriksaan vagina. Bidang semu tersebut dinamakan bidang hodge yang terdiri dari 4 jenis, yaitu : (Fitriahadi & Utami, 2020)

a) Hodge I

Adalah bidang sejajar dengan pintu atas panggul yang dibentuk secara berturut oleh promontorium, artikulasio iliaka, sayap sacrum, linea inominata, ramus superior, dan tepi atas simpisis pubis.

b) Hodge II

Merupakan bidang setinggi tepi bawah simpisis pubis yang berhimpitan dengan Hodge I

c) Hodge III

Merupakan bidang setinggi spina ischiadika yang berhimpitan dengan hodge I dan II.

d) Hodge IV

Merupakan bidang setinggi os koksigis yang berhimpitan dengan hodge I, II, dan III

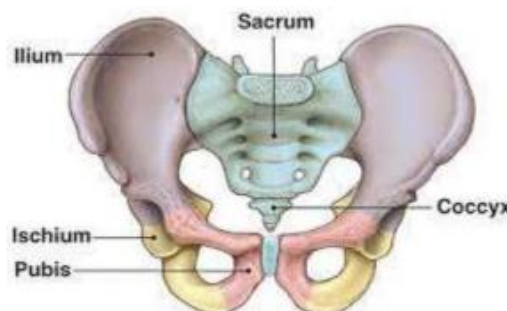
Tulang panggul dipisahkan oleh pintu atas panggul menjadi dua bagian, yaitu: (Harwijayanti et al., 2022)

a) Pervis mayor

Yaitu bagian diatas pintu atas panggul dan tidak berkaitan dengan persalinan.

b) Pelvis minor

Menyerupai suatu saluran yang tidak menyerupai sumbu melengkung ke depan.

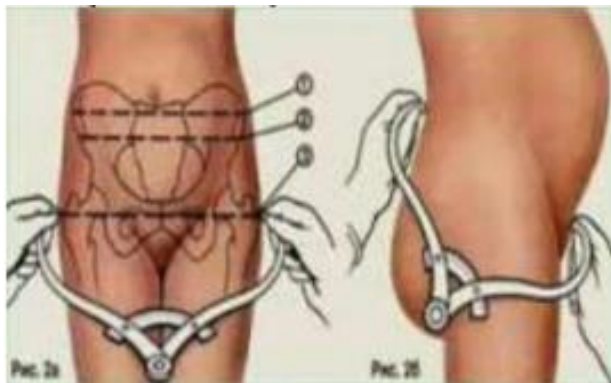


Gambar 8.1 Panggul Wanita (Harwijayanti et al., 2022)

Panggul juga memiliki ukuran-ukuran yang dibentuk antar tulang hingga terdapat sambungan antar tulang. Ukuran-ukuran panggul yaitu : (Fitriahadi & Utami, 2020)

a) Panggul Luar, terdapat empat diameter panggul luar yaitu : (Simin et al., 2012)

- 1) Distansia Spinarum, yaitu diameter yang dibentuk antara kedua tulang spina iliaka anterior superior kanan dan kiri sebesar 24-26 cm.
- 2) Distansia Kristarum, yaitu diameter yang terbesar diantara kedua tulang krista iliaka kanan dan kiri sebesar 28-30 cm.
- 3) Konjugata Eksterna, yaitu diameter yang terletak antara tulang lumbal V dengan tepi atas simpisis pubis sebesar 18-20 cm.
- 4) Lingkar panggul, yaitu pengukuran dengan metlin yang dihitung dari tepi atas simpisis pubis ke pertengahan antara trochanter serta spina iliaka anterior superior ke lumbal V dan kembali lagi disisi satunya hingga kembali ke tepi atas simpisis pubis. Ukuran lingkar panggul wanita umumnya 80-90 cm.

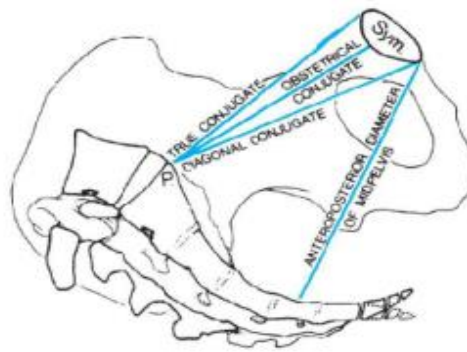


Gambar 8.2 Ukuran Panggul Luar (Harwijayanti et al., 2022)

b) Panggul Dalam, terdapat beberapa batas pada panggul dalam, yaitu : (Fitriahadi & Utami, 2020)

1) Pintu Atas Panggul (PAP)

- (a) Diameter antero posterior, sering disebut dengan Konjugata Vera adalah ukuran diameter antara promontorium dan tepi atas simpisis yaitu sebesar 11 cm.
- (b) Diameter transversa, yaitu diameter melintang merupakan jarak terlebar yang terletak antara kedua linea inominata sebesar 13 cm.
- (c) Diameter oblique atau diameter miring yang diukur dari jarak antara artikulasio sakro iliaka dengan tuberkulum pubikum sebesar 12 cm



Gambar 8.3 Pintu Atas Panggul (Pahlavi et al., 2017)

2) Bidang Tengah Panggul, yang terdiri atas bidang luas panggul dan bidang sempit panggul

(a) Bidang Luas Panggul

Bidang ini adalah bidang dengan ukuran yang terbesar dan tidak akan menimbulkan masalah pada saat terjadi penurunan kepala. Bidang ini terbentuk dari pertengahan simpisis, pertengahan acetabulum, dan ruas antara sacrum ke 2 dan ke 3 dengan ukuran diameter anteroposterior sebesar 12,75 cm dan ukuran diameter transversa sebesar 12,5 cm.

(b) Bidang Sempit Panggul

Bidang ini adalah bidang dengan ukuran kecil yang terbentuk dari tepi bawah simpisis pubis, tepi bawah spina ischiadika kiri dan kanan, serta ujung bawah sacrum dengan jarak 1-2 cm dengan ukuran diameter anteroposterior 11,5 cm dan diameter transversa 10 cm.

3) Pintu Bawah Panggul, bidang ini terbentuk dari dua segitiga dengan alas yang sama dan dinamakan diameter tuber ischiadicum dengan ujung segitiga depan adalah arkus pubis dan ujung segitiga belakang adalah os sacrum. Bidang ini memiliki tiga diameter yaitu : (Fitriahadi & Utami, 2020)

(a) Diameter anteroposterior sebesar 11,5 cm yang dibentuk dari tepi bawah simpisis pubis ke ujung sacrum.

(b) Diameter transversa sebesar 10,5 cm yang dibentuk antar tuber ischiadika kiri dan kanan.

(c) Diameter sagitalis posterior sebesar 7,5 cm yang dibentuk dari ujung sacrum ke pertengahan ukuran diameter transversa.

3. Power

Power atau tenaga merupakan kekuatan yang memberi kode janin dan membantu janin untuk lahir. Power dalam proses persalinan terbagi menjadi tenaga primer dan sekunder.

a. Primer

Tenaga primer berasal dari kontraksi uterus yang berlangsung dari akhir kehamilan (Braxton Hicks) sampai pembukaan lengkap.

b. Sekunder

Tenaga sekunder berasal dari kekuatan ibu ketika pembukaan sudah lengkap dan mulai dipimpin mengejan oleh bidan atau dokter.

Power yang memiliki kontribusi sangat besar pada saat persalinan adalah tenaga yang dihasilkan dari kontraksi dan retraksi otot rahim, kontraksi otot perut dan diafragma serta beberapa ligament. Kekuatan yang mendorong janin keluar terdiri dari : (Hidayat, 2013)

- a. Kontraksi atau His dari otot uterus yang menguncup sehingga lebih pendek dan menebal sehingga menyebabkan rongga uterus menjadi lebih kecil dan mendorong janin dan kantung amnion ke arah segmen bawah Rahim dan serviks.
- b. Kontraksi otot-otot pada dinding perut.
- c. Kontraksi diafragma pervis atau kekuatan mengejan.
- d. Ketegangan dari ligamentous action terutama ligament rotundum.

4. Position

Posisi ibu secara anatomi dan fisiologi akan mempengaruhi terhadap proses persalinan (Fitriahadi & Utami, 2020). Contohnya posisi tegak dapat memungkinkan ibu mengalami persalinan yang lebih cepat karena gaya gravitasi, posisi miring ke kiri dapat memungkinkan ibu istirahat diantara kontraksi dan memperbesar suplay oksigen ke janin karena uterus tidak menekan vena kava inferior, dan lain sebagainya.

5. Psikologi

Psikologi ibu dan penolong penting untuk persalinan. Psikologi ibu yang ketakutan, merasa sakit, tidak berharga akan membuat nyeri semakin terasa karena lepasnya hormone adrenalin dan kortisol. Psikologi penolong yang tidak tenang dalam membantu proses persalinaan akan membuat ibu merasa tidak nyaman dan ibu akan merasa nyerinya bertambah. Penting sekali untuk membangun rasa percaya antara ibu bersalin dengan penolong. Perubahan psikologi dan perilaku ibu pada saat persalinan kala I yang sebagian besar merasa takut terutama pada ibu primigravida (Hidayat, 2013). Psikologi ibu berhubungan erat dengan kontraksi uterus. Ibu yang memiliki masalah psikologi seperti cemas, takut, dan marah maka menyebabkan kontraksi lemah dan sedang, sedangkan ibu yang memiliki perasaan rileks dan tenang akan menjadikan kontraksi semakin

adekuat. Pada ibu yang memiliki gangguan psikologi memiliki risiko persalinan lama karena kelainan uterus yang berdampak pada lambatnya proses persalinan (Tanjung & Jahriani, 2022).

6. Provider

Provider atau penolong dalam persalinan memiliki peran mengantisipasi, mendeteksi dini, dan menangani komplikasi yang mungkin akan terjadi baik pada ibu maupun janin. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan penolong dalam proses persalinan. Bidan memiliki tanggung jawab besar dalam menangani proses persalinan. Kompetensi yang dimiliki bidan harus baik untuk membantu proses persalinan dan mencegah kematian maternal dan neonatal. Kompetensi yang dimaksud adalah pengetahuan, keterampilan, dan etika. Ibu bersalin dan bidan yang saling percaya dan bekerja sama akan meningkatkan kemampuan kepercayaan diri pada diri bidan sehingga keduanya akan siap dalam menghadapi persalinan yang aman dan nyaman (Tanjung & Jahriani, 2022).

D. Kesimpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya persalinan adalah Power (tenaga ibu), Passage (jalan lahir), Passanger (janin), Posisi, Psikologi, dan Provider.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriahadi, E., & Utami, I. (2020). *Buku Ajar Asuhan Persalinan dan Managemen Nyeri Persalinan*. Universitas' Aisyiyah Yogyakarta.
- Harwijayanti, B. P., Rohmah, H. N. F., Elyasari, E., Mogan, M., Saleh, U. K. S., Simanjuntak, H., Kartikasari, M. N. D., Farming, W. S., Hutomo, C. S., & Kusuma, D. C. R. (2022). *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Hidayat, A. (2013). *Asuhan Kebidanan Persalinan*. Nuha Medika.
- Pahlavi, I. R., Sari, R. D. P., & Ramkita, N. (2017). Multigravida dengan Riwayat Sectio Caesarea Atas Indikasi Disproporsi Kepala Panggul dengan Penyerta Tumor Paru, Kekurangan Energi Kronik dan Anemia Berat. *Jurnal Medula*, 7(4), 30–36. <http://www.ejurnalbidanbestari-poltekkesbjm.com/index.php/JKB/article/view/38/31>
- Simin, N. A., Kalangi, S. J. R., & Wongkar, D. (2012). Ukuran Lebar Panggul Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi dengan Tinggi Badan di Bawah 150 cm. *Jurnal Biomedik*, 4(3), 93–100.
- Sulfianti, S., Indrayani, I., Purba, D. H., Sitorus, S., Yuliani, M., Haslan, H., Ismawati, I., Sari, M. H. N., Pulungan, Wahyuni, W., Hutabarat, J., ANggraini, D. D., Purba, A. M. V., & Aini, F. N. (2020). *Asuhan Kebidanan pada Persalinan*. Yayasan Kita Menulis.
- Tanjung, R. D. S., & Jahriani, N. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persalinan Normal di Klinik Harapan Bunda Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2021. *Jurnal Gentle Birth*, 5(1), 1–7.
- Yeyeh, R. A. (2013). *Asuhan Kebidanan II (Persalinan)*. Trans Info Media.
- Yulizawati, Y., Insani, A. A., B, L. E. S., & Andriani, F. (2019). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Persalinan*. Indomedia Pustaka.

BAB 9

MEKANISME PERSALINAN

Yuli Astuti, S.S.T., M.Keb



BAB 9

MEKANISME PERSALINAN

Yuli Astuti, S.S.T., M.Keb

A. Pendahuluan

Persalinan fisiologi normal merupakan adalah persalinan yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan ibu dan janin sesuai dengan sifat alamiahnya. Proses persalinan fisiologis lebih aman dan sehat karena tidak ada intervensi yang tidak dibutuhkan yang mengganggu proses-proses fisiologis normal selama masa persalinan. Meskipun beberapa kasus komplikasi dapat terjadi pada ibu maupun janin, dukungan proses persalinan fisiologis pada adanya komplikasi memiliki potensi dalam mengoptimalkan luaran persalinan yang baik bagi ibu maupun janin (ACNM, 2013).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan seorang wanita bersalin dengan fisiologis adalah dari factor penolong persalinan, yaitu salah satunya pendidikan, pengetahuan, kompetensi, keterampilan, dan kepercayaan diri dalam mendukung proses persalinan normal (ACNM, 2013). Salah satu pengetahuan esensial yang harus dimiliki penolong persalinan adalah pengetahuan mengenai mekanisme persalinan. Dengan memiliki pengetahuan yang baik mengenai mekanisme persalinan diharapkan mempermudah bidan dalam memvisualisasikan apa yang terjadi selama persalinan dan membantu posisi yang mendukung proses persalinan tersebut. Hal ini merupakan pengetahuan penting untuk mendukung upaya bidan dalam mengoptimalkan asuhan persalinan fisiologis.

Seiring dengan kemajuan persalinan, janin bergerak menuruni jalan lahir dan didorong untuk melakukan berbagai pergerakan karena adanya dorongan, dan menyebabkan janin melakukan pergerakan mengikuti jalan lahir. Pergerakan ini disebut mekanisme persalinan (McDonald & Magill-Cuerden, 2011).

B. Tujuan

Tujuan sub topik ini adalah untuk memahami mekanisme pergerakan janin menuruni jalan lahir (mekanisme persalinan) pada persalinan fisiologis.

C. Pembahasan

Mekanisme persalinan merupakan serangkaian pergerakan yang terjadi pada kepala janin pada proses adaptasi selama perjalanan melalui rongga panggul. Selama perjalanan kepala janin melalui tulang-tulang panggul atau jalan lahir, mengikuti serangkaian gerakan yang secara sederhana dideskripsikan sebagai gerakan cardinal (*cardinal movement*). Karena bentuk kepala janin dan tulang panggul yang tidak

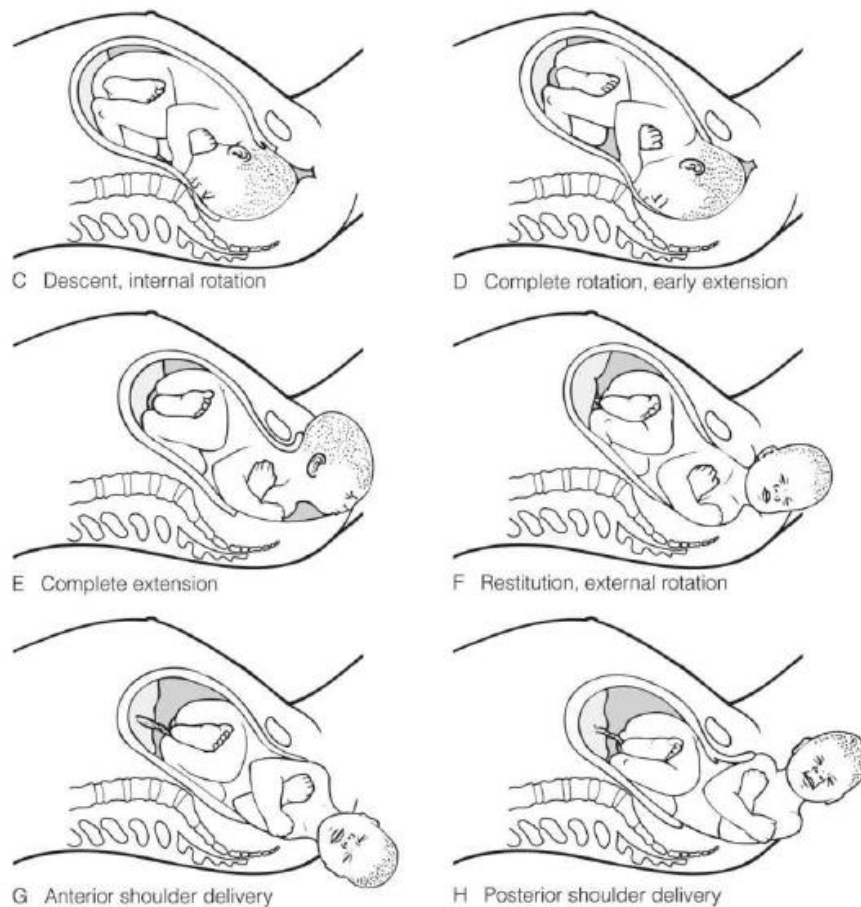
simetris, beberapa gerakan dibutuhkan agar janin berhasil keluar dari jalan lahir (Arulkumaran & Warren, 2016).

Ada mekanisme tersendiri untuk setiap presentasi dan posisi kepala janin. Diameter terbesar pintu atas panggul adalah diameter transversa, sedangkan diameter terbesar pintu bawah panggul adalah diameter anteroposterior. Untuk memanfaatkan rongga yang ada, diameter presentasi terluas kepala janin biasanya memasuki panggul pada diameter transversa. Karena posisi oksipitolateral paling banyak terjadi, mekanisme persalinan tersebutlah yang akan dideskripsikan dalam pembahasan ini.

Pada persalinan normal, kepala janin memasuki rongga panggul secara umum sejajar dengan diameter transversa (70%) dan sebagian kecil lainnya memasuki panggul sejajar dengan diameter oblique. Dengan demikian, janin masuk ke panggul dengan posisi oksipitolateral atau oblique oksipito anterior. Oksipito anterior kiri terjadi lebih jarang dibanding oksipito anterior kanan karena diameter oblique kiri dibatasi oleh adanya rectum. Bagian kepala janin yang engage dengan diameter anteroposterior adalah diameter suboksipitobregmatika (9,5 cm) atau pada posisi sedikit defleksi/suboksipito frontal (10 cm). Diameter transfer saat kepala engage adalah ukuran biparietal (9,5cm) (Dutta, 2015).

Prinsip dari pergerakan kepala janin adalah: (1) engagement, (2) penurunan, (3) fleksi, (4) putaran paksi dalam, (5) crowning, (6) ekstensi, (7) restitusi, (8) putaran paksi luar, dan (9) ekspulsi. Meskipun pergerakannya akan dijelaskan secara terpisah, namun realitanya ada beberapa gerakan yang mungkin terjadi secara simultan/bersamaan (Dutta, 2015).

Memiki pemahaman mengenai mekanisme persalinan membantu dalam memahami penilaian kemajuan persalinan, dan rekognisi kapan dukungan psikologi dibutuhkan, atau pendampingan harus dilaksanakan.



Gambar 9.1
Tahapan Mekanisme Persalinan

1. Engagement

Engagement terjadi ketika diameter maksimum kepala janin (suboksipito-bregmatika dan biparietal, ketika kepala fleksi maksimum) telah melewati pintu atas panggul. Pada saat engagement diameter biparietal berada pada konjugata veradan vertex berada pada 1 cm di atas spina isciadika. Pada presentasi bokong diameter terbesar adalah diameter bi-trochantik.

Secara normal kepala janin masuk ke PAP dengan posisi miring (oksipito transversa) atau oblique (oksipito transversa kanan/oksipito transversa kiri). Hal ini terjadi karena sutura sagitalis tidak sepenuhnya sesuai dengan diameter transversa yang tersedia, hal ini berarti sutura sagitalis masuk dalam keadaan melintang terhadap jalan lahir.

Kepala janin juga mungkin masuk ke PAP dengan presentasi oksopito anterior dan oksipito posterior. Pada keadaan ini tulang parietal sama tinggi, dan keadaan ini dinamakan sinklitismus. Kepala janin juga bisa masuk ke pintu atas

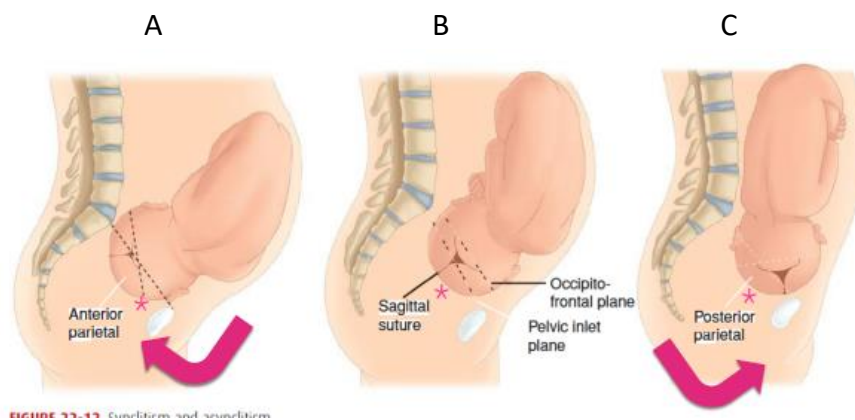
panggul dapat juga dalam keadaan sutura sagitalis mendekati promontorium atau symfisis. Hal tersebut disebut dengan **asinklitismus** (Dutta, 2015).

Jika sutura sagitalis mendekati bagian anterior, tulang parietal posterior menjadi presentasi janin terdepan dan ini dinamakan **asinklisismus posterior** atau presentasi pasietal posterior. Keadaan ini lebih banyak terjadi pada primigravida karena uterus dan dinding abdomen masih dalam kondisi optimal. Jika sutura sagitalis dalam posisi posterior, maka posisi tulang parietal anterior menjadi presentasi janin terdepan dan disebut presentasi parietal anterior atau **asinklitismus anterior**. Ini lebih sering terjadi pada primipara. (Dutta) Sudut asinklitismus ringan merupakan hal yang normal, namun apabila sudut asinklitismus cukup besar, hal ini merupakan indikasi adanya *cephalopelvic disproportion* (CPD).

Kepala bayi mengalami fleksi lateral posterior untuk membuat tulang anterior parietal melewati simfisis pubis pada presentasi parietal posterior. Fleksi lateral pada arah yang berlawanan terjadi untuk membuat tulang parietal posterior melewati promontorium pada presentasi parietal anterior. Setelah pergerakan ini terjadi pada awal persalinan, tidak hanya kepala janin yang masuk ke pintu atas panggul, tapi juga terjadi sinklitismus. Bagaimanapun, sekitar 25% kasus kepala janin masuk ke pintu atas panggul secara sinklitismus.

Terdapat keuntungan kepala janin masuk ke PAP secara asinklitismus, yaitu kedua tulang parietal masuk ke PAP secara bersamaan sehingga membantu memperkecil diameter kepala bayi yang masuk (super-subparietal : 8,5 cm), sedangkan pada posisi sinklitismus kepala janin masuk ke PAP dengan diameter biparietal (9,5 cm).

Pada primigravida engagement secara signifikan terjadi sebelum dimulainya proses persalinan, sedangkan pada multigravida biasanya engagement baru terjadi pada akhir kala I persalinan bersamaan dengan pecahnya ketuban.



Gambar 9.2

A. Asinklitismus parietal anterior, B. Sinklitismus, C. Asinklitismus parietal posterior

Selain masuk ke PAP dengan presentasi oksipito transverse, kepala janin juga mungkin masuk ke PAP dengan presentasi oksipito anterior dan presentasi oksipito posterior. Namun, dengan posisi tersebut janin tidak masuk ke PAP dengan diameter yang terkecil sehingga proses persalinan akan terhambat (Dutta, 2015).

Engagement dapat dikonfirmasi secara klinis dengan palpasi abdomen ketika 2/5 bagian kepala dapat dipalpasi dari abdomen, dengan konfirmasi pemeriksaan penurunan kepala janin melalui pemeriksaan dalam. Paritas, usia kehamilan, tinggi dan berat lahir janin memainkan peran signifikan dalam mengetahui waktu kepala janin engage, dan harus disadari ketika menilai kondisi pasien (Arulkumaran & Warren, 2016).

2. Penurunan (*descent*)

Penurunan kepala janin merupakan proses yang berkelanjutan jika tidak ada tulang atau jaringan lunak yang menghambat jalan lahir. Penurunan kepala janin terjadi dengan lambat dan tidak signifikan pada kala I tetapi berlangsung lebih cepat pada kala II. Penurunan kepala janin diakhiri dengan ekspulsi janin. Pada primigravida, dengan terjadinya engagement kepala janin, secara praktis tidak ada penurunan pada kala I persalinan dan penurunan terjadi pada kala II. Pada multipara penurunan kepala dimulai dengan engagement. Kepala diharapkan mencapai dasar pelvis saat serviks sudah membuka lengkap. Faktor yang memfasilitasi cepatnya penurunan kepala janin:

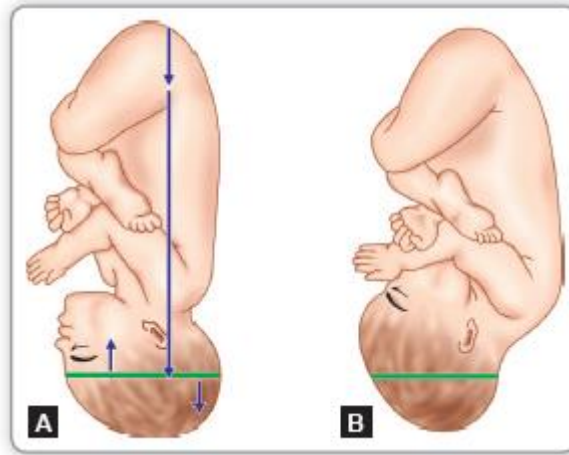
- a. Dorongan dari kontraksi uterus
- b. Usaha meneran ibu
- c. Posisi janin yang lurus terutama setelah air ketuban pecah (Dutta, 2015)

Penurunan kepala biasanya dideskripsikan dengan angka dari perlimaan bagian kepala janin yang dapat diraba secara abdomen atau hasil pemeriksaan station melalui pemeriksaan dalam (penurunan kepala terhadap spina ischiadika) (Arulkumaran & Warren, 2016).

3. Fleksi

Fleksi kepala janin terjadi secara pasif selama kepala janin mengalami penurunan. Fleksi difasilitasi oleh bentuk tulang panggul dan resistensi segmen bawah uterus, dinding samping pelvis, dan dasar pelvis (Arulkumaran & Warren, 2016). Pada awal persalinan kepala janin umumnya mengalami sedikit fleksi, sementara fleksi penuh jarang terjadi. Saat kepala terhambat oleh jalan lahir saat mengalami penurunan, fleksi penuh terjadi. Tekanan sumbu janin ditransmisikan melalui oksiput, yang didorong ke bawah sebagai konsekuensinya. Dahi didorong ke atas oleh resistensi dari bagian lunak jalan lahir, dan fleksi penuh terjadi. Jika panggul luas, fleksi dapat terjadi karena resistensi serviks, dinding pelvis atau otot

dasar panggul. Fleksi dapat terjadi sebelum atau bersamaan dengan putaran paksi dalam. Proses fleksi kepala janin sangat penting karena dengan melakukan fleksi, diameter kepala janin mencapai ukuran yang lebih kecil untuk memasuki jalan lahir (Dutta, 2015).



Gambar 9.3 Proses fleksi kepala janin mengecilkan diameter kepala yang menyusuri jalan lahir yaitu dari posisi A. oksipitofrontal ke B. suboksipitobregmatika

4. Putaran Paksi Dalam

Putaran paksi dalam merupakan pergerakan yang penting dalam proses persalinan meskipun pada pergerakan ini tidak ada penurunan kepala janin. Mekanisme putaran paksi dalam sangat kompleks, meskipun mudah untuk dideskripsikan. Teori yang menjelaskan rotasi anterior oksiput yaitu:

- Lekukan pada dasar panggul: kedua bagian otot levator ani membentuk saluran dan terlihat dari atas, yang mana arah serabut ototnya menuju bagian belakang dan ke arah garis tengah. Selama terjadi kontraksi, kepala janin terutama oksiput berada pada posisi fleksi yang baik, otot levator ani meregang terutama pada bagian yang bersinggungan dengan oksiput. Setelah kontraksi berkurang, elastisitas otot levator ani menurun dan mengakibatkan oksiput ke depan menuju garis tengah. Proses ini terjadi berulang-ulang hingga oksiput menempati bagian anterior. Hal inilah yang disebut rotasi berdasarkan hukum dasar pelvis (Hart's rule).
- Bentuk panggul: kemiringan dinding samping rongga panggul ke arah depan, jarak kedua spina sichiadika yang sempit, dan diameter anteroposterior kepala janin yang besar pada pintu bawah panggul menempatkan sumbu panjang kepala bayi mengakomodasi diameter terbesar yang tersedia, yaitu diameter anteroposterior dari pintu bawah panggul meninggalkan diameter bispinosus (diameter antar kedua spina isciadika) yang kecil.
- Hukum fleksibilitas tak sesuai (*Law of unequal flexibility*): putaran paksi dalam terutama terjadi karena adanya perbedaan fleksibilitas komponen bagian janin.

Pada posisi oksipitolateral, akan terjadi rotasi ke depan sebanyak 90°, sedangkan pada posisi anterior oblique, rotasi akan terjadi 45°, menempatkan oksiput di belakang simfisis pubis. Gerakan putaran paksi dalam selalu disertai dengan penurunan kepala. Dengan demikian, pra syarat terjadinya putaran paksi dalam adalah kepala yang fleksi, kontraksi uterus yang adekuat, bentuk bagian tengah panggul yang mendukung, dan tonus otot levator ani yang baik.

Tempat terjadinya putaran paksi dalam bervariasi. Rotasi yang terjadi di serviks adalah hal yang jarang terjadi. Sebagian besar putaran paksi dalam terjadi di dasar panggul, dan pada sebagian kecil kasus terjadi pada saat kepala crowning.

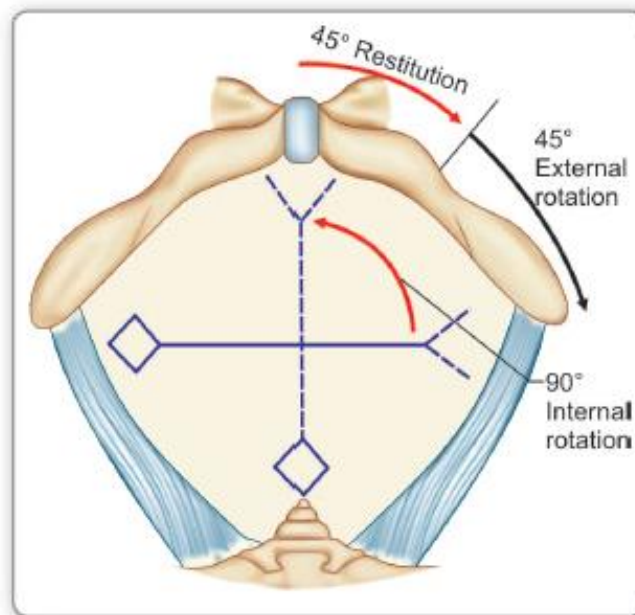


Fig. 13.14: Degree of internal rotation, restitution and external rotation of the head in left occipitolateral position

Gambar 9.4

Torsi leher adalah kejadian yang tidak bisa dihindari saat terjadi putaran paksi dalam. Apabila bahu tetap berada pada diameter anteroposterior, leher akan mengalami torsi 90° sesuai dengan derajat putaran kepala, namun leher gagal mempertahankan posisi ini, sehingga terjadi rotasi simultan bahu ke arah yang sama sejauh 45° yang menempatkan bahu pada diameter oblique dengan 45° masih tersisa. Dengan demikian, bahu bergerak menempati diameter oblik kiri pada posisi oksipitolateral kiri dan diameter oblik kanan pada posisi oksipitolateral kanan. Pada posisi oblique oksipitoanterior tidak ada pergerakan bahu dari diameter oblique karena leher hanya menopang torsi 45°.

5. Crowning

Setelah putaran paksi dalam, penurunan lebih lanjut terjadi hingga suboksiput berada di bawah archus pubis. Pada tahap ini diameter maksimum kepala (diameter biparietal) meregangkan vulva dan kepala tidak mundur kembali saat kontraksi berhenti yang disebut dengan crowning kepala bayi.

6. Ekstensi

Lahirnya seluruh kepala janin terjadi melalui proses ekstensi kepala. Terjadinya ekstensi disebabkan adanya kekuatan dorongan yang menuju arah bawah, sementara dasar panggul memberikan perlawanan ke atas dan ke depan. Gaya ke bawah dan ke atas menetralkan dan dorongan ke depan yang tersisa membantu terjadinya ekstensi. Dengan terjadinya ekstensi lahirlah berturut-turut kepala janin meliputi puncak kepala, alis dan wajah. Setelah dagu keluar melalui batas anterior perineum yang meregang, kepala turun ke bawah, sehingga dagu berada di dekat lubang anus ibu.

7. Restitusi

Restitusi merupakan pergerakan pasif kepala karena adanya torsi yang terjadi saat putaran paksi dalam. Pergerakan restitusi terjadi dengan memutar kepala berlawanan dengan arah putaran paksi dalam. Oleh karena itu, oksiput bergerak menuju pada ibu ke arah posisi asalnya.

8. Putaran paksi luar

Putaran paksi luar adalah gerak rotasi kepala yang terlihat di luar karena adanya rotasi internal pada bahu. Karena bahu berotasi ke arah simfisis pubis dari diameter oblique, kepala berputar menyesuaikan pergerakan tersebut sehingga terlihat putaran kepala 45° pada arah yang sama dengan restitusi. Kemudian bahu berada pada posisi diameter anteroposterior. Oksiput mengarah langsung ke paha ibu sesuai dengan sisi awal saat terjadi engagement.

9. Ekspulsi

Setelah bahu berada pada posisi diameter anteroposterior, penurunan lebih lanjut terjadi hingga bahu anterior melewati simfisis pubis. Dengan gerak fleksi lateral pada spina, bahu posterior melewati perineum, kemudian seluruh tubuh lahir dengan fleksi lateral.

D. Kesimpulan

Mekanisme persalinan terdiri dari 9 fase, yaitu engagement, penurunan, fleksi, putaran paksi dalam oksiput anterior berputar 90° dan secara bersamaan bahu ikut berputar 45°, crowning, ekstensi, restitusi, putaran paksi luar, dan ekspulsi. Restitusi dapat terjadi bersamaan dengan putaran paksi luar. Pada posisi oksipito lateral, diameter kepala janin saat engagement adalah suboksipito bregmatika (9,5 cm) atau suboksipito frontal (10 cm).

DAFTAR PUSTAKA

- ACNM. (2013). Supporting Healthy and Normal Physiologic Childbirth: A Consensus Statement by ACNM, MANA, and NACPM. *The Journal of Perinatal Education*, 22(1), 14–18. <https://doi.org/10.1891/1058-1243.22.1.14>
- Arulkumaran, S., & Warren, R. (Eds.). (2016). *Best Practice in Labour and Delivery* (2nd ed.). London: Cambridge University Press.
- Dutta, D. (2015). *Dutta's Textbook for Midwifery* (8th ed.; H. Konar, ed.). New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd.
- McDonald, S., & Magill-Cuerden, J. (Eds.). (2011). *Mayes' Midwifery* (15th ed.). Elsevier.

BAB 10

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

KEJADIAN RUPTURE PERINEUM

Ika Lustiani, S.ST., M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 10

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN RUPTURE PERINEUM

Ika Lustiani, S.ST., M.Kes

A. Pendahuluan

Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat derajat kesehatan masyarakat di suatu Negara. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 7.389 ibu di Indonesia meninggal pada 2021. Jumlah tersebut meningkat 59,69% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 4.627 orang. Sebagian besar kematian ibu pada 2021 disebabkan oleh Covid-19, yakni 2.982 orang. Sebanyak 1.320 ibu meninggal akibat pendarahan, Ada pula 1.077 ibu yang meninggal akibat hipertensi dalam kehamilan. Penyakit jantung menjadi penyebab kematian dari 335 ibu, Serta ibu yang meninggal dunia akibat infeksi dan gangguan metabolik masing-masing sebanyak 207 orang dan 80 orang. Lalu, sebanyak 65 ibu meninggal akibat gangguan sistem peredaran darah. Sebanyak 14 ibu lainnya meninggal akibat abortus. Sedangkan, terdapat penyebab lainnya yang merenggut nyawa 1.309 ibu di Indonesia sepanjang tahun lalu (Data Indonesia, 2022).

Sejalan dengan AKI Indonesia, Dinkes Provinsi Banten mengatakan angka kematian ibu mengalami peningkatan sangat tajam pada tahun 2021 yakni diangka 298 Orang. AKI Tahun 2022 per September terdapat 137 kasus AKI. Kasus itu menyebar di Kabupaten Pandeglang 17, Lebak 28, Kabupaten Tangerang 21. Kabupaten Serang 31, Kota Tangerang 2. Cilegon 3, Kota Serang 17, dan Tangerang Selatan ada 8 kasus (Banpos.co, 2022)

Salah satu penyebab tingginya morbiditas dan mortalitas ibu adalah infeksi, dimana infeksi tersebut dapat berawal dari ruptur perineum.

Pada tahun 2015 terjadi kasus ruptur perineum pada ibu bersalin yang dimana terdapat 2,7 juta kasus ruptur perineum pada ibu bersalin di seluruh dunia, dimana angka ini diperkirakan akan mencapai 6,3 juta pada tahun 2050. Di Amerika 26 juta ibu bersalin yang mengalami ruptur perineum, sedangkan di Asia ruptur perineum juga merupakan masalah yang cukup banyak dalam masyarakat, 50% dari kejadian ruptur perineum di dunia terjadi di Asia. Prevalensi ibu bersalin yang mengalami ruptur perineum di Indonesia pada golongan umur 25-30 tahun yaitu 24%, sedangkan pada ibu bersalin usia 32-39 tahun sebesar 62% pada 3 minggu terakhir bulan juli 2016 kejadian ruptur perineum di tempat penelitian sebanyak 80% dari 10 persalinan (Risnawati, 2016)

Menurut Mochtar R., 2012 faktor yang menyebabkan Rupture perineum meliputi yaitu faktor maternal, faktor janin dan faktor penolong. Dampak dari

terjadinya Rupture perineum pada ibu antara lain terjadinya infeksi pada luka jahitan dimana dapat berakibat munculnya komplikasi infeksi kandung kemih maupun infeksi pada jalan lahir. Selain itu juga dapat terjadi perdarahan bahkan jika penanganannya lambat dapat menyebabkan terjadinya kematian.

Faktor maternal meliputi perineum yang rapuh dan oedema, primigravida, kesempitan pintu bawah panggul, kelenturan jalan lahir, mengejan terlalu kuat, partus presipitatus, persalinan dengan tindakan seperti ekstraksi vakum, ekstraksi forsep, versi ekstraksi dan embriotomi, varikosa pada pelvis maupun jaringan parut pada perineum dan vagina. Faktor janin meliputi janin besar, posisi abnormal seperti oksipitoposterior, presentasi muka, presentasi dahi, presentasi bokong, distosia bahu dan anomali kongenital seperti hidrosefalus. Faktor penolong meliputi cara memimpin mengejan, cara berkomunikasi dengan ibu, keterampilan menahan perineum pada saat ekspulsi kepala, episiotomi dan posisi meneran (Dewi D, 2012).

Seorang bidan yang telah memahami faktor-faktor penyebab terjadi ruptur perineum pada saat persalinan kala II, dapat melakukan antisipasi untuk menghindari tingginya angka kejadian ruptur perineum seperti menyarankan senam kegel dan pijat perineum pada ibu hamil yang mempunyai resiko terjadinya ruptur perineum.

Salah satu upaya bidan untuk mencegah terjadinya Rupture perineum adalah melindungi perineum pada kala II persalinan saat kepala bayi membuka vulva (diameter 5-6 cm) dengan melakukan penatalaksanaan persalinan sesuai standart asuhan persalinan normal (60 langkah APN) untuk mengontrol lahirnya kepala, bahu, lengan dan kaki dan akan memberikan waktu bagi kulit untuk meregang sehingga mengurangi kemungkinan Rupture perineum (JNPK - KR, 2017).

B. Tujuan

Tujuan umum sub topik materi mengetahui hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian ruptur perineum pada persalinan kala II (pengeluaran janin) di Puskesmas Curug Kota Serang Provinsi Banten Bulan Mei – Juli Tahun 2022.

Adapun tujuan khusus sub topik materi untuk mengetahui hubungan umur ibu, paritas, jarak kelahiran, partus presipitatus, berat lahir janin dan penolong persalinan dengan kejadian ruptur perineum di Puskesmas Curug Kota Serang Provinsi Banten Tahun 2022.

C. Pembahasan

1. Anatomi Perineum

Menurut Moore, 2014 Perineum terletak antara vulva dan anus. Jaringan yang mendukung perineum terutama ialah diafragma pelvis dan diafragma urogenitalis. Perineum mendapat pasokan darah terutama dari a.pudenda interna dan cabang cabangnya. Persarafan perineum terutama oleh nervus pudendus dan cabang cabangnya. (Hardiyanti, 2022).

Badan perineum berfungsi untuk memperkuat dasar panggul. Menurut Kraima 2016 dalam Hardianti 2022 Otot-otot pada badan perineum terdiri dari:

- a. Otot bulbospongiosus muscle (striated muscle) berjalan secara anterolateral kearah badan perineum.
- b. Otot deep transverse perineal (pada pria) berjalan secara lateral kearah badan perineum.
- c. Otot compressor urethra (pada wanita) berjalan secara anterior badan perineum.
- d. Otot sfingter ani eksterna berjalan secara posterolateral kearah badan perineum
- e. Otot sfingter ani interna bersamaan dengan musculus levator ani (LAM) akan berjalan secara posterior kearah badan perineum.
- f. Otot sfingter uretra eksterna berjalan secara anterior ke badan perineum
- g. Otot levator ani (the internal fibers of the puborectalis muscle) berjalan secara lateral pada badan perineum berjalan vertical
- h. Otot rekto-uretralis (perineal smooth muscle) berjalan dari musculus levator ani (LAM) secara lateral ke kelenjar bulbouretralis dan melekat secara anterolateral ke otot puborektalis.
- i. Musculus levator ani (LAM) melekat kuat di anterior dan anterolateral ke badan perineum dan otot puborectalis.

Terdapat dua struktur fascia yang berada di badan perineum, yaitu fascia perineum superfisial, menghubungkan membrane perineum dengan badan perineum anterior; rectovaginal septum (wanita) bergabung dengan badan perineum superior. Recto prostatic septum (pria) bergabung dengan badan perineum superior. Badan perineum berperan penting untuk menjaga integritas pada dasar panggul, terutama pada wanita. Robekan pada badan perineum dapat terjadi selama persalinan pervaginam. Badan perineum dapat pecah selama persalinan pervaginam (Hinata, 2014 dalam Hardiyanti, 2022)

2. Pengertian Rupture Perineum

Ruptur adalah robek atau koyaknya jaringan secara paksa. Sedangkan perineum adalah lantai pelvis dan struktur yang berhubungan yang menempati pintu bawah panggul; bagian ini dibatasi disebelah anterior oleh symphysis pubis, disebelah lateral oleh tuber ischiadicum, dan di sebelah posterior oleh os. coccygeus (Dorland, 2002)

Ruptur perineum adalah robekan yang terjadi Ketika bayi lahir, baik secara spontan maupun dengan alat atau tindakan, sering terjadi pada garis tengah namun dapat meluas jika kepala janin lahir terlalu cepat (Winkjosastro, 2008 dalam Fatimah & Lestari, P., 2019).

Robekan perineum terjadi pada hampir semua primipara namun tidak jarang juga terjadi pada persalinan berikutnya. Beberapa cedera jaringan penyokong, baik cedera akut maupun nonakut, baik telah diperbaiki atau belum, dapat menjadi masalah ginekologis di kemudian hari (Bobak, 2012 dalam Fatimah & Lestari, P., 2019)

Jadi, rupture perineum adalah robekan yang terjadi antara vagina dan anus baik disengaja (episiotomi atau tidak (spontan) pada saat persalinan berlangsung di kala II atau pengeluaran janin.

3. Etiologi Rupture Perineum

Menurut Fatimah & Lestari, P., 2019 faktor yang menjadi penyebab ruptur perineum bisa dari ibu, janin, persalinan pervaginam, dan penolong persalinan. Berikut faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya ruptur:

a. Faktor Ibu

- **Meneran**

Meneran dengan benar adalah pada saat ibu merasakan dorongan dan memang ingin mengejan. Secara normal Ibu akan merasakan dorongan untuk meneran jika pembukaan sudah lengkap dan refleks ferguson telah terjadi.

- **Paritas**

Paritas adalah jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, baik hidup maupun mati. Paritas mempunyai pengaruh terhadap kejadian ruptur perineum. Ibu dengan paritas satu (primipara) memiliki risiko lebih besar mengalami robekan perineum daripada ibu dengan paritas lebih dari satu (multipara). Hal ini dikarenakan jalan lahir yang belum pernah dilalui oleh kepala bayi, sehingga otot-otot belum meregang.

b. Faktor Janin

- **Berat Badan Bayi Baru Lahir**

Berat badan janin yang berlebih yaitu lebih dari 3500gr dapat mengakibatkan terjadinya ruptur perineum, karena risiko trauma partus melalui vagina seperti distosia bahu dan kerusakan jaringan lunak pada ibu. Perkiraan berat janin bergantung pada pemeriksaan klinik atau ultrasonografi, maka dari itu penting sekali melakukan pemeriksaan pada masa kehamilan untuk mengetahui tafsiran berat janin.

- **Presentasi Janin**

Presentasi digunakan untuk menentukan bagian bawah rahim yang dijumpai pada palpasi atau pada pemeriksaan dalam
Ruptur perineum dapat disebabkan oleh beberapa faktor menurut Prawirohardjo, 2014 yaitu:

- Episiotomi.
- Robekan perineum spontan.
- Trauma forsep atau vakum ekstraksi, atau karena versi ekstraksi.
- Robekan perineum dari faktor ibu meliputi inpartus presipitatus, mengejan yang tidak efektif, dorongan fundus yang berlebih, edema dan kerapuhan pada perineum, varikosis vulva, arcus pubis sempit dengan pintu bawah panggul yang sempit, serta perluasan episiotomi. Faktor dari janin yaitu bayi besar, posisi kepala yang abnormal, presentasi bokong, ekstraksi forceps, dystocia bahu, hidrocephalus.
- Penggunaan oksitosin yang tidak tepat.
- Laserasi spontan pada vagina atau perineum dapat terjadi saat kepala dan bahu dilahirkan
- Kejadian laserasi akan meningkat jika bayi dilahirkan terlalu cepat dan tidak terkendali

Faktor-faktor penyebab rupture perineum dibagi menjadi faktor maternal meliputi perineum yang rapuh dan oedema, primigravida, kesempitan pintu bawah panggul, kelenturan jalan lahir, mengejan terlalu kuat, partus presipitatus, persalinan dengan tindakan seperti ekstraksi vakum, ekstraksi forsep, versi ekstraksi dan embriotomi, varikosa pada pelvis maupun jaringan parut pada perineum dan vagina. Faktor janin meliputi janin besar, posisi abnormal seperti oksipitoposterior, presentasi muka, presentasi dahi, presentasi bokong, distosia bahu dan anomali kongenital seperti hidrosefalus. Faktor penolong meliputi cara memimpin mengejan, cara berkomunikasi dengan ibu, keterampilan menahan perineum pada saat ekspulsi kepala, episiotomi dan posisi meneran (Dewi D, 2012)

4. Tingkatan/ Grade Rupture Perineum

Ruptur diklasifikasikan menurut JNPK-KR tahun 2017 berdasarkan luasnya robekan:

- a. Derajat satu : Mukosa vagina, mukosa posterior, kulit perineum.
- b. Derajat dua : Mukosa vagina, mukosa posterior, kulit perineum, dan otot perineum.
- c. Derajat Tiga : Mukosa vagina, mukosa posterior, kulit perineum, otot perineum dan otot sfingter ani.
- d. Derajat empat : Mukosa vagina, mukosa posterior, kulit perineum, otot perineum, otot sfingter ani, dan dinding depan rektum.

5. Tatalaksana Rupture perineum

Tatalaksana rupture perineum derajat 1 yang mengenai kulit perineum dan tidak mengeluarkan darah aktif dalam penatalaksanaannya tidak membutuhkan penjahitan. Penjahitan pada derajat 1 dilakukan apabila terdapat pengeluaran darah aktif. Sedangkan, rupture perineum derajat 2, 3, dan 4 dalam penatalaksanaannya dibutuhkan penjahitan. Penjahitan bertujuan untuk menyatukan kembali jaringan dan kehilangan darah yang berlebih.

Langkah-langkah penjahitan ruptur perineum derajat 2, menurut Cuningham 2012 dalam Hardiyanti 2022 sebagai berikut :

- a. Identifikasi luka menggunakan jari tangan dan tentukan batas luka. Mulai jahitan pertama dengan jarak kira-kira 1 cm dari tepi atas ujung luka di dalam vagina. Lalu potong benang pada salah satu ujung dengan ukuran $\pm 0,5$ cm
- b. Penjahitan mukosa vagina dengan teknik jelujur, arah ikatan ke bawah hingga mencapai lingkaran hymen
- c. Lanjutkan penjahitan pada mukosa vagina di depan hymen, dan jahitan dikeluarkan pada sisi dalam robekan perineum
- d. Jahitan jelujur dilanjutkan pada lapisan subkutis dan otot hingga mencapai ujung luar luka
- e. Setelah mencapai ujung luka, lakukan penjahitan balik ke arah lumen vagina dan mulai penjahitan kulit dengan teknik subkutikular
- f. Ketika mencapai batas hymen, keluarkan jarum ke arah luar dari mukosa vagina pada sisi yang berlawanan
- g. Jepit benang (sepanjang 2 cm) menggunakan klem, kemudian ditusukan kembali pada mukosa vagina pada jarak 2 mm dari tempat keluarnya benang dan jahit menyilang ke sisi berlawanan hingga menembus mukosa.
- h. Ikat benang dengan teknik simpul kunci dan Pastikan jahitan dengan cara rectal touché
- i. Akhiri dengan menutup luka jahitan menggunakan kasa

6. Penyembuhan Rupture Perineum

Kebanyakan robekan perineum terjadi sewaktu melahirkan dan penanganannya merupakan salah satu masalah kebidanan. Robekan perineum bisa terjadi spontan bisa juga karena tindakan episiotomi. Pada fase-fase penyembuhan faktor-faktor tertentu mempengaruhi penyembuhan luka seperti faktor termasuk ukuran dan tempat luka, kondisi fisiologis umum pasien, cara perawatan penyembuhan luka perineum yang tepat, serta bantuan ataupun intervensi dari luar yang ditujukan dalam rangka mendukung penyembuhan

Menurut Smeltzer 2013, lama penyembuhan luka perineum terdiri dari sebagai berikut:

- a. Cepat Jika luka perineum sembuh dalam waktu 1-6 hari, penutupan luka baik, jaringan granulasi tidak tampak.
- b. Normal Jika luka perineum sembuh dalam waktu 7-14 hari, penutupan luka baik, jaringan granulasi tidak tampak, pembentukan jaringan parut minimal, akan tetapi waktu lebih lama.
- c. Lama Jika luka perineum sembuh dalam waktu ≥ 14 hari, tepi luka tidak saling merapat, proses perbaikan kurang, kadang disertai adanya pus dan waktu penyembuhan lebih lama.

7. Faktor-Faktor Resiko Rupture Perineum

a. Hubungan Umur Ibu Dengan Kejadian Rupture Perineum

Faktor yang dianalisis secara deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang melahirkan dengan ruptur perineum pada usia tidak beresiko (20 - 35 tahun) sebanyak 48 orang (52,2%). Responden yang melahirkan dengan ruptur perineum pada usia beresiko (< 20 Tahun dan >35 Tahun) sebanyak 44 orang (47,8%). Hasil Uji statistik Kai Kuadrat (*Chi Square*) pada $\alpha = 0,05$ didapatkan nilai p sebesar 0,001 ($p \leq 0,05$) yang berarti secara statistik ada pengaruh bermakna antara umur ibu dengan kejadian ruptur perineum.

Presentasi responden dengan usia tidak beresiko, yang melahirkan usia produktif menandakan bahwa masyarakat sudah mengikuti anjuran pemerintah, walaupun perbedaan persentase tidak terlalu jauh berbeda.

Rentang usia 20-35 tahun dimana ibu dengan usia reproduksi sehat sedangkan usia diatas 35 tahun adalah usia ibu yang paling sedikit yang artinya, ibu yang hamil dan melahirkan berada pada zona aman dimana usia 20-35 tahun adalah usia yang dianggap matang secara fisik dan psikis (BKKBN, 2015)

Menurut Walyani tahun 2015, umur sangat menentukan suatu kesehatan ibu, ibu dikatakan beresiko tinggi apabila ibu hamil berusia dibawah 20 tahun dan di atas 35 tahun. Umur berguna untuk mengantisipasi diagnose masalah kesehatan dan tindakan yang dilakukan. Wanita yang melahirkan anak pada usia <20 tahun atau >35 tahun merupakan faktor risiko terjadinya perdarahan pasca persalinan oleh karena ruptur perineum. Hal ini dikarenakan pada usia dibawah 20 tahun, fungsi reproduksi seorang wanita belum berkembang dengan sempurna sedangkan pada usia >35 tahun fungsi reproduksi seorang wanita sudah mengalami penurunan dibandingkan fungsi reproduksi norma.

Persalinan membutuhkan kesiapan baik segi fisik maupun psikis, bagi ibu dengan umur yang belum genap 20 tahun sangat rentan terjadinya komplikasi persalinan salah satunya adalah ruptur perineum, berbanding terbalik dengan usia yang kurang dari 20 tahun, untuk ibu yang berusia lebih dari 35 tahun kemungkinan mengalami penurunan secara fisik walau tidak signifikan, dimana

pada saat persalinan kala 2 ibu mengerahkan semua tenaga untuk mendorong bagian bawah janin untuk keluar, secara sadar atau tidak sadar ibu lepas kontrol seperti cara mengedan yang baik, atur nafas yang baik yang berakibat terjadinya rupture perineum.

b. Hubungan Paritas Dengan Kejadian Rupture Perineum

Faktor yang dianalisis secara deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang melahirkan dengan rupture perineum pada paritas multipara sebanyak 39 orang (42,4%). Responden yang melahirkan dengan rupture perineum pada paritas primigravida sebanyak 53 orang (57,6%). Hasil Uji statistik Kai Kuadrat (*Chi Square*) pada $\alpha = 0,05$ didapatkan nilai p sebesar $0,000 = (p \leq 0,05)$ yang berarti secara statistik ada pengaruh bermakna antara paritas dengan kejadian rupture perineum.

Paritas adalah jumlah janin dengan berat badan lebih dari 500 gram yang pernah dilahirkan, hidup maupun mati, bila berat badan belum diketahui maka dipakai umur kehamilan lebih dari 24 minggu. Primipara adalah wanita yang pernah melahirkan satu kali. Multipara adalah wanita yang pernah melahirkan dua kali atau lebih. Grandemultipara adalah wanita yang pernah melahirkan lima kali atau lebih (Pusdiknakes, 2012).

Pada seorang primipara atau orang yang baru pertama kali melahirkan ketika terjadi peristiwa "kepala keluar pintu". Pada saat ini seorang primipara biasanya tidak dapat tegangan yang kuat ini sehingga robek pada pinggir depannya. Luka-luka biasanya ringan tetapi kadang-kadang terjadi juga luka yang luas dan berbahaya. Sebagai akibat persalinan terutama pada seorang primipara, biasa timbul luka pada vulva di sekitar introitus vagina yang biasanya tidak dalam akan tetapi kadang-kadang bisa timbul perdarahan banyak (Prawirohardjo, 2014).

Pada paritas primigravida yang belum mempunyai pengalaman persalinan dan multigravida yang memiliki riwayat rupture perineum, jika perineum tidak dilatih sedini mungkin pada saat awal kehamilan akan sangat rentan mengalami rupture perineum, dimana perineum tidak terlatih untuk elastis melakukan gerakan-gerakan yang berpengaruh pada saat bagian terbawah janin keluar.

c. Hubungan Jarak Kelahiran Dengan Kejadian Rupture Perineum

Faktor yang dianalisis secara deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang melahirkan dengan rupture perineum pada jarak kelahiran ≤ 2 tahun sebanyak 28 orang (30,4%). Responden yang melahirkan dengan rupture perineum pada jarak kelahiran ≥ 2 tahun sebanyak 64 orang (69,5%). Hasil Uji statistik Kai Kuadrat (*Chi Square*) pada $\alpha = 0,05$ didapatkan

nilai p sebesar $0,001 = (p \leq 0,05)$ yang berarti secara statistik ada pengaruh bermakna antara jarak kelahiran dengan kejadian rupture perineum.

Ibu yang mempunyai jarak kehamilan kurang dari 2 tahun rata-rata mengalami robekan jalan lahir. Robekan jalan lahir disebabkan karena ibu melahirkan terlalu cepat sehingga proses pemulihan jalan lahir belum sempurna dan robekan perineum dapat terjadi pada saat melahirkan lagi. Jarak kelahiran 2-3 tahun merupakan jarak kelahiran yang lebih aman bagi ibu dan janin. Begitu juga dengan keadaan jalan lahir yang mungkin pada persalinan terdahulu mengalami robekan perineum derajat tiga atau empat, sehingga proses pemulihan belum sempurna dan robekan perineum dapat terjadi (Nurlicha, 2019)

Jarak kehamilan merupakan rentang waktu antara kehamilan anak sekarang dengan kehamilan anak sebelumnya. Jarak kelahiran kurang dari dua tahun tergolong resiko tinggi karena dapat menimbulkan komplikasi pada persalinan. Jarak kehamilan 2 – 3 tahun merupakan jarak kehamilan yang lebih aman bagi ibu dan janin. Begitu juga dengan keadaan jalan lahir yang mungkin pada persalinan terdahulu mengalami robekan perineum derajat tiga atau empat, sehingga pemulihan belum sempurna dan robekan perineum dapat terjadi (Depkes, 2014).

Jarak kelahiran adalah rentang waktu antara kelahiran anak sekarang dengan kelahiran anak sebelumnya. Jarak kelahiran kurang dari dua tahun tergolong resiko tinggi karena dapat menimbulkan komplikasi pada persalinan (Rochmayanti, 2019)

Jarak Kelahiran sangat berpengaruh pada kejadian rupture perineum apalagi pada ibu yang selama rentang jarak tersebut mengesampingkan nutrisi, artinya bagi ibu yang nutrisi cukup masih ada kemungkinan untuk belum sempurnanya perineum pada persalinan terdahulu, apalagi bagi ibu dengan menjunjung tinggi tradisi yang bertentangan dengan kesehatan seperti melakukan pantangan makan selama 2 tahun atau selama menyusui anak sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, nutrisi mempunyai peran dalam pertahanan tubuh manusia untuk menghindari terjadinya kelainan seperti kekurangan energi, anemia, yang dapat menghambat elastisnya perineum.

d. Hubungan Partus Presipitatus Dengan Kejadian Rupture Perineum

Faktor yang dianalisis secara deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang melahirkan dengan rupture perineum pada partus tidak presipitatus sebanyak 64 orang (69,5%). Responden yang melahirkan dengan rupture perineum pada partus presipitatus sebanyak 28 orang (30,4%). Hasil Uji statistik Kai Kuadrat (*Chi Square*) pada $\alpha = 0,05$ didapatkan nilai p sebesar 0,000

= ($p \leq 0,05$) yang berarti secara statistik ada pengaruh bermakna antara partus presipitatus dengan kejadian ruptur perineum.

Ruptur perineum dapat disebabkan oleh beberapa faktor menurut Prawirohardjo, 2014 salah satunya dari faktor ibu meliputi inpartus presipitatus. Partus presipitatus adalah persalinan yang berlangsung dalam waktu yang sangat cepat, atau persalinan yang sudah selesai kurang dari 3 jam. Akibatnya dari kontraksi uterus yang kuat disertai serviks yang panjang serta kaku, dan vagina, vulva atau perineum yang tidak dapat menimbulkan ruptur uteri atau laserasi yang luas pada serviks, vagina, atau perineum (Saifuddin, 2015).

Partus presipitatus biasa disebut dengan persalinan cepat merupakan hal yang patut diwaspadai, persepsi masyarakat semakin cepat persalinan dikatakan semakin baik bahkan di wilayah kerja Puskesmas Curug masih menggunakan rumput Fatimah untuk mempercepat proses persalinan, rumput Fatimah jelas dilarang oleh medis karena dapat mengakibatkan komplikasi persalinan salah satunya adalah perdarahan dan ruptur, dimana pada saat persalinan kala 2 ibu mengerahkan semua tenaga untuk mendorong bagian bawah janin untuk keluar, secara sadar atau tidak sadar ibu lepas kontrol seperti cara mengedan yang baik, atur nafas yang baik yang berakibat terjadinya ruptur perineum.

e. Hubungan Berat Lahir Janin Dengan Kejadian Rupture Perineum

Faktor yang dianalisis secara deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang melahirkan dengan ruptur perineum pada berat lahir janin < 2500 gram sebanyak 5 orang (5,5%). Responden yang melahirkan dengan ruptur perineum pada berat lahir janin ≥ 2500 sebanyak 87 orang (94,5%). Hasil Uji statistik Kai Kuadrat (*Chi Square*) pada $\alpha = 0,05$ didapatkan nilai p sebesar 0,000 = ($p \leq 0,05$) yang berarti secara statistik ada pengaruh bermakna antara berat lahir janin dengan kejadian ruptur perineum.

Berat badan bayi baru lahir dapat mempengaruhi proses persalinan kala II semakin besar bayi yang dilahirkan akan meningkatkan resiko terjadinya ruptur perineum. Bayi besar adalah bayi yang begitu lahir memiliki bobot lebih dari 4.000 gram (Vivian, 2011)

Berat badan janin dapat mempengaruhi proses persalinan kala II. Berat neonatus pada umumnya < 4000 gr dan jarang melebihi 5000 gr. Kriteria janin cukup bulan yang lama kandungannya 40 minggu mempunyai panjang 48-50 cm dan berat badan 2750 – 3000 gram (Saifuddin, 2013)

Berat badan janin pada saat lahir jika tidak diimbangi oleh kelenturan atau elastisitas jalan lahir termasuk perineum maka dapat menyebabkan

robekan. Kelenturan didapat ibu melalui latihan fisik salah satunya dengan cara rutin melakukan senam kegel, serta latihan psikis dimana Bidan berperan dalam melatih senam kegel tersebut selain itu bidan dapat menerapkan asuhan sayang ibu sehingga ibu dapat lebih rileks dalam melakukan persalinan terutama kala II dan bidan memastikan Taksiran Berat Janin tidak lebih dari 4000 gram.

f. Hubungan Penolong Persalinan Dengan Kejadian Rupture Perineum

Faktor yang dianalisis secara deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang melahirkan dengan ruptur perineum pada penolong persalinan nakes sebanyak 54 orang (58,7%). Responden yang melahirkan dengan ruptur perineum pada penolong persalinan non nakes sebanyak 38 orang (41,3%). Hasil Uji statistik Kai Kuadrat (*Chi Square*) pada $\alpha = 0,05$ didapatkan nilai p sebesar $0,000 = (p \leq 0,05)$ yang berarti secara statistik ada pengaruh bermakna antara penolong persalinan dengan kejadian ruptur perineum.

Faktor penolong persalinan disebutkan dapat menyebabkan ruptur perineum meliputi: cara memimpin mengejan, cara berkomunikasi, keterampilan menahan perineum saat ekspulsi kepala, serta ajuran posisi meneran (JNPK-KR, 2017).

Bidan merupakan tenaga lini terdepan harus mampu dan terampil dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada ibu dan bayi baru lahir khususnya saat persalinan sesuai dengan asuhan kebidanan yang ditetapkan, mengacu kepada kewenangan dan kode etik profesi serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang terstandar. Untuk mendukung peningkatan keterampilan bidan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Kemenkes telah menyusun berbagai pedoman dan standar asuhan kebidanan sehingga dapat digunakan sebagai acuan. Seiring dengan itu pula pemerintah dan berbagai pihak di Indonesia terus mengembangkan pendidikan kebidanan yang berhubungan dengan perkembangan pelayanan kebidanan baik pendidikan formal maupun non formal (Kemenkes, 2015).

Tiga kunci dari MPS ini adalah setiap persalinan harus ditangani oleh tenaga terlatih (paramedis), karena setiap persalinan tetap ada risikonya dan jangan pergi ke Dukun. Setiap komplikasi harus ditangani sebaik mungkin, setiap wanita usia subur harus memiliki akses terhadap pelayanan kontrasepsi dan bila dihadapkan pada masalah aborsi, wanita juga harus mendapatkan pelayanan kesehatan (Kemenkes, 2015).

Di Wilayah Puskesmas Curug masih terdapat persalinan yang ditolong oleh Non Nakes, banyak upaya yang telah dilakukan oleh pihak Puskesmas Curug, Pemerintah Kecamatan, kelurahan dan kader dalam menyadarkan

warga sekitar untuk persalinan di Nakes, terdapat paraji yang telah bermitra dengan bidan desa, namun paraji senior masih saja ada yang tidak mau bermitra, paraji yang tidak mau bermitra sampai saat ini tetap tidak lepas dari pantauan kader, bidan desa dan Puskesmas Curug demi terciptanya pelayanan KIA sesuai standar pemerintah.

D. Kesimpulan

Hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian rupture perineum pada persalinan kala II (pengeluaran janin) di Puskesmas Curug Kota Serang Provinsi Banten Bulan Mei – Juli Tahun 2022. Faktor-faktor dalam pembahasan ini diantaranya hubungan umur ibu, paritas, jarak kelahiran, partus presipitatus, berat lahir janin dan penolong persalinan dengan kejadian rupture perineum. Masing-masing faktor tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai $p \leq 0,05$.

Terimakasih Kepada kepala Puskesmas Curug dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis dalam melakukan semua proses ini, selama kegiatan penulis berdampingan dengan bidan dan kader kelurahan dibawah naungan Puskesmas Curug. Terimakasih kepada keluarga besar STIKes Salsabila Serang yang selalu memberikan dukungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiyah, N., & Risnawati, I. 2016. Pengaruh Paritas Terhadap Kejadian Ruptur Perineum Pada Posisi Mengejan Antara Telentang Dan Kombinasi. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/7784?show=full>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2022.
- Asuhan Persalinan Normal: Asuhan Esensial Persalinan *Buku Acuan. Book*. 2017. Jakarta. *JNPK-KR*
- Banpos.co. 2022. AKI/AKB Banten Masih Jadi PR. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=banpos.co+AKI+AKB+PR>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2022.
- BKKBN. 2015. Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi. Cetakan Ke-5. Jakarta: Bina Pustaka Sinar Harapan
- Cunningham, F. 2012. Obstetri Williams. Jakarta. EGC
- Depkes RI. 2004. Penilaian K I dan K IV. Jakarta : Depkes RI.
- Dewi, Dina. 2013. Hubungan mobilisasi dini dengan kecepatan kesembuhan luka perineum pada ibu post partum di seluruh wilayah kerja puskesmas singosari kabupaten malang. <http://ejournal.stikesnh.ac.id/plugins/generic/pdf>. Diakses Pada tanggal 25 Desember 2022
- Dorland,. W.A.. Newman,. 2002,. Kamus Kedokteran. *Dorland*,. Alih bahasa Huriwati Hartanto, dkk., edisi 29. Jakarta. EGC
- Dr. wisniati condro, 2021. Organ reproduksi wanita : bukan hanya vagina dan Rahim, yoona.id. diakses pada 25 desember 2022
- Fatimah dan Lestari, P. 2019. Pijat Perineum (Mengurangi Ruptur Perineum). Yogyakarta. Pustaka Baru Pres
- Friedman. 2004. Keperawatan Keluarga. Jakarta : EGC
- Kemendes RI, (2015). Profil kesehatan Indonesia Tahun 2014. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta. Kementrian Kesehatan RI.
- Nurlich, 2019. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Ruptur Perineum pada Ibu Bersalin. Majalah Kesehatan Pharma Medika. Vol.11 I No.1 I Juni. e-ISSN 2655-2396.
- Prawirohardjo, S. 2014. Ilmu Kebidanan. Jakarta. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Pusdiknakes. 2012. Konsep Asuhan Kebidanan. Jakarta: JHPIEGO
- Rahma Hardiyanti, Nurul Islamy, Marzuqi Sayuti. 2022. Ruptur Perineum Grade 3A Post Trauma: Laporan Kasus (Traumatic Perineal Tears Grade 3A: A Case Report). Jurnal

Ilmu Medis Indonesia (JIMI) ISSN 2807-1697 Vol 2, No 1, 2022, 11-24.
<https://doi.org/10.35912/jimi.v2i1.742>

Rochmayanti 2019. Pijat Perenium Selama Masa Kehamilan Terhadap Kejadian Ruptur Perineum. Surabaya. Jakad media.

Saifuddin, 2013. Ilmu Kebidanan. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka

Saifudin. 2015. Buku Acuan Maternal dan Neonatal. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka

Sarnita Sadya. 2021. Jumlah Kematian Ibu di Indonesia Meningkat 59,69% pada 2021.
<https://dataindonesia.id/ragam/detail/jumlah-kematian-ibu-di-indonesia-meningkat-5969-pada-2021>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2022.

Sarwono Prawirohardjo. 2014. Ilmu Kebidanan. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

Smeltzer, S.C. & Bare, B.G. 2013. Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah. Brunner & Suddarth, edisi 8. Jakarta : EGC

Sondakh. 2013. Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir. Jakarta : Erlangga

Sulistiyawati. 2015. Buku Ajar Asuhan Kebidanan. Jakarta: EGC

Vivian. 2011. Asuhan Nenatus Bayi dan Anak Balita. Jakarta. PT Selemba Medik

Walyani ES. 2015. Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan. Pustakabarupress, Yogyakarta.

SINOPSIS
BUKU ASUHAN KEBIDANAN
FISIOLOGI DAN PSIKOLOGI PERSALINAN

Buku Asuhan Kebidanan Fisiologi dan Psikologi Persalinan merupakan suatu upaya mencegah terjadinya komplikasi persalinan pada ibu bersalin baik komplikasi yang terjadi secara fisik maupun psikologis dengan teknik promotif dan preventif serta mampu mengkaji faktor dalam persalinan dengan baik dan tepat diantaranya faktor *passanger, passage, power, position, psikologis, dan provider*, agar persalinan berjalan lancar serta diharapkan mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Jika semua tenaga kesehatan khususnya bidan dilatih agar dapat menerapkan asuhan persalinan secara tepat guna, tepat waktu, baik sebelum atau saat masalah terjadi dan segera melakukan rujukan diwaktu yang tepat. Maka para ibu dan bayi lahir akan terhidar dari ancaman kesakitan dan kematian (Yulizawati dkk, 2019). Upaya pencegahan AKI khususnya pada proses persalinan adalah dengan pelaksanaan asuhan persalinan normal (APN). Setiap bidan harus dapat melakukan pertolongan persalinan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, mulai dari pengkajian data (data subjektif dan data objektif, menegaskan diagnosis kebidanan, mengenali diagnose potensial, merencanakan dan melaksanakan perencanaan tersebut sampai dengan evaluasi selama proses persalinan. Bidan melakukan pertolongan persalinan dengan 60 langkah APN. Pada APN, terdapat lima aspek dasar atau lima benang merah yang penting dan saling terkait dalam asuhan persalinan yang diberikan (JNPK-KR, 2017). Adapun asuhan kebidanan fisiologi dan psikologi persalinan terdiri dari: 1) Konsep Dasar Persalinan, 2) Lima Benang Merah Persalinan, 3) Kebutuhan Dasar Persalinan, 4) Psikologi Masa Persalinan, 5) Pemeriksaan Fisik pada Ibu Bersalin, 6) Langkah-langkah Persalinan, 7) Tahapan Persalinan, 8) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persalinan, 9) Mekanisme Persalinan, 10) Faktor-faktor yang Mempengaruhi kejadian Rupture Perineum. Dalam memberikan pertolongan persalinan dengan melakukan 60 langkah asuhan persalinan normal, menerapkan lima benang merah serta 6 faktor persalinan baik secara fisik maupun psikologi, merupakan upaya tenaga kesehatan khususnya bidan untuk mencegah komplikasi yang menyebabkan AKI dan AKB.

Buku Asuhan Kebidanan Fisiologi dan Psikologi Persalinan merupakan suatu upaya mencegah terjadinya komplikasi persalinan pada ibu bersalin baik komplikasi yang terjadi secara fisik maupun psikologis dengan teknik promotif dan preventif serta mampu mengkaji faktor dalam persalinan dengan baik dan tepat diantaranya faktor *passanger, passage, power, position, psikologis, dan provider*, agar persalinan berjalan lancar serta diharapkan mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Jika semua tenaga kesehatan khususnya bidan dilatih agar dapat menerapkan asuhan persalinan secara tepat guna, tepat waktu, baik sebelum atau saat masalah terjadi dan segera melakukan rujukan diwaktu yang tepat. Maka para ibu dan bayi lahir akan terhindar dari ancaman kesakitan dan kematian (Yulizawati dkk, 2019). Upaya pencegahan AKI khususnya pada proses persalinan adalah dengan pelaksanaan asuhan persalinan normal (APN). Setiap bidan harus dapat melakukan pertolongan persalinan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, mulai dari pengkajian data (data subjektif dan data objektif, menegakan diagnosis kebidanan, mengenali diagnose potensial, merencanakan dan melaksanakan perencanaan tersebut sampai dengan evaluasi selama proses persalinan. Bidan melakukan pertolongan persalinan dengan 60 langkah APN. Pada APN, terdapat lima aspek dasar atau lima benang merah yang penting dan saling terkait dalam asuhan persalinan yang diberikan (JNPK-KR, 2017). Adapun asuhan kebidanan fisiologi dan psikologi persalinan terdiri dari: 1) Konsep Dasar Persalinan, 2) Lima Benang Merah Persalinan, 3) Kebutuhan Dasar Persalinan, 4) Psikologi Masa Persalinan, 5) Pemeriksaan Fisik pada Ibu Bersalin, 6) Langkah-langkah Persalinan, 7) Tahapan Persalinan, 8) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persalinan, 9) Mekanisme Persalinan, 10) Faktor-faktor yang Mempengaruhi kejadian Rupture Perineum. Dalam memberikan pertolongan persalinan dengan melakukan 60 langkah asuhan persalinan normal, menerapkan lima benang merah serta 6 faktor persalinan baik secara fisik maupun psikologi, merupakan upaya tenaga kesehatan khususnya bidan untuk mencegah komplikasi yang menyebabkan AKI dan AKB.

ISBN 978-623-88659-4-9



 **IKAPI**
IKATAN PENERBIT INDONESIA
Anggota IKAPI
No. 624/DKI/2022

Penerbit :
PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F
Jalan S. Parman Kav. 22-24
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480
Telp: (021) 29866919